

Buku Referensi
**PENTINGNYA PENCEGAHAN
STUNTING PADA ANAK**

Nurseha • Desi Rofita • Nurulicha
Novi Puspita Sari • Made Rismawan
Aemilianus Mau

Editor : Yuni Kristiani Tumani

BUKU REFERENSI PENTINGNYA PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

Desi Rofita, S.ST.,M.Keb.

Nurulicha, S.ST.,M.Keb

Novi Puspita Sari S.Gz., M.Kes

Ns. Made Rismawan, S.Kep., MNS.

Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep

Editor : Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb



BUKU REFERENSI

PENTINGNYA PENCEGAHAN STUNTING PADA ANAK

Penulis: Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

Desi Rofita, S.ST., M.Keb.

Nurulicha, S.ST., M.Keb

Novi Puspita Sari S.Gz., M.Kes

Ns. Made Rismawan, S.Kep., MNS.

Dr. Aemilianus Mau., S.Kep., Ns., M.Kep

Editor: Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9348-6

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga buku referensi berjudul "**Pentingnya Pencegahan Stunting pada Anak**" ini dapat kami selesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab kami terhadap isu stunting yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang ditandai dengan kegagalan pertumbuhan fisik anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dampak stunting tidak hanya sebatas gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif yang buruk, rentan terhadap penyakit, serta penurunan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan sejak dini sangatlah krusial.

Dalam buku ini, kami menguraikan secara sistematis berbagai faktor penyebab stunting, mulai dari kondisi gizi ibu selama kehamilan, praktik pengasuhan anak, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga. Pembahasan yang komprehensif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada berbagai kalangan, termasuk tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, serta orang tua yang berperan penting dalam upaya pencegahan stunting.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kontributor, para pakar, dan praktisi kesehatan yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Masukan dan kritik konstruktif sangat kami nantikan untuk penyempurnaan edisi selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi acuan dan panduan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia melalui pencegahan stunting secara efektif dan berkelanjutan.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PERAN BIDAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH STUNTING SEJAK MASA KEHAMILAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Stunting: Definisi, Penyebab, dan Dampaknya.....	2
C. Peran Bidan dalam Kesehatan Ibu Hamil	3
D. Pemantauan Gizi Ibu Hamil dan Dampaknya pada Pertumbuhan Janin	4
E. Mendeteksi Risiko Stunting Sejak Kehamilan	5
F. Menangani Komplikasi Kehamilan yang Dapat Menyebabkan Stunting	7
G. Peran Bidan dalam Mempromosikan ASI Eksklusif	8
H. Tantangan dan Solusi dalam Pencegahan Stunting oleh Bidan	10
Referensi.....	12
BAB II PENGARUH POLA ASUH KELUARGA TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Dasar Pola Asuh Keluarga Dan Pertumbuhan Anak.....	16
C. Pengaruh Pola Asuh Keluarga Terhadap Berbagai Aspek Pertumbuhan Anak	17
1. Pengaruh Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Fisik Anak.....	17
2. Pengaruh Pola Asuh Terhadap Perkembangan Psikologis Anak	18
D. Jenis – Jenis Pola Asuh Pada Anak.....	19
1. Pola Asuh Otoriter (Authoritarian Parenting).....	19
2. Pola Asuh Demokratis (Authoritative Parenting).....	19
3. Pola Asuh Permisif (Permissive Parenting)	20
4. Pola Asuh Tidak Terlibat (Neglectful/Uninvolved Parenting).....	20
E. Strategi Menerapkan Pola Asuh Yang Mendukung Pertumbuhan Anak	20
1. Membangun Komunikasi yang Efektif	20
2. Menetapkan Aturan dan Batasan yang Konsisten	21
3. Memberikan Kasih Sayang dan Dukungan Emosional	21
4. Mendorong Kemandirian dan Tanggung Jawab	21
5. Menyediakan Lingkungan yang Mendukung Pertumbuhan.....	21
6. Menjadi Teladan yang Baik.....	21
7. Mendukung Interaksi Sosial Anak.....	21
8. Membatasi Penggunaan Teknologi.....	21
F. Tantangan Dalam Penerapan Pola Asuh di Era Digital.....	21
1. Paparan Berlebihan terhadap Layar	22
2. Informasi yang Tidak Tersaring	22
3. Kurangnya Interaksi Sosial	22
4. Dampak pada Kesehatan Mental	22
5. Ketidakseimbangan Antara Teknologi dan Aktivitas Fisik.....	22
G. Dampak Pola Asuh Pada Kesehatan Anak	22
1. Kesehatan Fisik	22
2. Kesehatan Mental.....	23
3. Perkembangan Sosial.....	23
H. Strategi dalam Pola Asuh Keluarga Terhadap Pertumbuhan Anak.....	23
1. Menerapkan Pola Asuh Demokratis	23
2. Menciptakan Lingkungan Rumah yang Aman dan Nyaman	23

3.	Memberikan Disiplin Positif.....	24
4.	Menjadi Teladan yang Baik	24
5.	Memberikan Dukungan Emosional	24
6.	Melibatkan Ayah dalam Pengasuhan	24
7.	Menjaga Konsistensi dalam Pengasuhan.....	24
8.	Mengajarkan Kemandirian	24
9.	Menghindari Pola Asuh Otoriter dan Permisif	24
I.	Penutup	25
	Referensi	26
	BAB III INTERVENSI NUTRISI UNTUK MENCEGAH STUNTING PADA BALITA.....	29
A.	Pendahuluan.....	29
B.	Definisi Stunting	29
C.	Penyebab Stunting.....	30
D.	Dampak Stunting	31
E.	Pencegahan dan Penanganan Stunting	32
F.	Peranan Nutrisi dalam Mencegah Stunting pada Balita	34
G.	Intervensi Gizi Sensitif dan Spesifik dalam Pencegahan Stunting	38
H.	Penutup	39
	Referensi	40
	BAB IV DUKUNGAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG ANAK	46
A.	Pendahuluan.....	46
B.	Pertumbuhan dan Perkembangan Anak.....	47
C.	Pola Pengasuhan Anak.....	50
D.	Implementasi Deteksi dan Intervensi Dini Pertumbuhan Anak.....	54
E.	Implementasi Deteksi dan Intervensi Dini Perkembangan Anak.....	57
F.	Peran Tenaga Keperawatan dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	60
G.	Simpulan.....	63
	Referensi	65
	BAB V PENANGANAN MEDIS PADA ANAK DENGAN KONDISI STUNTING.....	67
A.	Pendahuluan.....	67
B.	Pengertian Stunting.....	68
C.	Diagnosis Stunting	69
1.	Pengukuran Antropometri.....	69
2.	Penilaian Kecepatan Tumbuh	69
3.	Evaluasi Proporsi Tubuh.....	70
4.	Perkiraan Potensi Tinggi Genetik.....	70
5.	Alur Diagnostik Stunting	70
D.	Faktor Penyebab Stunting.....	70
1.	Pemberian ASI Eksklusif.....	71
2.	Pemberian MP-ASI yang Tidak Tepat.....	71
3.	Infeksi Berulang	71
4.	Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	71
5.	Kondisi Sanitasi yang Buruk	71
6.	Status Sosial Ekonomi Keluarga	71
7.	Tingkat Pendidikan Ibu	72
E.	Pencegahan Stunting.....	72
F.	Intervensi Medik Anak Stunting	73
1.	Masa Emas Pertumbuhan (Golden Period)	73
2.	Peran Kunci Ibu dan Pengasuh	74
3.	Perlindungan dari Lingkungan yang Buruk	74

4. Stimulasi Perkembangan Anak	74
G. Tatalaksana Stunting di Faskes Sekunder	74
H. Penutup	76
Referensi	77
BAB VI STRATEGI KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG STUNTING	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Konsep Stunting.....	85
1. Pengertian Stunting dan Faktor Penyebabnya	85
2. Faktor penyebab stunting.....	85
3. Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Stunting	86
4. Status Stunting di Indonesia dan Global.....	88
5. Kebijakan Pemerintah dan Program Nasional Terkait Stunting	88
C. Peran Komunitas dalam Penganggulan Stunting	89
1. Definisi Komunitas dan Jenis-jenisnya dalam Konteks Kesehatan	89
2. Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Stunting.....	91
3. Model Keterlibatan Komunitas dalam Program Pencegahan Stunting	92
4. Studi Kasus Keberhasilan Komunitas dalam Mengatasi Stunting.....	92
D. Strategi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Stunting	93
1. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Stunting di Masyarakat	93
2. Program Gizi Berbasis Komunitas	93
3. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif.....	94
4. Pemanfaatan Media Sosial dan Digital untuk Edukasi Stunting	94
5. Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat dalam Penyebaran Informasi.....	95
E. Implementasi Program Komunitas di Berbagai Daerah.....	95
1. Studi Kasus: Program Komunitas di Daerah Perkotaan	95
2. Studi Kasus: Program Komunitas di Daerah Pedesaan	96
3. Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Donor	97
4. Evaluasi Keberhasilan Program dan Tantangan yang Dihadapi	99
F. Keberlanjutan dan Pengembangan Program Komunitas.....	100
1. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	100
2. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan bagi Anggota Komunitas.....	101
3. Sinergi antara Komunitas, Pemerintah, dan Sektor Swasta.....	102
4. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Peran Komunitas dalam Penanggulan Stunting	102
G. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	104
1. Ringkasan Temuan dan Pelajaran dari Berbagai Program Komunitas	104
2. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesadaran Stunting melalui Komunitas	105
3. Saran untuk Penelitian dan Implementasi Selanjutnya	105
H. Penutup	106
Referensi	107
Profil Penulis	114

BAB I

PERAN BIDAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH STUNTING SEJAK MASA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan gizi yang tepat selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan. Stunting tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada balita Indonesia (12-23 bulan) adalah 40,4%. Inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif didapatkan pada 42,7% dan 19,7% bayi. Pemberian MPASI dini ditemukan pada 68,5% bayi. Analisis multivariat menunjukkan bayi yang lahir dengan BBLR sebanyak 1,74 kali lebih mungkin mengalami stunting daripada bayi yang lahir dengan berat badan normal. Anak laki-laki 1,27 kali lebih mungkin mengalami stunting daripada anak perempuan. Bayi dengan riwayat penyakit neonatal, sebesar 1,23 kali lebih rentan terhadap stunting. Kemiskinan adalah variabel tidak langsung lain yang secara signifikan terkait dengan stunting. Penelitian ini menunjukkan bahwa BBLR, jenis kelamin (anak laki-laki), Riwayat penyakit neonatal dan kemiskinan adalah faktor yang terkait dengan stunting di antara anak-anak yang berusia 12-23 bulan di Indonesia, dengan BBLR menjadi penentu utama stunting (Aryastami et al., 2017)

Pencegahan stunting tidak hanya dimulai setelah bayi lahir, namun sudah dapat dimulai sejak masa kehamilan. Dalam hal ini, bidan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan perhatian medis yang tepat, pemantauan gizi yang memadai, serta edukasi tentang pentingnya perawatan kehamilan yang optimal.

Pencegahan stunting sejak masa kehamilan juga mencakup pemantauan pertumbuhan janin secara rutin, serta deteksi dini terhadap masalah kesehatan yang dapat memengaruhi perkembangan janin, seperti hipertensi atau diabetes gestasional. Bidan juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif dan pola makan yang baik pasca kelahiran untuk mendukung perkembangan anak di tahap awal kehidupan.

Dampak stunting tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik anak, tetapi meluas pada kesehatan mental, pendidikan, dan masa depan ekonomi anak serta bangsa. Stunting yang tidak ditangani dengan baik berpotensi menciptakan generasi yang lemah secara fisik, kognitif, dan produktif. Oleh karena itu, pencegahan stunting sejak masa kehamilan dan awal kehidupan anak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal, demi masa depan yang lebih baik bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil dan calon bayi, memiliki kesempatan besar untuk mendeteksi faktor risiko yang dapat menyebabkan stunting pada anak, seperti kekurangan gizi ibu, anemia, atau infeksi yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan konseling kepada ibu hamil mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang, serta pemahaman tentang pola makan yang sehat selama kehamilan.

Dengan adanya peran yang sangat strategis ini, bidan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting, bukan hanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, tetapi juga dalam memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak.

B. Stunting: Definisi, Penyebab, dan Dampaknya

Definis Stunting:

Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki Panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi stunting jika lebih dari minus dua standar deviasi median. Balita stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu lama (kronik) (Trihono, et al, 2015)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia, menunjukkan gangguan pertumbuhan linear. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang adekuat selama periode 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu dari konsepsi hingga anak berusia dua tahun (Nirmalasari, 2020)

Penyebab Stunting:

1. Asupan Gizi yang Tidak Memadai: Kekurangan nutrisi penting selama masa kehamilan dan periode pertumbuhan anak dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif.
2. Praktik Pemberian Makanan yang Tidak Tepat: Kurangnya pengetahuan mengenai pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang sesuai dapat menyebabkan defisiensi nutrisi pada anak.
3. Kesehatan Ibu yang Buruk: Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, seperti anemia atau kurangnya perawatan antenatal, dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.
4. Sanitasi dan Akses ke Air Bersih yang Terbatas: Kondisi sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses terhadap air bersih meningkatkan risiko infeksi yang dapat menghambat pertumbuhan anak.
5. Faktor Sosial Ekonomi: Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap makanan bergizi, layanan

kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya berkontribusi terhadap risiko stunting (Nirmalasari, 2020)

Stunting disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi, bukan hanya karena faktor asupan gizi yang buruk pada ibu hamil atau balita saja. Di Indonesia, telah banyak dilakukan penelitian mengenai faktor risiko stunting. Risiko stunting dapat dimulai sejak masa konsepsi, yaitu dari faktor ibu. Ibu yang kurang memiliki pengetahuan mengenai kesehatan dan gizi sejak hamil sampai melahirkan berperan besar menimbulkan stunting pada anak yang dilahirkannya. Pada saat hamil, layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu setelah melahirkan), dan pembelajaran dini yang berkualitas juga sangat penting. Hal ini terkait dengan konsumsi suplemen zat besi yang memadai saat hamil, pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang optimal (World Health Organization, 2019)

Dampak Stunting:

- Dampak Jangka Pendek: Anak dengan stunting memiliki risiko lebih tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas, serta penurunan kemampuan belajar akibat gangguan perkembangan kognitif.
- Dampak Jangka Panjang: Stunting dapat mengurangi produktivitas ekonomi individu dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di kemudian hari (Nirmalasari, 2020).

C. Peran Bidan dalam Kesehatan Ibu Hamil

Bidan memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan ibu hamil melalui penyediaan asuhan kebidanan yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah. Asuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemantauan kesehatan ibu dan janin hingga deteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan.

Peran Bidan dalam Kesehatan Ibu Hamil:

1. Pemantauan Kesehatan Ibu dan Janin:
 - a) Melakukan kunjungan antenatal secara rutin untuk memantau perkembangan kehamilan, memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi (Yanti, Juli S, 2021)
 - b) Melakukan pengkajian status gizi ibu hamil dan memberikan edukasi mengenai pola makan sehat serta suplementasi zat besi untuk mencegah anemia (Paramitha Amelia, 2020).
2. Deteksi dan Penanganan Komplikasi:
 - a) Mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi seperti preeklamsia, diabetes gestasional, atau infeksi, serta mengambil langkah intervensi yang sesuai (Sukmawati et al., 2023)
 - b) Bekerja sama dengan tenaga medis lain dalam penanganan kasus komplikasi yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

3. Edukasi dan Konseling:
 - a) Memberikan informasi kepada ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan, pentingnya imunisasi, serta persiapan persalinan dan perawatan nifas.
 - b) Menyediakan dukungan emosional dan psikologis untuk membantu ibu hamil mengatasi stres atau kecemasan yang mungkin timbul selama kehamilan.
4. Promosi Kesehatan dan Pencegahan:
 - a) Mengadakan program promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perawatan antenatal dan kesehatan ibu hamil (Sukmawati et al., 2023)
 - b) Mengimplementasikan praktik berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan dan memastikan pelayanan yang aman serta efektif bagi ibu dan bayi (Siti Tyastuti, 2015)

D. Pemantauan Gizi Ibu Hamil dan Dampaknya pada Pertumbuhan Janin

Pemantauan status gizi ibu hamil merupakan aspek krusial dalam memastikan kesehatan ibu dan perkembangan optimal janin. Asupan nutrisi yang adekuat selama kehamilan tidak hanya mendukung kesehatan ibu tetapi juga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin (Nasriyah & Ediyono, 2023)

Selama masa kehamilan, kebutuhan nutrisi meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin dan perubahan fisiologis pada ibu. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan komplikasi seperti anemia, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah (BBLR). Pemantauan rutin status gizi ibu hamil, termasuk pengukuran antropometri dan kadar hemoglobin, membantu mengidentifikasi risiko dan mencegah dampak negatif pada janin (Maharani et al., 2022).

Dampak Kekurangan Nutrisi pada Pertumbuhan Janin dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan energi, protein, zat besi, dan asam folat selama kehamilan dapat mengganggu pertumbuhan janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur, BBLR, dan stunting pada anak. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil dengan status gizi kurang memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan BBLR, yang berpotensi mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan (Pradani & Indarti, 2022). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prihatini et al (2021) yang menyatakan bahwa ibu hamil dengan kekurangan energi kronis pada trimester pertama memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Prihatini et al., 2021). Hal ini menekankan pentingnya pemantauan dan intervensi gizi sejak awal kehamilan untuk mencegah BBLR. Penelitian lain juga membahas terkait dengan efek pemberian makanan tambahan berprotein pada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Hasilnya menunjukkan bahwa suplementasi protein dapat meningkatkan pertumbuhan janin, mengurangi risiko BBLR, dan mendukung perkembangan janin yang optimal (Prameswari et al., 2020)

E. Mendeteksi Risiko Stunting Sejak Kehamilan

Deteksi dini risiko stunting sejak kehamilan adalah langkah penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Stunting, atau kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini, bahkan selama kehamilan, untuk mengurangi prevalensinya di masa depan. (Oktaviana et al., 2020). Faktor risiko stunting yang dapat dideteksi sejak kehamilan melibatkan beberapa aspek kesehatan ibu, pola makan, serta faktor lingkungan dan sosial. Berikut adalah beberapa faktor risiko stunting yang dapat dideteksi sejak kehamilan:

1. Status Gizi Ibu Hamil

- a) Indeks Massa Tubuh (IMT): IMT yang terlalu rendah ($<18,5$) atau terlalu tinggi (>25) pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko malnutrisi pada janin, yang dapat berkontribusi pada stunting pada anak setelah lahir.
- b) Anemia pada Ibu Hamil: Ibu hamil dengan anemia (kadar hemoglobin <11 g/dL) berisiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan faktor risiko utama stunting.
- c) Kekurangan Mikronutrien: Kekurangan mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, yodium, dan asam folat pada ibu hamil dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, meningkatkan risiko stunting.
- d) Tinggi Badan Ibu: Ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 145 cm memiliki risiko lebih besar melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan risiko stunting lebih tinggi (Desni Sagita & Kusuma Wardani, 2022)(Prihatini et al., 2021)

2. Kehamilan yang Tidak Direncanakan

Kehamilan yang tidak direncanakan atau terlalu dini (di bawah usia 18 tahun) dapat meningkatkan risiko kekurangan gizi pada ibu, yang berdampak pada pertumbuhan janin. Kehamilan yang terlalu dekat dengan kelahiran sebelumnya (jarak antar kehamilan kurang dari dua tahun) juga berisiko meningkatkan stunting pada bayi (Pusmaika et al., 2022)

3. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, seperti pemeriksaan rutin kehamilan (ANC), pengawasan pertumbuhan janin, dan pemberian suplementasi gizi (misalnya asam folat dan zat besi), memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan kekurangan gizi. Akses yang buruk terhadap layanan kesehatan juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi potensi masalah kesehatan pada ibu dan janin (Runjati, 2018) (Ika Hariani, 2024)

4. Pola Makan Ibu Hamil

- a) Pola makan yang tidak seimbang atau kurangnya konsumsi makanan bergizi pada ibu hamil dapat menghambat perkembangan janin. Diet yang tidak

- mencukupi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien selama kehamilan sangat berisiko terhadap kesehatan ibu dan janin, serta dapat menyebabkan stunting pada anak.
- b) Makanan Bergizi Kurang: Konsumsi makanan yang kurang variatif dan tidak mengandung cukup protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral dapat berkontribusi pada malnutrisi ibu dan bayi.
 - c) Kekurangan Zat Besi dan Asam Folat: Kekurangan kedua zat ini pada ibu hamil berhubungan langsung dengan peningkatan risiko stunting pada anak (Prihatini et al., 2021)
5. Kesehatan Lingkungan dan Sosial
- a) Pengaruh Ekonomi: Keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan, yang dapat meningkatkan risiko stunting pada anak (Garina et al., 2024)
 - b) Paparan Lingkungan yang Buruk: Pola hidup tidak sehat, paparan terhadap lingkungan yang tidak bersih (misalnya sanitasi buruk), serta risiko infeksi pada ibu hamil dapat memengaruhi kesehatan ibu dan bayi (Vilcins et al., 2018)
 - c) Stres Psikologis Ibu: Stres berat atau kekerasan yang dialami ibu selama kehamilan juga dapat berdampak pada kesehatan janin, yang bisa meningkatkan risiko stunting (Sutrisna et al., 2024) (Ardianti et al., 2020)
6. Usia Ibu yang Tidak Ideal
- a) Usia Ibu yang Terlalu Muda: Ibu yang hamil di usia di bawah 18 tahun berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah dan masalah gizi yang berdampak pada risiko stunting.
 - b) Usia Ibu yang Terlalu Tua: Ibu hamil di atas usia 35 tahun juga berisiko mengalami komplikasi kesehatan yang bisa berpengaruh pada perkembangan janin, seperti preeklampsia atau diabetes gestasional (Pusmaika et al., 2022)
7. Kehamilan dengan Komplikasi
- a) Preeklampsia: Kehamilan dengan hipertensi atau preeklampsia dapat memengaruhi aliran darah ke janin, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi, sehingga menyebabkan berat badan bayi lahir rendah (BBLR) yang berisiko pada stunting (Lia idealistiana & Siti Fauziah, 2019)
 - b) Infeksi atau Penyakit Lain : Anak balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi (ISPA tau diare kronik) memiliki risiko 6,61 kali untuk mengalami stunting dibandingkan anak balita yang tidak memiliki Riwayat penyakit infeksi (ISPA dan diare kronik) (Dewi & Adhi, 2014). iwayat penyakit infeksi memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting pada balita usia 24-36 bulan (Yulnefia & Sutia, 2022)
8. Status ASI Eksklusif dan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI)
- Walaupun ini terjadi setelah kelahiran, penting juga untuk mencatat bahwa deteksi dini terhadap pola pemberian ASI yang tidak adekuat dan keterlambatan

pemberian MPASI bisa berawal dari pola makan ibu hamil yang tidak sehat (Lukito Diewindya Aulia & Aryanti Setyaningsih, 2023)

F. Menangani Komplikasi Kehamilan yang Dapat Menyebabkan Stunting

Menangani komplikasi kehamilan yang dapat menyebabkan stunting adalah langkah penting dalam upaya pencegahan stunting pada anak. Komplikasi kehamilan yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan risiko gangguan gizi pada bayi yang dapat berlanjut hingga usia anak. Berikut adalah beberapa komplikasi kehamilan yang dapat berkontribusi pada risiko stunting dan cara penanganannya:

1. Preeklampsia

Preeklampsia adalah kondisi yang ditandai dengan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan adanya protein dalam urine pada ibu hamil. Komplikasi ini dapat mempengaruhi aliran darah ke plasenta, yang berdampak pada asupan oksigen dan nutrisi ke janin. Bayi yang lahir dari ibu dengan preeklampsia cenderung lebih kecil dari ukuran normal dan berisiko mengalami stunting.

Penanganan:

- a) Pemantauan Tekanan Darah: Ibu hamil dengan riwayat tekanan darah tinggi harus dipantau secara rutin untuk mendeteksi tanda-tanda preeklampsia.
- b) Pemberian Obat-obatan: Obat antihipertensi seperti methyldopa atau nifedipine dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah ibu.
- c) Kelahiran Dini: Pada kasus preeklampsia berat, kelahiran prematur mungkin perlu dilakukan untuk menyelamatkan ibu dan bayi, meskipun ini bisa meningkatkan risiko stunting pada bayi yang lahir prematur.
- d) Asupan Gizi yang Tepat: Makanan bergizi yang cukup dan kaya antioksidan seperti vitamin C dan E dapat membantu mengurangi dampak preeklampsia. (POGI, 2016)

2. Diabetes Gestasional

Diabetes gestasional adalah diabetes yang berkembang selama kehamilan dan dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang lebih tinggi dari normal. Meskipun bayi ini tampak besar saat lahir, mereka berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan di kemudian hari, termasuk stunting, terutama jika ibu tidak mengelola kadar gula darah dengan baik.

Penanganan:

- a) Kontrol Gula Darah: Pemantauan gula darah secara teratur dan penyesuaian pola makan yang sehat, serta penggunaan insulin jika diperlukan, dapat membantu ibu mengelola diabetes gestasional.
- b) Diet Sehat: Mengonsumsi makanan yang rendah gula dan karbohidrat tinggi serat sangat penting untuk menjaga kestabilan gula darah ibu hamil.
- c) Pemantauan Pertumbuhan Janin: USG rutin dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan janin agar mencegah bayi terlalu besar atau kecil saat lahir. (Bagus et al., 2023)

Beberapa kebijakan dan program dari bukti yang tersedia hingga saat ini. Pertama, karena sebagian besar kasus stunting terjadi sebelum kelahiran, intervensi gizi harus mencakup dari kehamilan sampai periode pascanatal. Kedua, intervensi gizi cenderung memiliki dampak yang lebih besar pada pertumbuhan jika dilakukan sebagai bagian dari paket intervensi yang mengatasi berbagai penyebab stunting. Ini berarti bahwa perhatian harus diberikan pada pencegahan dan pengendalian infeksi prenatal dan pascanatal dan kondisi subklinis yang menghambat pertumbuhan, perawatan untuk wanita dan anak-anak, dan stimulasi perkembangan anak usia dini (Dewey, 2016)

G. Peran Bidan dalam Mempromosikan ASI Eksklusif

Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mempromosikan pemberian ASI eksklusif pada ibu dan bayi. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya, selain ASI itu sendiri, sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan. ASI eksklusif memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi, termasuk memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi, mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serta memberikan perlindungan terhadap infeksi.

Berikut adalah peran bidan dalam mendukung dan mempromosikan pemberian ASI eksklusif:

1. Edukasi dan Konseling kepada Ibu Hamil

Bidan memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif sejak kehamilan. Melalui konseling antenatal, bidan dapat menginformasikan manfaat ASI, seperti meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi serta memberikan gizi yang optimal untuk pertumbuhan bayi.

- a) Informasi tentang Manfaat ASI: Bidan dapat menjelaskan manfaat ASI bagi bayi, seperti mengandung antibodi yang melindungi bayi dari penyakit, serta membantu perkembangan otak dan sistem pencernaan yang lebih baik.
- b) Edukasi tentang Laktasi: Bidan memberikan pengetahuan mengenai proses laktasi, serta pentingnya teknik menyusui yang benar agar ibu tidak mengalami masalah seperti nyeri payudara atau puting lecet.

(Alfiyani, 2023) (Sudarmi, 2024)

2. Membantu Ibu Menyiapkan Diri untuk Menyusui

Sebelum dan setelah melahirkan, bidan memiliki peran dalam membantu ibu mempersiapkan diri untuk menyusui dengan baik. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui kelas laktasi atau sesi satu-satu.

- a) Teknik Menyusui yang Tepat: Bidan mengajarkan posisi menyusui yang benar agar bayi dapat mengisap dengan baik, yang akan membantu kelancaran produksi ASI
- b) Pemecahan Masalah Menyusui: Bidan memberikan solusi untuk masalah-masalah umum yang mungkin timbul, seperti ASI yang sedikit, puting lecet, atau bayi yang tidak mau menyusui.

3. Dukungan dan Motivasi Pasca Persalinan

Setelah melahirkan, bidan memiliki peran penting dalam mendukung ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif. Dukungan pasca persalinan dapat mencakup memberikan informasi tentang tanda-tanda keberhasilan menyusui dan memberikan dorongan untuk mempertahankan pemberian ASI eksklusif.

- a) Memastikan Proses Menyusui yang Lancar: Bidan memantau keberhasilan ibu dalam menyusui, membantu mengatasi masalah laktasi, dan memastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup.
- b) Pemberian Dukungan Psikologis: Selain masalah teknis, banyak ibu baru yang menghadapi tantangan emosional setelah melahirkan. Bidan memberikan dukungan emosional agar ibu merasa lebih percaya diri dalam menyusui.

(Wita Solama, 2021)

4. Pencegahan Pemberian Susu Formula

Salah satu tantangan dalam mempromosikan ASI eksklusif adalah kecenderungan untuk memberikan susu formula pada bayi. Bidan berperan dalam mencegah hal ini dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai manfaat ASI dibandingkan dengan susu formula, serta potensi risiko yang terkait dengan pemberian susu formula di luar indikasi medis.

- a) Penyuluhan tentang Dampak Negatif Susu Formula: Bidan memberikan penjelasan tentang potensi risiko seperti infeksi, alergi, dan masalah pencernaan yang dapat timbul akibat penggunaan susu formula.
- b) Informasi tentang Risiko Gizi Buruk: Penggunaan susu formula yang tidak tepat juga dapat menyebabkan masalah gizi buruk, termasuk stunting pada bayi. Bidan memastikan ibu memahami risiko ini.

(Kwartawaty et al., 2023)

5. Advokasi dan Kerja Sama dengan Tenaga Kesehatan Lain

Bidan juga dapat berperan sebagai advokat untuk ASI eksklusif, baik dalam keluarga maupun di komunitas. Bidan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter anak dan ahli gizi, untuk memastikan ibu mendapat dukungan penuh.

- a) Bekerja Sama dengan Rumah Sakit dan Klinik: Bidan berkolaborasi dengan rumah sakit dan pusat kesehatan untuk memastikan rumah sakit atau klinik menyediakan fasilitas yang mendukung pemberian ASI, seperti ruang menyusui yang nyaman dan pribadi.
- b) Penguatan Program ASI Eksklusif di Komunitas: Bidan dapat terlibat dalam program-program pendidikan masyarakat untuk mengedukasi keluarga dan masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif.

6. Pemantauan dan Evaluasi Status Laktasi

Bidan memantau dan mengevaluasi status laktasi ibu setelah melahirkan, memastikan ASI lancar, dan memberikan intervensi jika diperlukan. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan berat badan bayi dan cek apakah bayi mendapatkan ASI cukup melalui frekuensi menyusui dan tanda-tanda bayi yang sehat.

- a) Monitoring Produksi ASI: Bidan memeriksa apakah ibu mengalami masalah dalam produksi ASI dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, seperti teknik pemompaan yang benar atau pengaturan pola makan ibu
 - b) Pengawasan terhadap Kebutuhan Bayi: Memastikan bayi mendapatkan ASI secara cukup, baik dari segi frekuensi menyusui maupun volume, serta memastikan bayi tumbuh dan berkembang dengan baik.
7. Pendidikan untuk Keluarga
- Selain berfokus pada ibu, bidan juga dapat memberikan pendidikan kepada anggota keluarga lainnya, terutama suami, yang berperan penting dalam memberikan dukungan moral dan fisik kepada ibu menyusui. Keluarga yang mendukung ibu dalam proses menyusui dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Menyadarkan Peran Keluarga: Bidan mengedukasi keluarga tentang pentingnya dukungan terhadap ibu untuk menyusui, serta menjelaskan manfaat jangka panjang bagi kesehatan bayi.
8. Pemberian ASI pada Situasi Khusus
- Dalam beberapa situasi khusus, seperti pada ibu dengan masalah medis atau ibu yang kembali bekerja, bidan juga berperan dalam memberikan alternatif solusi agar pemberian ASI eksklusif tetap berjalan.
- a) ASI Perah: Bidan mengajarkan ibu cara memerah ASI dengan benar dan menyimpannya untuk diberikan saat ibu tidak dapat menyusui langsung.
 - b) Penyusunan Rencana Laktasi: Bagi ibu yang bekerja, bidan membantu merencanakan pengaturan waktu dan cara pemberian ASI perah di tempat kerja.

Manfaat ASI eksklusif:

- 1. Memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi
 - 2. ASI memiliki zat antibodi yang berperan dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit dalam tubuh bayi
 - 3. Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan kematian balita
- (Septikasari, 2018)

H. Tantangan dan Solusi dalam Pencegahan Stunting oleh Bidan

- a) Tantangan : perubahan pola pikir,
Solusi yang dapat dilakukan bidan adalah edukasi, motivasi, dan fasilitasi.
- b) Tantangan pencegahan stunting Pola pikir masyarakat yang belum berubah, Kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Status ekonomi masyarakat yang rendah
Solusi pencegahan stunting oleh bidan :
 - 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi sejak masa kehamilan
 - 2) Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memeriksakan kesehatan anak secara berkala

- 3) Memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil dan menyusui
- 4) Memantau perkembangan anak dan membawa anak ke posyandu secara berkala
- 5) Memberikan konseling kepada ibu hamil untuk mengatasi gejala emosi dan psikologis
- 6) Membantu ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil untuk mendapatkan perawatan kehamilan

Referensi

- Alfiyani, R. (2023). penerapan pendidikan kesehatan tentang asi eksklusif untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil Trimester III Di Wilayah Kerja Puskesmas Yosomulyo Kota Metro Tahun 2022. *Jurnal Cendikia Muda*, 3(3), 457–465.
- Ardianti, E., Pertiwi, S., & Rohmatin, E. (2020). The Effect of Prenatal Massage Towards Anxiety Level of Third Trimester Pregnant Women in The Work Area Of Cibeureum Public Health Center Tasikmalaya 2019. *Midwifery and Nursing Research*, 2(1), 28–30. <https://doi.org/10.31983/manr.v2i1.5607>
- Aryastami, N. K., Shankar, A., Kusumawardani, N., Besral, B., Jahari, A. B., & Achadi, E. (2017). Low birth weight was the most dominant predictor associated with stunting among children aged 12-23 months in Indonesia. *BMC Nutrition*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s40795-017-0130-x>
- Bagus, I., Nugraha, A., Gotera, W., & Gousario, S. F. (2023). Manajemen Diabetes Melitus Dalam Kehamilan. *Jurnal Medika Utama*, 4(4), 2023.
- Desni Sagita, Y., & Kusuma Wardani, P. (2022). Status Gizi Dan Usia Ibu Saat Hamil Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 1-5 Tahun. *Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)*, 3(2), 115–122. <https://doi.org/10.30604/jaman.v3i2.485>
- Dewey, K. G. (2016). Reducing stunting by improving maternal, infant and young child nutrition in regions such as South Asia: Evidence, challenges and opportunities. *Maternal and Child Nutrition*, 12, 27–38. <https://doi.org/10.1111/mcn.12282>
- Dewi, I. A., & Adhi, K. T. (2014). Pengaruh Konsumsi Protein Dan Seng Serta Riwayat Penyakit Infeksi Terhadap Kejadian Pendek Pada Anak Balita Umur 24-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Nusa Penida Iii. *Gizi Indonesia*, 37(2), 36–46. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v37i2.161>
- Garina, L. A., Dewi, M. K., Muflilah, H., Tursina, A., & Respati, T. (2024). *Maternal , Child , and Household Risk Factors for Children with Stunting*. 1–11. <https://doi.org/10.2174/0118749445321448240823112908>
- Ika Hariani, et al. (2024). Analisis Hubungan Aksesibilitas Dengan Pelaksanaan Anc Terpadu. *Jurnal Ilmia Ilmu Kesehatan*, 2(4), 693–697.
- Kwartawaty, N. N., W, S. T., & Sari, D. V. (2023). Literasi Pencegahan Stunting dan Efek Pemberian Susu Formula pada Balita Stunting di Kelurahan Tawangmas. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(11), 4655–4668. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i11.12390>
- Lia idealistiana, & Siti Fauziah. (2019). Hubungan Preeklampsia dan Faktor Lain Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Antara Kebidanan*, 1(3), 147–156. <https://doi.org/10.37063/ak.v1i3.19>

- Lukito Diewindya Aulia, & Aryanti Setyaningsih. (2023). Hubungan Pemberian Asi Eksklusif Dan Ketepatan Pemberian Mp-Asi Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Usia 6-23 Bulan Di Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. *Jurnal Gizi Dan Dietetik*, 2(2), 93–97. <https://doi.org/10.34011/jgd.v2i2.1804>
- Maharani, T. P., Budhisantosa, N., Studi, P., Informatika, T., Unggul, U. E., Barat, J., & Utara, J. (2022). *NutriCare : Aplikasi Pemantau Gizi Ibu Hamil untuk Menghindari Stunting dengan Memenuhi Kebutuhan Kalori dan Zat Besi*. 9(1), 62–69.
- Nasriyah, N., & Ediyono, S. (2023). Dampak Kurangnya Nutrisi Pada Ibu Hamil Terhadap Risiko Stunting Pada Bayi Yang Dilahirkan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 14(1), 161–170. <https://doi.org/10.26751/jikk.v14i1.1627>
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(1), 19–28. <https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>
- Oktaviana, F., Widyawati, M. N., Kurnianingsih, K., & Kubota, N. (2020). Early Detection of the Risk of Stunting in Pregnant Women and Its Recommendations. *2020 International Symposium on Community-Centric Systems, CcS 2020*, 0–5. <https://doi.org/10.1109/CcS49175.2020.9231464>
- Paramitha Amelia, R. R. (2020). Buku Ajar Evidende Based Midwifery. In *Umsida Press Sidoarjo Universitas* (Vol. 1, Issue 1).
- POGI. (2016). *PNPK Diagnosis dan Tatalaksana Preeklampsia*.
- Pradani, N. N. W., & Indarti, N. (2022). Hubungan Status Gizi Ibu hamil Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Teritip Balikpapan. *Junal Kebidanan*, XIV(02), 224–233.
- Prameswari, F. S. P., Marliyati, S. A., & Dewi, M. D. (2020). A Supplementary Protein Food for Pregnant Women with Chronic Energy Deficiency to Improve Fetal Growth. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 15(28), 1–10. <https://doi.org/10.25182/jgp.2020.15.1.1-10>
- Prihatini, N. L. N. S., Lindayani, I. K., & Surati, I. G. A. (2021). Hubungan Kurang Energi Kronis pada Ibu Hamil Triwulan I dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)*, 9(2), 148–154. <https://doi.org/10.33992/jik.v9i2.1461>
- Pusmaika, R., Novfrida, Y., Simatupang, E. J., Djami, M. E. ., & Sumiyati, I. (2022). Hubungan Usia Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Tangerang. *Indonesian Health Issue*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.47134/inhis.v1i1.11>
- Runjati, A. S. U. (2018). *Kebidanan : Teori Dan Asuhan*. Edited By Runjati And S. Umar. Jakarta: Egc.
- Septikasari, M. (2018). Peran Bidan dalam ASI Eksklusif di Kabupaten Cilacap. *Jurnal*

- Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 109–114. <https://doi.org/10.30604/jika.v3i2.93>
- Siti Tyastuti, H. P. W. (2015). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*.
- Sudarmi, et al. (2024). GEMAKES : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kelas Antenatalcare Terintegrasi Konseling Menyusui. *Gemakes: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, 359–368. <https://doi.org/10.36082/gemakes.v4i3.1947>
- Sukmawati, E., Ajsal, A. A. A., Purba, A., Abdullah, V. I., Putri, A. A. S., Ischak, N. I., Radhia, M. Z., Johan, R. B., Lestari, T., Muthoharoh, S., Yulia, M., & Widiyawati, R. (2023). *Epidemiologi Kesehatan Ibu Hamil Berbasis Evidence Based*.
- Sutrisna, E., Ulfa, M., Pohan, K., Persada, U. B., Keperawatan, A., & Aceh, Y. (2024). Hubungan Stres Dan Pemberian Asi Eksklusif Terhadap Risiko Kejadian Stunting Pada BadutA. *Jurnal Kesehatan, Teknologi, Dan Sains*, 3.
- Trihono, Atmarita, Dwi Hapsari Tjandrarini, Anies Irawati, Nur Handayani Utami, Teti Tejayanti, I. N. (2015). Pendek (Stunting) Di Indonesia, Masalah dan Solusinya. In *Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Vilcins, D., Sly, P. D., & Jagals, P. (2018). Environmental risk factors associated with child stunting: A systematic review of the literature. *Annals of Global Health*, 84(4), 551–562. <https://doi.org/10.29024/aogh.2361>
- Wita Solama, P. A. (2021). Cara Menyusui yang Benar, Pengetahuan, Sikap. *Babul Ilmi Jurnal Ilmiah Multi Science Kesehatan*, 13(1), 72–85.
- World Health Organization. (2019). Childhood Stunting: Context, Causes, and Consequences. *World Health Organization*, 4. <https://www.who.int/publications/m/item/childhood-stunting-context-causes-and-consequences-framework>
- Yanti, Juli S, D. (2021). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan (Teori). In *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Hang Tuah Pekanbaru* (Issue Mi).
- Yulnefia, & Sutia, M. (2022). Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-36 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tambang Kabupaten Kampar. *Medical Journal: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 10(1), 154–163.

BAB II

PENGARUH POLA ASUH KELUARGA TERHADAP PERTUMBUHAN ANAK

A. Pendahuluan

Pertumbuhan anak adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur kualitas kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi. Berbagai faktor sangat memengaruhi pertumbuhan anak, terutama pada usia dini, dan pola asuh keluarga adalah salah satunya. Pola asuh orang tua atau pengasuh utama sangat memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak. (Santrock, 2021)

Metode pengasuh yang tepat dapat membantu anak tumbuh dengan baik, tetapi pola asuh yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti keterlambatan pertumbuhan, gangguan perkembangan, dan masalah perilaku (Baumrind, 2013). Pengasuhan responsif sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental yang sehat, menurut World Health Organization (WHO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF). Ini terutama berlaku selama 1.000 hari pertama kehidupan anak. (WHO, 2019)

Aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran orang tua, memengaruhi pola asuh keluarga di berbagai negara. Kualitas pertumbuhan anak dapat dipengaruhi oleh perbedaan dalam metode pengasuhan ini. Oleh karena itu, pendidik, tenaga kesehatan, dan orang tua sangat penting untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana pola asuh memengaruhi perkembangan anak. Buku ini berfungsi sebagai referensi ilmiah yang menyelidiki berbagai aspek pola asuh keluarga dan dampak pola asuh tersebut terhadap pertumbuhan anak. (Bornstein, 2019)

Pola asuh orang tua memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak; interaksi antara orang tua dan anak membentuk perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Pola asuh orang tua juga memengaruhi karakter anak, keterampilan sosialnya, dan kesejahteraan psikologisnya. (Maccoby, E. E., & Martin, 2015)

Studi menunjukkan bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Pola asuh yang baik dapat membantu perkembangan anak secara fisik dan emosional, serta membantu mereka belajar bersosialisasi. (Papalia, D. E., & Feldman, 2020)

Dengan mengkaji berbagai teori dan penelitian sebelumnya, buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan menyeluruh tentang bagaimana pola asuh keluarga memengaruhi pertumbuhan anak. Diharapkan bahwa buku ini akan membantu orang tua, pendidik, dan praktisi memahami dan menerapkan pola asuh yang mendukung pertumbuhan optimal anak. (Steinberg, 2019)

B. Konsep Dasar Pola Asuh Keluarga Dan Pertumbuhan Anak

Strategi pengasuhan keluarga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sejak usia dini, orang tua dan lingkungan rumah memainkan peran penting dalam membentuk karakter, kebiasaan, dan kesehatan anak. Menurut (Santrock, 2021), pola pengasuhan yang digunakan dalam sebuah keluarga memengaruhi aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional seorang anak. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai cara orang tua mengasuh, mendidik, dan membimbing anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. (Baumrind, n.d.) mengidentifikasi tiga gaya pengasuhan utama: otoriter, demokratis, dan permisif. Pendidikan otoriter dicirikan oleh aturan-aturan yang ketat dan tuntutan kepatuhan yang tinggi, Pendidikan demokratis memiliki batasan yang jelas dan melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan pola asuh permisif memungkinkan anak-anak membuat keputusan sendiri tanpa banyak aturan. (Maccoby, E. E., & Martin, 2015) menambahkan kategori lain, yaitu "pengasuhan yang tidak memihak," di mana orangtua kurang memperhatikan dan tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya.

Pola pengasuhan dalam keluarga memengaruhi banyak aspek perkembangan anak. Dalam hal perkembangan fisik, anak-anak yang mendapatkan pengasuhan yang mendukung cenderung lebih ternutrisi dan berkembang secara optimal ((WHO), 2019). Dalam hal perkembangan kognitif, pendidikan demokratis mendukung penyelidikan dan pembelajaran yang lebih inklusif, membantu meningkatkan pemikiran anak dan keterampilan memecahkan masalah (Steinberg, 2019). Lebih jauh lagi, anak-anak dengan gaya pengasuhan demokratis lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dalam hal perkembangan sosial dan emosional daripada anak-anak yang dibesarkan dengan cara otoriter atau laissez-faire (Bornstein, 2019). Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengasuhan anak dalam suatu keluarga meliputi latar belakang sosial dan ekonomi, budaya dan nilai-nilai keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan kesehatan mental. Keluarga dengan keadaan ekonomi yang lebih baik cenderung memberi anak-anak mereka akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan. Selain itu, norma dan tradisi masyarakat juga memengaruhi gaya pengasuhan anak.

Pola asuh orang tua memiliki dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Gangguan tumbuh kembang, seperti keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, dapat dicegah dengan pola asuh yang tepat. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang demokratis cenderung lebih percaya diri dan mandiri, sedangkan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang lalai atau acuh tak acuh berisiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku dan kesehatan mental. Oleh karena itu, pola asuh keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan anak. Pola asuh yang demokratis dan kooperatif semakin memberikan kontribusi untuk pertumbuhan anak yang optimal. Orang tua harus

memahami dan menerapkan metode pengasuhan yang memenuhi kebutuhan anak mereka untuk mendukung perkembangan holistik anak mereka. (Trost, S. G., McDonald, S., & Cohen, 2019)

C. Pengaruh Pola Asuh Keluarga Terhadap Berbagai Aspek Pertumbuhan Anak

1. Pengaruh Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Fisik Anak

Pola asuh memengaruhi perkembangan fisik anak, termasuk bagaimana orang tua memberikan perhatian dan perawatan kepada anak-anaknya sejak usia dini, serta memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak-anaknya. Menurut Santrock, pertumbuhan fisik anak sangat dipengaruhi oleh interaksi faktor genetik, gizi, dan pola asuh dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam bidang kesehatan anak, penting untuk memahami dampak pola asuh terhadap pertumbuhan fisik anak.

Pola asuh yang baik memastikan anak menerima gizi yang cukup dan seimbang, yang merupakan faktor kunci untuk perkembangan fisik yang optimal. Menurut Black et al., anak-anak yang menerima dukungan orang tua dan makan dengan baik cenderung mencapai tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pertumbuhan. Sebaliknya, pola asuh yang tidak memperhatikan asupan gizi dapat menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan seperti terhambatnya pertumbuhan dan kekurangan gizi, yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Selain gizi, aktivitas fisik yang dipromosikan melalui pendidikan juga berperan dalam perkembangan anak. Trost dan kawan-kawan, menemukan bahwa anak-anak yang terpapar pola pengasuhan yang mengutamakan aktivitas fisik memiliki perkembangan motorik yang lebih baik dan kepadatan mineral tulang yang optimal. Anak-anak yang terbiasa bermain di luar ruangan dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik cenderung memiliki otot dan tulang yang lebih kuat daripada mereka yang tumbuh dengan pola asuh pasif.

Perawatan kesehatan juga merupakan bagian penting dari pola asuh yang memengaruhi perkembangan fisik anak. Anak-anak yang menerima semua vaksinasi yang diperlukan, menerima perawatan medis rutin dan menjalani gaya hidup sehat memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit yang menghambat pertumbuhan mereka. UNICEF menegaskan bahwa pola asuh yang memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. (UNICEF, 2021)

Namun, pola asuh yang buruk dapat mengganggu pertumbuhan fisik anak. Anak-anak yang mengalami pengabaian atau ketidakpedulian orang tua cenderung memiliki kebiasaan makan yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan masalah seperti kekurangan gizi dan obesitas. (Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, 2016b). Selain itu, apabila orang tua tidak mendorong anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik, hal itu dapat

menghambat perkembangan motorik anak dan meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan.

Oleh karena itu, cara anak dibesarkan dalam keluarga memainkan peran penting dalam perkembangan fisik mereka. Untuk pertumbuhan optimal, Anda harus makan makanan yang sehat, mendapatkan stimulasi fisik yang cukup, dan memberikan perhatian khusus pada kesehatan dan kebersihan Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memahami dan menerapkan pola asuh yang secara holistik mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik anak-anaknya. Pola asuh yang tidak mendukung dapat menyebabkan berbagai masalah pertumbuhan pada anak, seperti:

- a) **Stunting:** Kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang tidak memperhatikan nutrisi menyebabkan pertumbuhan anak terhambat (Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., 2017)
- b) **Obesitas:** Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan sedentari yang tidak dikontrol oleh orang tua dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak (Troost, S. G., McDonald, S., & Cohen, 2019)
- c) **Keterlambatan perkembangan motorik:** Anak yang kurang mendapatkan stimulasi fisik atau dibesarkan dalam lingkungan yang kurang mendukung aktivitas fisik cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan motoriknya (Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, 2016a)

2. Pengaruh Pola Asuh Terhadap Perkembangan Psikologis Anak

Orang tua adalah salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan psikologis anak. Membentuk karakter, kepribadian, keterampilan sosial, dan keterampilan emosional seorang anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Ada tiga jenis utama pola asuh yang dapat memengaruhi perkembangan anak, menurut Baumrind. Pola pengasuhan ini permisif, otoriter, dan demokratis.

a) **Aspek Kognitif**

Pola asuh yang baik dapat meningkatkan perkembangan intelektual anak. Misalnya, pola asuh demokratis yang memberikan kebebasan berpikir dapat meningkatkan kemampuan *problem-solving* dan kreativitas anak (Goleman, 2018)(Gunarsa, 2016)

b) **Aspek Emosional**

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki banyak dukungan emosional cenderung memiliki tingkat kestabilan emosi yang lebih tinggi. Di sisi lain, pola asuh yang terlalu otoriter atau permisif dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan atau depresi pada anak. (Santrock, 2021) (Yusuf, 2014)

c) **Aspek Sosial**

Anak-anak yang mendapatkan pengasuhan demokratis lebih mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial. Mereka memiliki

keterampilan komunikasi yang lebih baik dan lebih mudah beradaptasi dalam kelompok sosial. (Berk, 2022)

D. Jenis – Jenis Pola Asuh Pada Anak

Pola asuh orang tua mempengaruhi perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola asuh mempengaruhi karakter dan perilaku anak. (Santrock, 2021) .

Diana Baumrind mengklasifikasikan pola asuh menjadi tiga jenis utama, yang kemudian dikembangkan oleh Maccoby & Martin menjadi empat jenis pola asuh. Keempat jenis pola asuh tersebut adalah:

1. Pola Asuh Otoriter (Authoritarian Parenting)

Pola asuh otoriter ditandai dengan kontrol yang ketat dari orang tua, aturan yang kaku, serta harapan tinggi terhadap kepatuhan anak. Ciri-ciri utama pola asuh ini meliputi:

- (a) Orang tua menetapkan aturan tanpa menjelaskan.
- (b) Anak memiliki sedikit kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
- (c) Hukuman sering digunakan untuk menegakkan disiplin.
- (d) Interaksi yang minim antara orang tua dan anak dalam pengambilan keputusan.

Dampak pada Anak:

- (a) Anak cenderung memiliki keterampilan sosial yang rendah.
- (b) Dapat mengembangkan kecemasan, ketakutan, atau kurang percaya diri.
- (c) Cenderung patuh tetapi kurang mandiri dan kurang memiliki inisiatif
- (d) (Baumrind, 2017)

2. Pola Asuh Demokratis (Authoritative Parenting)

Pola asuh demokratis dianggap sebagai pola asuh yang paling seimbang dan positif. Dalam pola ini, orang tua tetap memberikan batasan dan aturan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat. Ciri-ciri pola asuh ini meliputi:

- (a) Orang tua menetapkan aturan yang jelas, tetapi tetap terbuka untuk diskusi dengan anak.
- (b) Memberikan bimbingan dan dorongan positif dalam pengambilan keputusan.
- (c) Menggunakan pendekatan disiplin yang bersifat edukatif, bukan hukuman keras.
- (d) Menunjukkan kasih sayang dan mendukung perkembangan emosional anak.

Dampak pada Anak:

- (a) Anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

- (b) Mengembangkan keterampilan sosial yang baik dan mampu beradaptasi.
- (c) Lebih mandiri dan mampu mengambil keputusan sendiri (Papalia, D. E., & Feldman, 2020)

3. Pola Asuh Permisif (Permissive Parenting)

Pola asuh permisif cenderung memberikan kebebasan yang luas kepada anak tanpa batasan yang jelas. Orang tua dengan pola asuh ini biasanya sangat penyayang tetapi kurang dalam memberikan struktur dan aturan. Ciri-ciri pola asuh ini meliputi:

- (a) Orang tua jarang menetapkan aturan yang tegas.
- (b) Cenderung menghindari konfrontasi dengan anak.
- (c) Anak diberikan kebebasan penuh untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan dalam situasi yang membutuhkan bimbingan orang tua.

Dampak pada Anak:

- (a) Anak kurang memiliki disiplin diri.
- (b) Cenderung sulit mengontrol emosi dan bisa menjadi impulsif.
- (c) Mungkin mengalami kesulitan dalam memahami batasan dan tanggung jawab. (Berk, 2022)

4. Pola Asuh Tidak Terlibat (Neglectful/Uninvolved Parenting)

Pola asuh ini terjadi ketika orang tua kurang memberikan perhatian dan keterlibatan dalam kehidupan anak mereka. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan finansial, pekerjaan, atau masalah psikologis orang tua. Ciri-ciri pola asuh ini meliputi:

- (a) Kurangnya komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak.
- (b) Tidak ada aturan atau bimbingan yang jelas dalam kehidupan anak.
- (c) Orang tua tidak menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan emosional maupun fisik anak.

Dampak pada Anak:

- (a) Anak cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial.
- (b) Dapat mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan dan depresi.
- (c) Berisiko mengalami masalah akademik dan perilaku menyimpang. (Santrock, 2021)

E. Strategi Menerapkan Pola Asuh Yang Mendukung Pertumbuhan Anak

Strategi Implementasi Pola Asuh yang Mendukung Pertumbuhan Anak Untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal, berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pola asuh:

1. Membangun Komunikasi yang Efektif

- (a) Orang tua perlu mendengarkan dan memahami kebutuhan anak

- (b) Menggunakan komunikasi dua arah yang terbuka dan positif.
- (c) Memberikan umpan balik yang membangun. (Santrock, 2021)

2. Menetapkan Aturan dan Batasan yang Konsisten

- (a) Menyusun aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh anak (Baumrind, 2017)
- (b) Menerapkan disiplin yang konsisten agar anak memahami konsekuensi dari setiap tindakan.

3. Memberikan Kasih Sayang dan Dukungan Emosional

- (a) Menunjukkan empati dan memahami perasaan anak (Papalia, D. E., & Feldman, 2020)
- (b) Memberikan penghargaan dan dorongan positif untuk meningkatkan kepercayaan diri anak.

4. Mendorong Kemandirian dan Tanggung Jawab

- (a) Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan (Berk, 2022)
- (b) Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sederhana sesuai usia mereka.

5. Menyediakan Lingkungan yang Mendukung Pertumbuhan

- (a) Memastikan anak memiliki lingkungan yang aman dan sehat (Hurlock, 2011)
- (b) Memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan pembelajaran.

6. Menjadi Teladan yang Baik

- (a) Orang tua harus menunjukkan perilaku yang dapat dicontoh oleh anak.
- (b) Menanamkan nilai-nilai positif melalui tindakan sehari-hari (Dacey, J. S., & Travers, 2013)

7. Mendukung Interaksi Sosial Anak

- (a) Mendorong anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya.
- (b) Mengajarkan anak keterampilan sosial, seperti berbagi dan bekerja sama.

8. Membatasi Penggunaan Teknologi

- (a) Mengontrol waktu layar anak dan memastikan akses ke konten yang sesuai.
- (b) Mendorong aktivitas fisik dan interaksi langsung dengan keluarga serta teman (Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, 2010)

F. Tantangan Dalam Penerapan Pola Asuh di Era Digital

Implementasi pola asuh yang mendukung pertumbuhan anak memerlukan kesadaran dan konsistensi dari orang tua. Anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan di masa depan dengan menerapkan strategi yang tepat dan menghadapi tantangan di era digital

secara bijak. Dalam jangka panjang, pola asuh yang positif akan berdampak pada kesehatan mental, sosial, dan kognitif anak. (Hurlock, 2011)

Tantangan dalam Penerapan Pola Asuh di Era Digital Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru dalam pola asuh anak. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi orang tua:

1. Paparan Berlebihan terhadap Layar

- (a) Anak cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental
- (b) Orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gawai dan mengajak anak beraktivitas fisik. (Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, 2016a)

2. Informasi yang Tidak Tersaring

- (a) Anak-anak dapat dengan mudah mengakses internet, termasuk konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. (Livingstone, S., & Helsper, n.d.)
- (b) Orang tua harus aktif dalam mengawasi konten yang dikonsumsi anak dan memberikan edukasi tentang literasi digital.

3. Kurangnya Interaksi Sosial

- (a) Anak yang terlalu sering menggunakan perangkat digital dapat mengalami keterlambatan dalam keterampilan sosial (Twenge, 2017)
- (b) Mendorong anak untuk berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya dan keluarga menjadi hal yang penting.

4. Dampak pada Kesehatan Mental

- (a) Media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak dan menyebabkan kecemasan atau depresi
- (b) Orang tua perlu mengajarkan anak tentang penggunaan media sosial yang sehat dan mendorong diskusi terbuka mengenai perasaan mereka. (Chassiakos, Y. R., Radesky, J., Christakis, D., Moreno, M. A., & Cross, 2016)

5. Ketidakseimbangan Antara Teknologi dan Aktivitas Fisik

- (a) Anak cenderung kurang bergerak akibat terlalu banyak menggunakan teknologi ((WHO)., 2019)
- (b) Orang tua dapat menetapkan jadwal bermain di luar rumah dan mendorong aktivitas fisik yang menyenangkan

G. Dampak Pola Asuh Pada Kesehatan Anak

Kesehatan berbagai anak sangat dipengaruhi oleh cara orang tua menjaga mereka, seperti:

1. Kesehatan Fisik

- (a) Pola asuh demokratis cenderung menghasilkan anak dengan pola makan yang lebih sehat dan kebiasaan hidup aktif (Santrock, 2021)

- (b) Pola asuh permisif dapat menyebabkan anak lebih rentan terhadap obesitas karena kurangnya kontrol terhadap asupan makanan dan aktivitas fisik (Maccoby, E. E., & Martin, 2010)
- (c) Pola asuh tidak terlibat meningkatkan risiko malnutrisi dan kurangnya perawatan kesehatan (Baumrind, 2017)

2. Kesehatan Mental

- (a) Pola asuh otoriter dan tidak terlibat berisiko menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah perilaku (Darling, N., & Steinberg, n.d.)
- (b) Pola asuh demokratis membantu anak mengembangkan ketahanan mental dan kepercayaan diri (Santrock, 2021)
- (c) Pola asuh permisif dapat menyebabkan anak memiliki kontrol diri yang rendah dan kesulitan mengelola emosi (Baumrind, n.d.)

3. Perkembangan Sosial

- (a) Anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis cenderung lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan sosial (Maccoby, E. E., & Martin, 2015)
- (b) Anak-anak dengan pola asuh yang permisif atau tidak terlibat dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. (Darling, N., & Steinberg, n.d.)
- (c) Cara orang tua menjaga berbagai anak sangat memengaruhi kesehatan mereka. (Santrock, 2021)

H. Strategi dalam Pola Asuh Keluarga Terhadap Pertumbuhan Anak

Pola asuh keluarga memainkan peran vital dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Strategi pengasuhan yang tepat tidak hanya membentuk karakter dan perilaku anak, tetapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental mereka. Berikut adalah beberapa strategi dalam pola asuh keluarga yang dapat diterapkan untuk mendukung pertumbuhan anak: (Wiwin Nart, 2014)

1. Menerapkan Pola Asuh Demokratis

Komunikasi dua arah antara orang tua dan anak menunjukkan pola asuh demokratis. Orang tua membantu dan mengajar, tetapi mereka tetap menghargai kemandirian dan pendapat anak. Anak-anak memperoleh rasa tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kemampuan pengambilan keputusan melalui pendekatan ini.

2. Menciptakan Lingkungan Rumah yang Aman dan Nyaman

Sangat penting bahwa rumah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak untuk tumbuh. Orang tua dapat menciptakan suasana positif di mana anak-anak dapat bermain dan belajar, sehingga mereka merasa dihargai dan dicintai.

3. Memberikan Disiplin Positif

Disiplin positif fokus pada pengajaran dan pembimbingan daripada hukuman. Orang tua menetapkan aturan yang jelas dan konsisten, serta memberikan konsekuensi yang mendidik. Pendekatan ini membantu anak memahami batasan dan mengembangkan kontrol diri.

4. Menjadi Teladan yang Baik

Orang tua harus menunjukkan sikap dan perilaku positif seperti kejujuran, empati, dan kerja keras kepada anak-anak mereka karena anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka.

5. Memberikan Dukungan Emosional

Dukungan emosional dari orang tua membantu anak merasa aman dan dicintai. Mendengarkan dengan empati, memberikan pujian, dan menunjukkan kasih sayang secara konsisten dapat memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak, serta mendukung kesehatan mental mereka.

6. Melibatkan Ayah dalam Pengasuhan

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan memiliki dampak positif pada perkembangan anak. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua cenderung lebih bahagia, berprestasi akademik, dan lebih peka terhadap orang lain.

7. Menjaga Konsistensi dalam Pengasuhan

Konsistensi dalam penerapan aturan dan ekspektasi membantu anak memahami apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini menciptakan rasa aman dan membantu anak mengembangkan perilaku yang diinginkan.

8. Mengajarkan Kemandirian

Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab sesuai dengan usianya membantu mereka mengembangkan kemandirian dan rasa percaya diri. Orang tua dapat mendukung dengan memberikan bimbingan dan kepercayaan.

9. Menghindari Pola Asuh Otoriter dan Permisif

Pola asuh yang terlalu otoriter dapat menyebabkan anak tertekan dan kehilangan kepercayaan diri, sementara pola asuh yang terlalu longgar dapat menyebabkan anak kurang disiplin. Akibatnya, penting bagi orang tua untuk menemukan cara untuk mengimbangi pengasuhan mereka.

Orang tua dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak mereka dengan cara-cara di atas, membentuk karakter yang positif, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi kesulitan di masa depan.

I. Penutup

Orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak mereka dapat berdampak pada perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak tersebut. Pengasuhan yang tepat membantu anak-anak tumbuh menjadi orang yang sehat, mandiri, dan berkualitas sosial. (Bornstein, 2019)

Diskusi sebelumnya menyatakan bahwa ada banyak jenis orang tua, seperti otoritarianisme, demokratis, toleransi, non-terlibat, dan masing-masing memiliki efek berbeda pada perkembangan anak. Hubungan orang tua-anak yang demokratis adalah yang paling ideal karena mereka memberikan keseimbangan aturan dan kebebasan sehingga anak-anak dapat mengembangkan pemikiran kritis, kepercayaan, dan keterampilan sosial yang sangat baik. Namun, pada kenyataannya, pengasuhan anak tidak selalu mudah diterapkan. Tantangan seperti perubahan sosial, dampak teknologi, dan tekanan ekonomi dapat memengaruhi cara orang tua membesarkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, kesadaran orang tua yang mendalam dan pemahaman yang mendalam diperlukan untuk mengadaptasi hubungan orang tua-anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Penting bagi orang tua dan pendidik lebih lanjut meningkatkan pengetahuan pengasuhan mereka yang mendukung pertumbuhan optimal anak-anak mereka. Menerapkan strategi orang tua yang tepat berarti bahwa anak-anak akan berkembang secara keseluruhan dan menjadi orang yang bersedia menghadapi tantangan di masa depan. (Baumrind, n.d.)

Oleh karena itu, memahami bagaimana hubungan orang tua-anak memengaruhi perkembangan anak adalah tugas yang tidak terbatas pada orang tua, tetapi juga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sangat penting bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat bekerja sama untuk membuat lingkungan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. (Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, 2010)

Referensi

- (WHO), W. H. O. (2019). Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age. *Who*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550536>
- Baumrind, D. (n.d.). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. *Genetic Psychology Monographs*. <https://psycnet.apa.org/record/1967-05780-001>
- Baumrind, D. (2017). Child care practices anteceding three patterns of preschool behavior. *Journal of Early Adolescence*. <https://psycnet.apa.org/record/1967-05780-001>
- Berk, L. E. (2022). *Development Through the Lifespan*. Pearson. https://www.google.co.id/books/edition/Development_Through_The_Lifespan/b0xwEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Laura+E.+Berk%22&printsec=frontcover
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2017). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23746772/>
- Bornstein, M. H. (2019). *Handbook of Parenting* (3rd ed.). https://www.routledge.com/Handbook-of-Parenting-Volume-3-Being-and-Becoming-a-Parent-Third-Edition/Bornstein/p/book/9781138228726?srsId=AfmBOOp80IUWFaXIwcNRW_9CdI7Dd6SMfBBEVP8yhtSEecvE49HEowes
- Chassiakos, Y. R., Radesky, J., Christakis, D., Moreno, M. A., & Cross, C. (2016). *Children and Adolescents and Digital Media*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27940795/>
- Dacey, J. S., & Travers, J. F. (2013). *Human Development Across the Lifespan* (7 (ed.)). McGraw-Hill Education. <https://www.amazon.com/Human-Development-Across-Lifespan-Dacey/dp/0073382655>
- Darling, N., & Steinberg, L. (n.d.). Parenting style as context: An integrative model. *Psychological Bulletin*. <https://psycnet.apa.org/record/1993-29246-001>
- Goleman, D. (2018). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam. <https://www.amazon.com/Emotional-Intelligence-Matter-More-Than/dp/055338371X>
- Gunarsa, S. D. (2016). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Gunung Mulia. <https://www.pdfdrive.com/psikologi-perkembangan-anak-dan-remaja-e52680891.html>
- Hurlock, E. B. (2011). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga. <http://opacinsancendekia-oki.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1760>

- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (n.d.). *Gradations in digital inclusion: Children, young people, and the digital divide*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/1461444807080335>
- Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (2010). *Socialization in the context of the family: Parent-child interaction*. (4th ed.). Handbook of Child Psychology.
<https://www.scienceopen.com/book?vid=480aba1c-b694-4d5c-b00c-63bb6766b138>
- Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (2015). *Socialization in the context of the family* (Vol. 4). Handbook of Child Psychology. <https://rl.talis.com/3/ucl/items/36C9F7D9-9E36-3721-1144-3867002B248B.html>
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2020). *Experience Human Development*. McGraw-Hill.
https://www.researchgate.net/profile/Ying-Zhang-164/publication/362712073_Learning_Process_and_Success_in_Education_Learning_Process_and_Success_in_Education/links/62fb6c78e3c7de4c345f4973/Learning-Process-and-Success-in-Education-Learning-Process-and-Success-in-Education.pdf
- Rideout, V. J., Foehr, U. G., & Roberts, D. F. (2010). *ion M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds*. Kaiser Family Foundation.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527859.pdf>
- Santrock, J. W. (2021). *Life-span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Higher Education,.
https://books.google.co.id/books/about/Life_Span_Development.html?id=4JcoyQEACAAJ&redir_esc=y
- Steinberg, L. (2019). *The 10 Basic Principles of Good Parenting*.
https://books.google.co.id/books?id=AahNd33-EC0C&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Trost, S. G., McDonald, S., & Cohen, A. (2019). Movement behaviors and physical activity in early childhood. *Journal-of-Environmental-Research-and-Public-Health-IJERPH*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/ijerph182413226>
- Twenge, J. M. (2017). *Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious*. Atria Books.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/fcsr.12345>
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021*.
<https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021>
- Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, R. (2016a). Worldwide timing of growth faltering: Revisiting implications for interventions. *Pediatrics*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20156903/>

- Victora, C. G., de Onis, M., Hallal, P. C., Blössner, M., & Shrimpton, R. (2016b). Worldwide timing of growth faltering Revisiting implications for interventions. *Pediatrics*. <https://europepmc.org/article/med/20156903>
- Wiwin Nart. (2014). *Menjadi Pribadi Otentik dengan Mengenal Diri*. Victory Pustaka Media. <https://kubuku.id/detail/menjadi-pribadi-otentik-dengan-mengenal-diri/79793>
- Yusuf, S. (2014). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (19th ed.). Remaja Rosdakarya. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=23415>

BAB III

INTERVENSI NUTRISI UNTUK MENCEGAH STUNTING PADA BALITA

A. Pendahuluan

Kejadian stunting pada balita merupakan salah satu permasalahan gizi yang dialami oleh anak balita di dunia saat ini. Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan linear yang terjadi pada masa kanak-kanak dan merupakan bentuk kekurangan gizi yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah gizi, termasuk Indonesia. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak ibu mulai mengandung hingga anak berusia dua tahun, baik karena kualitas gizi maupun kondisi lingkungan. Stunting berdampak terhadap kesehatan saat ini dan di masa depan, seperti gangguan pertumbuhan dan kerentanan anak terhadap penyakit dengan konsekuensi permanen pada saat dewasa. Selain itu, stunting dapat menghambat perkembangan kognitif yang berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan produktivitas saat dewasa. Kerusakan fisik dan neurokognitif yang berpotensi tidak dapat diperbaiki yang menyertai pertumbuhan terhambat merupakan hambatan utama bagi perkembangan manusia. Masalah stunting tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, juga berdampak pada perekonomian. Gejala Stunting mulai terlihat setelah bayi berusia dua tahun dan memiliki ciri-ciri tinggi badan di bawah rata-rata atau pendek. Upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia salah satunya adalah melalui program gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, dengan memberikan intervensi yang optimal seperti intervensi gizi yang meliputi intervensi gizi sensitif dan spesifik. Stunting termasuk salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) yang termasuk pada tujuan Pembangunan berkelanjutan kedua yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan.

B. Definisi Stunting

Kegagalan pertumbuhan linear (stunting) pada masa kanak-kanak merupakan bentuk kekurangan gizi yang paling umum di dunia. Stunting didefinisikan sebagai rasio tinggi badan anak terhadap usia dan jenis kelamin yang berada di bawah standar deviasi (Kusuma *et al.*, 2023). Stunting dianggap sebagai kegagalan pertumbuhan linear pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk yang berlangsung dalam jangka waktu lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), stunting pada anak balita merupakan masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya mencapai 20%. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen. Angka ini masih jauh dari target penurunan stunting, yaitu 14 persen pada akhir tahun 2024. Pada anak yang mengalami stunting, gangguan

perkembangan motorik berkaitan dengan terhambatnya proses pematangan otot, sehingga kemampuan menggerakkan otot pun terganggu. Stunting merupakan kondisi terhambatnya pertumbuhan balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama yang ditandai dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD) dan kurang dari -3SD berdasarkan standar pertumbuhan (WHO, 2010).

C. Penyebab Stunting

Secara umum penyebab stunting dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu masyarakat, keluarga, dan individu, yang berkaitan dengan pola asuh, asupan makanan, pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan (Hasanah *et al.*, 2020). Penyebab masalah gizi (stunting) dapat terbagi menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi. Faktor risiko penyebab langsung stunting juga meliputi kesehatan ibu yang buruk, kurangnya fasilitas perawatan antenatal, pemberian makanan dan perawatan yang tidak memadai, infrastruktur dan fasilitas perawatan kesehatan yang tidak memadai (Fatima *et al.*, 2020). Interaksi antara praktik pemberian makanan yang tidak memadai dan Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) juga merupakan penyebab langsung terjadinya stunting (Syahrudin, Irmawati and Sari, 2023), sehingga kesadaran masyarakat dalam penanganan sanitasi, pola makan dan pengasuhan anak perlu ditingkatkan untuk menekan prevalensi stunting. Sementara, penyebab tidak langsung dari masalah stunting adalah tingkat dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pemilihan jenis makanan tambahan, waktu pemberian serta kebiasaan hidup sehat, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi balita. Riwayat berat badan lahir rendah (BBLR) mempengaruhi kejadian stunting. Dampaknya, pertumbuhan bayi BBLR tidak optimal, jika keadaan ini terus berlanjut dengan pemberian makanan yang tidak memadai, sering terkena infeksi, dan perawatan kesehatan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak (Alba, Ditte Ayu Suntara and Siska, 2021). Penyebab stunting bersifat multifaktorial dan utamanya adalah kekurangan gizi kronis pada 1.000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun dan terkait dengan asupan gizi yang tidak mencukupi atau kebutuhan gizi yang meningkat. Kebutuhan gizi yang meningkat disertai dengan terbatasnya kualitas dan kuantitas makanan pendamping selama dua tahun pertama kehidupan menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang tidak optimal yang berkaitan dengan kejadian stunting. Stunting dapat terjadi akibat pertumbuhan yang terhambat secara bertahap dan tidak dapat mengejar laju pertumbuhan yang diharapkan. Yang mengejutkan adalah bahwa anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir normal pun dapat mengalami retardasi pertumbuhan jika kondisi ini tidak ditangani. Oleh karena itu, penekanan pada intervensi tepat waktu dan penanganan komprehensif sangat penting untuk mengurangi konsekuensi jangka panjang dari stunting. Salah satu periode utama terjadinya stunting adalah selama masa kehamilan. Ketika janin dalam kandungan tidak menerima asupan gizi yang

cukup, hal itu dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat bahkan sebelum lahir. Hal ini menggarisbawahi peran penting asupan gizi ibu dalam membentuk kesehatan anak sejak awal kehidupan. Lebih jauh, kondisi ini mungkin tidak muncul hingga anak mencapai usia 2 tahun, yang menunjukkan kompleksitas dalam mendiagnosis dan menangani stunting dalam kurun waktu kritisnya (Sianturi, Alfriyani and Cintya, 2023). Peran seorang ibu menentukan status gizi anak balita setelah lahir. Selama dua tahun pertama di awal kelahiran, kebutuhan gizi untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal sangat tinggi, sehingga faktor-faktor yang merugikan dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan di awal kehidupan. Kekurangan gizi dapat berupa asupan makanan yang kurang atau kualitas makanan yang tidak memadai, seperti makanan kurang bervariasi. Faktor lain yang berperan terhadap risiko terjadinya stunting yaitu kesehatan ibu saat hamil, pola asuh dan kesehatan anak atau seringnya menderita penyakit menular, kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Infeksi yang sering terjadi selama 2 tahun pertama kehidupan juga berperan penting terhadap risiko tinggi menjadi kerdil selama periode tersebut (Roth *et al.*, 2017). Stunting juga dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. Pendidikan ibu berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pendidikan ibu dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal, termasuk keahlian tentang pemberian gizi, kebersihan, atau perawatan kesehatan pada anak sehingga pendidikan ibu dapat mempengaruhi terjadinya kasus stunting pada anak. Lokasi tempat tinggal juga dapat berdampak pada kesehatan anak. Lingkungan yang kotor berisiko meningkatkan penyakit infeksi atau penyakit lainnya, dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, lingkungan rumah, dan jamban yang tidak bersih lebih berisiko mengalami stunting karena berpotensi mengalami penyakit infeksi seperti diare, yang akan mengganggu penyerapan zat gizi dalam proses pencernaan (Laksono *et al.*, 2022). Bayi akan mengalami penurunan berat badan akibat beberapa penyakit infeksi yang dideritanya. Stunting dapat terjadi pada anak jika kondisi ini berlangsung lama dan tidak diimbangi dengan asupan yang cukup untuk mempercepat penyembuhan infeksi (Hasanah *et al.*, 2020). Penyebab terjadinya stunting tidak hanya terfokus pada sektor kesehatan saja, melainkan sektor non kesehatan. Selain itu, faktor gizi yang sensitif seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya juga turut memberikan kontribusi lebih besar dalam mengatasi masalah gizi, yakni sebesar 70% (Ch Rosha *et al.*, 2016). Penurunan angka stunting balita yang relatif lambat juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebiasaan/budaya masyarakat yang sulit diubah ke arah pola hidup bersih dan sehat, kondisi geografis, serta masalah kerawanan pangan.

D. Dampak Stunting

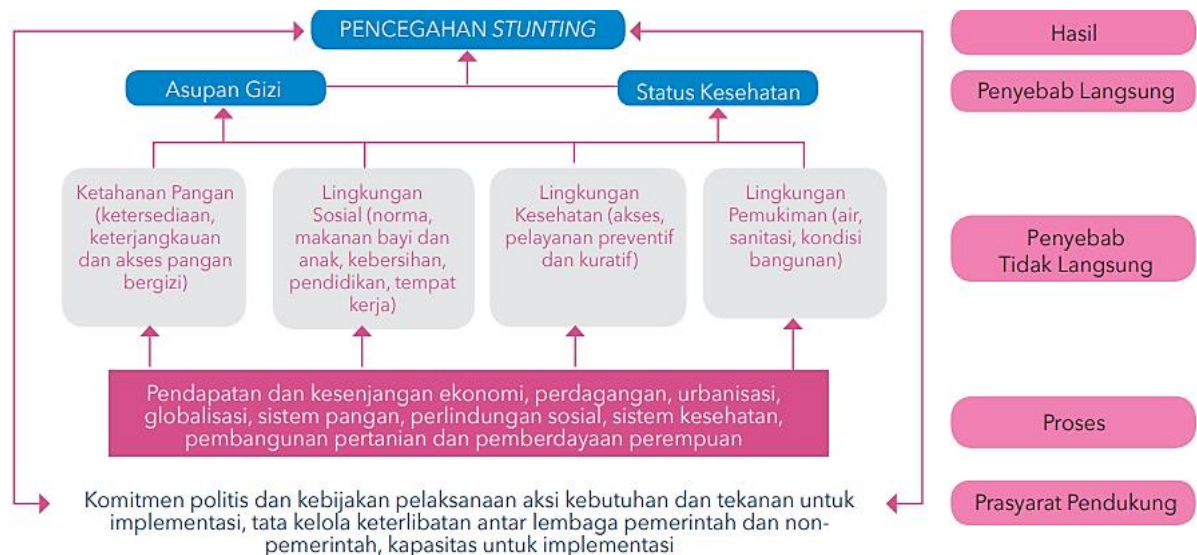
Stunting pada anak memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang dan mencakup peningkatan morbiditas dan mortalitas, dan berdampak buruk

terhadap perkembangan anak dan kesehatan saat dewasa yang berkontribusi pada siklus kekurangan gizi, dan menghambat pembangunan ekonomi, meliputi penurunan kapasitas kerja, hasil reproduksi ibu yang tidak baik di masa dewasa dan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR mengindikasikan adanya masalah kesehatan pada ibu selama kehamilan. Bayi BBLR memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan rentan terhadap infeksi, yang dapat menyebabkan masalah gizi di kemudian hari. Lebih jauh lagi, anak-anak yang mengalami stunting yang mengalami kenaikan berat badan dengan cepat setelah dua tahun berisiko lebih tinggi menjadi kelebihan berat badan atau obesitas di kemudian hari, meningkatnya risiko penyakit kronis terkait gizi di masa dewasa seperti resistensi insulin, diabetes, hipertensi dan dislipidemia, serta menurunkan pendapatan ekonomi (Soliman *et al.*, 2021). Masalah stunting terutama pada masa 1000 HPK sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, dan akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh anak yang kurang optimal. Stunting dikaitkan dengan tinggi badan yang lebih pendek pada anak-anak. Anak-anak yang mengalami stunting biasanya mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan fisiknya. Anak-anak yang pertumbuhannya terhambat memerlukan bantuan dalam mengembangkan keterampilan motorik seperti berjalan, mengambil benda, atau keterampilan fisik lainnya. Stunting juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, termasuk keterlambatan dalam belajar, berpikir, dan kemampuan berbahasa. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit lainnya karena lemahnya sistem kekebalan tubuh. Dampak jangka pendek dari stunting adalah anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mengalami hambatan perkembangan kognitif dan motorik, ukuran tubuh kurang optimal, dan gangguan metabolisme pada anak, sedangkan Dampak stunting dalam jangka panjang berakibat pada menurunnya kemampuan intelektual atau kecerdasan serta terganggunya struktur dan fungsi syaraf serta sel otak, yang sifatnya permanen atau irreversible, yang akan berdampak pada menurunnya kemampuan dalam menyerap pelajaran saat dewasa (Akbar, Kartika and Khairunnisa, 2023).

E. Pencegahan dan Penanganan Stunting

Pemenuhan gizi, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), merupakan periode kritis untuk mencegah terjadinya stunting. Pemenuhan gizi tersebut meliputi gizi pada masa kehamilan dan masa kanak-kanak hingga usia 2 tahun. Pemberian Makanan yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dan mendukung pertumbuhan yang optimal. Selain itu, penting juga untuk memastikan variasi makanan, asupan gizi yang cukup, dan pola asuh yang tepat untuk membantu mengatasi stunting pada anak. Kesehatan saat hamil dan anak yang lahir juga harus dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi saat hamil dan masa kanak-kanak. WHO menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun. ASI juga mengandung zat gizi makro

dan mikro, komponen kekebalan tubuh, serta asam amino bebas (Free Amino Acids) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi (Soraya, Ilham and Hariyanto, 2022). Pemberian cairan selain ASI, terutama sebelum usia empat bulan, berkaitan dengan masalah gastrointestinal. Hal ini dapat mengakibatkan stunting, kekurangan zat gizi mikro, dan kerentanan terhadap berbagai penyakit dalam beberapa tahun pertama kehidupan (Fatima *et al.*, 2020). Pemberian ASI eksklusif akan meningkatkan sistem imun bayi. Pemberian kolostrum sejak dini dapat memberikan kekebalan pada tubuh bayi sehingga mengurangi risiko infeksi. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko 6,6 kali lebih besar mengalami stunting karena sistem imun yang rendah berdampak pada kerentanan tubuh terhadap berbagai macam infeksi (Wicaksono *et al.*, 2021). Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala juga penting. Sejak dalam kandungan, setiap bulan setelah lahir hingga berusia dua tahun, dan setiap 6-12 bulan setelah berusia dua tahun. Dengan demikian, keterlambatan tumbuh kembang dapat dideteksi dan dicegah. Menangani masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga masyarakat. Strategi efektif yang ditujukan untuk memerangi stunting mencakup pendekatan multidimensi. Intervensi gizi yang menargetkan ibu dan anak merupakan hal mendasar. Ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya ibu balita, tentang stunting. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye mengenai stunting. Melalui upaya seperti ini, diharapkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang stunting dapat meningkat, sehingga dapat membantu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan ibu balita tentang stunting diharapkan dapat menjadi salah satu kunci upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak. Program yang berfokus pada edukasi masyarakat tentang gizi yang tepat, promosi pemberian ASI, dan peningkatan akses terhadap makanan yang beragam dan bergizi memainkan peran penting dalam mengurangi prevalensi stunting. Selain itu, intervensi harus mencakup lebih dari sekadar gizi. Meningkatkan akses layanan kesehatan, memastikan fasilitas sanitasi, dan menerapkan praktik kebersihan merupakan komponen integral dalam mengekang prevalensi stunting. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya membahas aspek gizi tetapi juga faktor sosial lingkungan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan terhambat (Muliawan *et al.*, 2024). Identifikasi dan intervensi dini melalui layanan kesehatan, ditambah dengan inisiatif pendidikan yang menargetkan orang tua dan pengasuh, merupakan komponen penting dalam memutus siklus stunting. Dengan deteksi dini, penyimpangan tumbuh kembang anak dapat diketahui sejak dini, sehingga upaya Pencegahan stunting pada anak dapat segera dilakukan. Selain itu, mendukung kebijakan yang memprioritaskan gizi, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan di tingkat lokal dan nasional sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penyebab dan Pencegahan Stunting

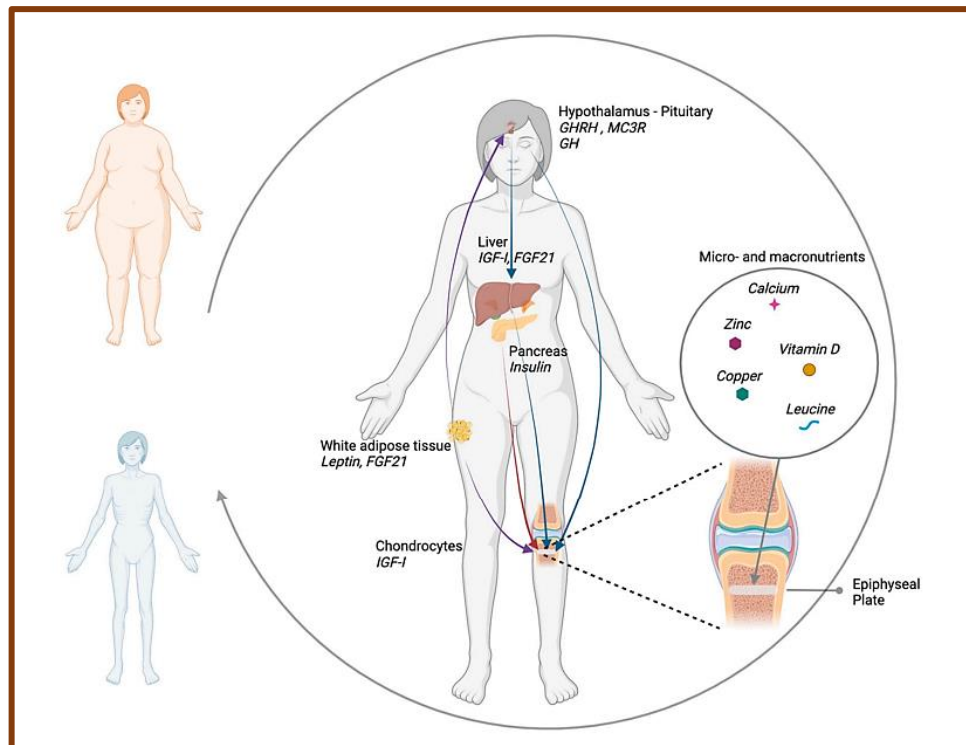
F. Peranan Nutrisi dalam Mencegah Stunting pada Balita

Gizi merupakan bagian penting dari kesehatan dan perkembangan. Gizi yang baik berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, kehamilan dan persalinan yang lebih aman, rendahnya risiko penyakit tidak menular (seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular), dan umur panjang. Makanan mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang sehat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan anak. Selain kualitas makanan, kuantitas dalam pemberian makanan juga penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami kebutuhan gizi dan cara pemberian makan pada anak untuk mencegah risiko kekurangan gizi (Wardani, 2022).



Gambar 3.2 Rekomendasi Praktik PMBA pada Rentang Usia 6-23 Bulan

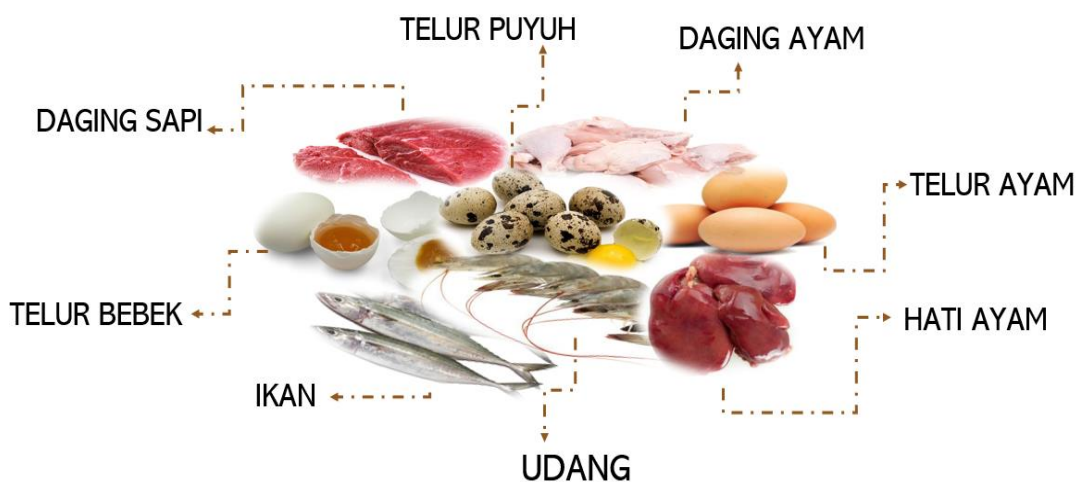
Ketersediaan dan/atau pemanfaatan zat gizi pada tingkat seluler berperan penting dalam mendorong lintasan pertumbuhan linier anak dan perkembangan neurokognitif (Prado *et al.*, 2019). Selama enam bulan pertama kehidupan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal. Untuk bayi dan anak kecil berusia 6–23 bulan, dianjurkan untuk terus memberikan ASI dan melengkapinya dengan makanan yang bervariasi dan padat energi dan zat gizi untuk meningkatkan pertumbuhan yang optimal. Setelah enam bulan, hanya pemberian ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Periode dari 6 hingga 23 bulan, saat makanan pendamping diperkenalkan, bertepatan dengan waktu ketika gangguan pertumbuhan dan perkembangan neurokognitif yang tertunda paling umum terjadi. Kurangnya asupan gizi pada masa emas pertumbuhan dapat mengakibatkan kekurangan gizi, salah satunya adalah stunting. Asupan gizi yang tidak adekuat pada masa perkembangan otak mengakibatkan berkurangnya jumlah akson saraf, dendrit apikal menjadi pendek, dan proses mielinisasi menjadi terhambat sehingga kecepatan penghantaran impuls saraf antar neuron menjadi terganggu yang berhubungan dengan gangguan perkembangan motorik pada anak stunting (Kartika, Suryani and Garna, 2020). Asupan makanan anak sepanjang seribu hari pertama kehidupan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan otak. Asupan gizi yang tidak mencukupi pada anak dapat menyebabkan perkembangan motorik yang buruk, tingkat aktivitas yang rendah, dan kurangnya minat terhadap lingkungan (Martiani *et al.*, 2021). Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, asupan zat gizi makro dan mikro yang cukup (seperti energi, protein, dan vitamin A, C, dan kalsium) sangat penting. Asupan zat gizi makro dan mikro yang rendah menjadi faktor risiko kekurangan gizi (Sari *et al.*, 2023). Dibandingkan dengan mereka yang asupannya cukup (>90% RDA), anak-anak dengan asupan energi dan protein di bawah 70% RDA memiliki risiko 1,3 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting. Pada manusia, kekurangan protein menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Zat gizi berperan penting dalam pengaturan pertumbuhan pada kehidupan janin, bayi, anak-anak, dan remaja. Zat gizi merupakan bahan dasar untuk perkembangan tulang rawan dan tulang dan, pada saat yang sama, mengatur jaringan hormon dan faktor pertumbuhan yang kompleks, yang bekerja secara endokrin, parakrin, dan autokrin, yang secara halus mengendalikan fisiologi lempeng pertumbuhan. Kebutuhan protein pada anak lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Laju pertumbuhan anak dapat terhambat akibat kekurangan protein karena dapat mengganggu produksi hormon Insulin-like Growth Factor (IGF)-1 yang memengaruhi pertumbuhan tulang (Sari *et al.*, 2016). Protein berfungsi untuk memodifikasi sekresi dan aksi osteotropik hormone IGF-I, sehingga, asupan protein dapat memodulasi potensi genetik dari pencapaian peak bone mass. Hormon IGF-1 juga dibutuhkan untuk pembentukan kondroitin sulfat dan kolagen yang dibutuhkan untuk Pertumbuhan Tulang Rawan.



Gambar 3.3 Representasi skematis interaksi antara status gizi dan pengatur pertumbuhan endokrin

Protein dapat dikatakan adekuat apabila mengandung semua jenis asam amino esensial dalam jumlah yang sesuai dan mudah dicerna serta diserap oleh tubuh. Protein-asam amino merupakan zat gizi utama yang terlibat dalam pertumbuhan linier. Anak balita memerlukan asam amino lisin, leusin, isoleusin, valin, treonin, fenilalanin, tirosin, metionin, sistein, triptofan, histidin, dan arginin yang sebagian besar merupakan asam amino esensial (Hardinsyah, 2017). Oleh karena itu, sebagian besar protein yang dikonsumsi anak haruslah protein hewani yang berkualitas tinggi karena protein tersebut memiliki daya cerna yang lebih baik dan komposisi asam amino esensial yang lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Protein hewani dapat memengaruhi kejadian stunting pada anak (Afiah *et al.*, 2020). Asupan lemak yang rendah akan berdampak pada sintesis lemak sehingga berdampak pada pertumbuhan anak (Basri *et al.*, 2021). Konsumsi zat gizi mikro juga harus diperhatikan untuk pertumbuhan anak. Stunting merupakan kondisi di mana kekurangan vitamin C diduga menjadi faktor penyebabnya. Vitamin C sangat penting untuk produksi kolagen, yaitu serat dan struktur protein yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang (Bening, 2016). Asupan kalsium sangat penting untuk pembentukan tulang. Kalsium berperan dalam proses pembentukan substrat dan akan terakumulasi selama pembentukan jaringan tulang. Mekanisme pembelahan sel, pertumbuhan, dan penyembuhan jaringan akan terhambat akibat kekurangan kalsium, yang akan berdampak pada berat dan tinggi badan anak (Ratnalela Srg *et al.*, 2021). Asupan zat besi yang rendah dapat mengganggu fungsi kognitif dan pertumbuhan anak karena zat besi membantu sistem kekebalan tubuh, sehingga anak tidak mudah terserang penyakit. Kekurangan zat besi dapat

menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terhambat. Zat besi juga berperan dalam pengangkutan oksigen ke seluruh jaringan. Jika oksigenasi jaringan terganggu, tulang tidak akan tumbuh dengan baik dan proses pembentukan tulang akan melambat. Anak dengan riwayat pertumbuhan tulang yang terhambat dapat menyebabkan stunting (Hary Cahyati *et al.*, 2019). Asupan seng yang tidak memadai juga akan mengurangi produksi dan sekresi IGF-1 (faktor pertumbuhan), yang dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan pada anak (Losong and Adriani, 2017). Anak yang kekurangan asupan seng dan vitamin A rentan mengalami stunting karena vitamin A mengatur sintesis protein. Anak yang kekurangan gizi banyak mengonsumsi protein dari sayur-sayuran dan kacang-kacangan, tetapi sedikit dari protein hewani seperti telur, ikan dan susu. Makanan protein hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, dan susu mengandung kadar protein yang relatif tinggi (40% lebih tinggi) dibandingkan dengan protein dari sumber nabati. Pemberian telur 1 butir perhari selama 6 bulan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan linier dan dapat menurunkan risiko stunting hingga 47% (Iannotti *et al.*, 2017). Penelitian yang dilakukan di pandeglang menunjukkan bahwa pemberian 1 butir telur perhari selama 6 bulan menunjukkan bahwa terjadi penurunan stunting sebesar 11,5% (Farras and Yusnita, 2022). Setiap 15g putih telur terdapat 1300 mg leusin (asam amino terbanyak ketiga di dalam telur). Leusin berfungsi merangsang pertumbuhan otot secara maksimal pada usia muda. Mengonsumsi makanan yang mengandung protein hewani sangat penting untuk mendapatkan jumlah zat besi yang dibutuhkan, yang mendorong pertumbuhan lebih cepat dan menurunkan prevalensi stunting pada anak-anak (Ilmani and Fikawati, 2023). Hal tersebut dikarenakan protein hewani mengandung asam amino esensial yang dapat mensintesis hormon pertumbuhan sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan balita, dapat meningkatkan penyerapan seng dan zat besi, yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak (Sholikhah and Dewi, 2022) dan menghindarkan balita agar tidak mengalami kejadian stunting. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa bahan pangan yang bersumber dari protein hewani dapat mempercepat laju pertumbuhan dan mencegah terjadinya stunting.



Gambar 3.4 Sumber Protein Hewani

Anak-anak yang mengalami stunting mengonsumsi zat gizi dalam jumlah rendah. Kekurangan zat gizi makro dan mikro merupakan faktor terpenting yang memengaruhi status gizi anak di berbagai negara (Verma and Prasad, 2021).

G. Intervensi Gizi Sensitif dan Spesifik dalam Pencegahan Stunting

Upaya percepatan pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi. Intervensi gizi, termasuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kekurangan gizi. Gerakan 1000 hari pertama kehidupan juga menggunakan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik menargetkan penyebab langsung kekurangan gizi, seperti asupan makanan atau praktik pengasuhan anak, dan penyakit infeksi sedangkan intervensi gizi sensitif berfokus pada faktor-faktor yang mendasarinya, seperti ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya (Abdullahi *et al.*, 2021). Umumnya, intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi gizi spesifik terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, Intervensi prioritas: intervensi yang diidentifikasi berdampak secara langsung terhadap pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Kedua, Intervensi pendukung: intervensi yang memiliki dampak tidak langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi dan kesehatan. Intervensi ini dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi. Ketiga, Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu: yaitu intervensi yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu sesuai dengan kondisi, termasuk saat darurat bencana (program gizi darurat). Sedangkan intervensi gizi sensitif melibatkan upaya yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting melalui penyebab tidak langsung dari stunting. Intervensi gizi sensitif mencakup Ketahanan pangan (Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan), Peningkatan akses pangan bergizi, Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, pendidikan, dan Peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Untuk mempercepat penurunan stunting dari tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 92 persen dari total dana yang dialokasikan digunakan untuk intervensi gizi sensitif (BAPPENAS, 2021). Sejak tahun 2022, pemerintah melakukan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan edukasi masyarakat terkait konsumsi makanan sumber hewani sebagai strategi untuk meningkatkan gizi dan kesehatan. Hal ini karena protein yang berasal dari hewan mengandung semua asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan. Selain protein dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhan balita, makanan hewani juga memiliki berbagai zat gizi mikro, seperti zat besi (Ilmani and Fikawati, 2023). Intervensi khusus gizi menangani faktor penyebab langsung gizi, serta perkembangan janin dan anak, asupan makanan dan gizi yang cukup, pemberian makan, perawatan dan praktik pengasuhan, dan rendahnya beban penyakit menular. Ada 11 intervensi spesifik,

meliputi skrining anemia, konsumsi TTD (tablet tambah darah) remaja putri, pemeriksaan kehamilan (ANC), konsumsi TTD ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK), pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian MPASI kaya protein hewani bagi Balita, tata laksana Balita dengan masalah gizi, peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi, edukasi remaja ibu hamil dan keluarga. Intervensi gizi sensitif mengatasi faktor-faktor yang berkaitan dengan gizi dan perkembangan janin dan anak, seperti ketahanan pangan, sumber daya perawatan yang memadai di tingkat ibu, rumah tangga dan Masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dan lingkungan yang aman dan higienis, dan menggabungkan tujuan dan tindakan gizi yang spesifik. Program gizi sensitive dapat berfungsi sebagai platform penyampaian untuk intervensi gizi spesifik, yang berpotensi meningkatkan skala, cakupan, dan efektivitasnya (Goudet *et al.*, 2019). Penurunan stunting merupakan salah satu dari enam tujuan dalam Target Gizi Global tahun 2025 dan indikator kunci menuju Zero-Hunger dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

H. Penutup

Stunting memerlukan prioritas penanganan yang cepat dan tepat karena bukan hanya menjadi masalah di Indonesia tetapi juga masalah yang dihadapi dunia saat ini. Stunting pada anak sebagian besar disebabkan oleh kekurangan gizi, beban penyakit yang tinggi, pemberian makanan anak yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas. Asupan gizi yang cukup sesuai kebutuhan baik kebutuhan makronutrien terutama Protein hewani berperan penting dalam pencegahan atau meminimalisir kejadian stunting pada anak balita, serta kebutuhan mikronutrien seperti Zat Besi, zink, vitamin C, Vitamin A dan kalsium juga berperan penting dalam mencegah terjadinya stunting. Dengan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting pada anak, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak serta mencegah timbulnya masalah kesehatan kronis di kemudian hari.

Referensi

- Abdullahi, L.H. *et al.* (2021) 'Best practices and opportunities for integrating nutrition specific into nutrition sensitive interventions in fragile contexts: a systematic review', *BMC Nutrition*, 7(1), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.1186/s40795-021-00443-1>.
- Afiah, N. *et al.* (2020) 'Rendahnya Konsumsi Protein Hewani Sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Kota Samarinda', *Nutrire Diaita*, 12(1), pp. 23–28.
- Akbar, R.R., Kartika, W. and Khairunnisa, M. (2023) 'The Effect of Stunting on Child Growth and Development', *Scientific Journal*, 2(4), pp. 153–160. Available at: <https://doi.org/10.56260/sciena.v2i4.118>.
- Alba, A.D., Ditte Ayu Suntara and Siska, D. (2021) 'HUBUNGAN RIWAYAT BBLR DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SEKUPANG KOTA BATAM TAHUN 2019', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12).
- BAPPENAS (2021) *Dukungan Pemerintah Pusat dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Perencanaan dan Penganggaran dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting*.
- Basri, H. *et al.* (2021) 'Dietary diversity, dietary patterns and dietary intake are associated with stunted children in Jeneponto District, Indonesia', *Gaceta Sanitaria*, 35, pp. S483–S486. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.077>.
- Bening, S. (2016) 'Asupan Gizi Makro dan Mikro Sebagai Faktor Risiko Stunting Anak Usia 2-5 Tahun di Semarang', *Medica Hospitalia: Journal of Clinical Medicine*, 4(1), pp. 45–50. Available at: <https://doi.org/10.36408/mhjcm.v4i1.245>.
- Ch Rosha, B. *et al.* (2016) 'Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita di Kota Bogor (Roles of Sensitive and Spesific Nutritional Interventions in The Improvement of Nutritional Problems', *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2), pp. 127–138.
- Farras, R.M. and Yusnita, Y. (2022) 'Program One Day One Egg sebagai Upaya Penurunan Stunting di Kabupaten Pandeglang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), pp. 389–396. Available at: <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.645>.
- Fatima, S. *et al.* (2020) 'Stunting and associated factors in children of less than five years: A hospital-based study', *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 36(3). Available at: <https://doi.org/10.12669/pjms.36.3.1370>.

- Goudet, S.M. *et al.* (2019) 'Nutritional interventions for preventing stunting in children (Birth to 59 months) living in urban slums in low-and middle-income countries (LMIC)', *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(6). Available at: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011695.pub2>.
- Hardinsyah (2017) *Ilmu Gizi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hary Cahyati, W. *et al.* (2019) 'Disparity of Risk Factors Stunting on Toddlers in the Coast and the Mountain Areas of Sinjai, South Sulawesi', *Public Health Perspectives Journal*, 4(3), pp. 196–205. Available at: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/phpj>.
- Hasanah, U. *et al.* (2020) 'Water, sanitation dan hygiene analysis, and individual factors for stunting among children under two years in ambon', *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(T2), pp. 22–26. Available at: <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5177>.
- Iannotti, L.L. *et al.* (2017) 'Eggs in early complementary feeding and child growth: A randomized controlled trial', *Pediatrics*, 140(1). Available at: <https://doi.org/10.1542/peds.2016-3459>.
- Ilmani, D.A. and Fikawati, S. (2023) 'Nutrition Intake as a Risk Factor of Stunting in Children Aged 25–30 Months in Central Jakarta, Indonesia', *Jurnal Gizi dan Pangan*, 18(2), pp. 117–126. Available at: <https://doi.org/10.25182/jgp.2023.18.2.117-126>.
- Kartika, C., Suryani, Y.D. and Garna, H. (2020) 'Hubungan Stunting dengan Perkembangan Motorik Kasar dan Halus Anak Usia 2 – 5 Tahun di Desa Panyirapan , Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Correlation between Stunting with Gross and Fine Motor Development of Children Aged 2 – 5 Years Old in Panyirapan ', 2(22), pp. 104–108.
- Kusuma, L. *et al.* (2023) 'Risks of Stunting and Interventions to prevent Stunting', *Journal of Community Engagement in Health*, 6(2), pp. 79–83. Available at: <https://doi.org/10.30994/jceh.v6i2.528>.
- Laksono, A.D. *et al.* (2022) 'Factors Related to Stunting Incidence in Toddlers with Working Mothers in Indonesia', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17). Available at: <https://doi.org/10.3390/ijerph191710654>.
- Losong, N.H.F. and Adriani, M. (2017) 'Perbedaan Kadar Hemoglobin, Asupan Zat Besi, dan Zinc pada Balita Stunting dan Non Stunting', *Amerta Nutrition*, 1(2), p. 117.

Available at: <https://doi.org/10.20473/amnt.v1i2.6233>.

Martiani, M. *et al.* (2021) 'Asupan Zat Besi Berhubungan dengan Perkembangan Anak', *Sari Pediatri*, 23(2), pp. 95–102.

Muliawan, A. *et al.* (2024) 'Handling Stunting as a Management Community Service', *Journal of Loyalty and Community Development*, 1(1), pp. 27–32. Available at: <https://ejournal.mediakunkun.com/index.php/record>.

Prado, E.L. *et al.* (2019) 'Do effects of early life interventions on linear growth correspond to effects on neurobehavioural development? A systematic review and meta-analysis', *The Lancet Global Health*, 7(10), pp. e1398–e1413. Available at: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30361-4](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30361-4).

Ratnalela Srg, I. *et al.* (2021) 'Analisis Kadar Kalsium Dan Magnesium Terhadap Kejadian Stunting Balita Di Puskesmas Titipapan Medan Deli', *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(2), pp. 517–524. Available at: <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i2.1938>.

Roth, D.E. *et al.* (2017) 'Early childhood linear growth faltering in low-income and middle-income countries as a whole-population condition: analysis of 179 Demographic and Health Surveys from 64 countries (1993–2015)', *The Lancet Global Health*, 5(12), pp. e1249–e1257. Available at: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30418-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30418-7).

Sari, E.M. *et al.* (2016) 'Asupan protein, kalsium dan fosfor pada anak stunting dan tidak stunting usia 24-59 bulan', *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 12(4), p. 152. Available at: <https://doi.org/10.22146/ijcn.23111>.

Sari, N.P. *et al.* (2023) 'Asupan Gizi Dan Status Gizi Anak Usia 6-23 Bulan Di Kabupaten Maros', *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 5(2), pp. 660–672. Available at: <https://doi.org/10.35971/jjhsr.v5i2.18617>.

Sholikhah, A. and Dewi, R.K. (2022) 'Peranan Protein Hewani dalam Mencegah Stunting pada Anak Balita', *JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi)*, 6(1), p. 95. Available at: <https://doi.org/10.30595/jrst.v6i1.12012>.

Sianturi, S.R., Alfriyani, M. and Cintya, S. (2023) 'Edukasi Kader Kesehatan dan Ibu Balita Mengenai Stunting dan Makanan Sehat di Kecamatan Johar Baru', *Prosiding SENAPAS*, 1(1), pp. 261–264.

Soliman, A. *et al.* (2021) 'Early and long-term consequences of nutritional stunting: From childhood to adulthood', *Acta Biomedica*, 92(1), pp. 1–12. Available at:

<https://doi.org/10.23750/abm.v9i1.11346>.

- Soraya, S., Ilham, I. and Hariyanto, H. (2022) 'Kajian Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur', *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(2), pp. 98–114. Available at: <https://doi.org/10.22437/jpb.v5i1.21200>.
- Syahrudin, A.N., Irmawati, I. and Sari, N.P. (2023) 'Water Sanitation and Hygiene (WASH) and feeding patterns: Linkages with stunting among children aged 6-23 months', *Action: Aceh Nutrition Journal*, 8(3), p. 466. Available at: <https://doi.org/10.30867/action.v8i3.1007>.
- Verma, P. and Prasad, J.B. (2021) 'Stunting, wasting and underweight as indicators of under-nutrition in under five children from developing Countries: A systematic review', *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews*, 15(5), p. 102243. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2021.102243>.
- Wardani, N.E.K. (2022) 'the Effect of Stunting on the Level of Language Development in Toddlers', *Jurnal Voice of Midwifery*, 12(2), p. 61.
- Wicaksono, R.A. *et al.* (2021) 'Risk factors of stunting in Indonesian children aged 1 to 60 months', *Paediatrica Indonesiana(Paediatrica Indonesiana)*, 61(1), pp. 12–19. Available at: <https://doi.org/10.14238/pi61.1.2021.12-9>.

Glosarium

A

ASI Eksklusif: adalah air susu ibu yang diberikan mulai sejak bayi lahir hingga berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman apapun

B

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah): adalah kondisi Ketika bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram

D

Diabetes: adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang dikenal sebagai diabetes mellitus atau kencing manis

Dislipidemia: adalah kondisi yang ditandai dengan kadar kolesterol, LDL, HDL, dan trigliserida yang tidak normal

H

Hipertensi atau tekanan darah tinggi: adalah kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal (130/80 mmHg atau lebih)

K

KEK (Kekurangan Energi Kronis): adalah kondisi Ketika seseorang mengalami kekurangan asupan gizi (kalori dan protein) dalam jangka waktu lama

Kuratif: adalah istilah yang merujuk pada upaya penyembuhan penyakit atau cedera.

M

MP-ASI (Makanan Pendamping ASI): adalah makanan yang diberikan setelah bayi berusia 6 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi

Morbiditas (Kesakitan): adalah Kondisi yang ditandai dengan penyakit atau kondisi tertentu pada suatu populasi

Mortalitas (Kematian): adalah Jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi

O

Obesitas: adalah kondisi di mana terjadi penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh dan dapat mengganggu kesehatan.

P

Preventif: adalah tindakan pencegahan atau upaya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan

R

Retardasi Pertumbuhan: adalah kondisi ketika pertumbuhan anak atau janin lebih lambat dari yang normal

S

Stunting: adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung lama yang ditandai dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD) dan kurang dari -3SD berdasarkan standar pertumbuhan

T

TTD (Tablet tambah darah): adalah suplemen zat gizi yang mengandung zat besi dan asam folat

BAB IV

DUKUNGAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG ANAK

A. Pendahuluan

Tumbuh kembang anak merupakan proses yang kompleks dan krusial dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran fisik, seperti berat dan tinggi badan, sedangkan perkembangan mencakup aspek motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Pemantauan yang tepat terhadap tumbuh kembang anak memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan atau gangguan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara efektif (Wati, Rismawan & Sriasih, 2024).

Tenaga keperawatan memiliki peran strategis dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari tim kesehatan, perawat berperan dalam pengkajian, deteksi dini, intervensi, serta edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya stimulasi dan pemantauan perkembangan anak. Peran aktif perawat dalam pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak dan mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang yang dapat berdampak jangka panjang (Saepudin et al., 2025).

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tumbuh kembang anak, menjelaskan peran dan tanggung jawab tenaga keperawatan dalam pemantauan tumbuh kembang, serta menyajikan panduan praktis dalam pengkajian, deteksi dini, dan intervensi terhadap gangguan tumbuh kembang. Selain itu, buku ini juga mengulas kebijakan dan regulasi terkait pemantauan tumbuh kembang anak di Indonesia. Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi tenaga keperawatan, pendidik, dan praktisi kesehatan lainnya dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan terkait tumbuh kembang anak.

Dalam penyusunannya, buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar tumbuh kembang anak, peran dan kompetensi perawat dalam pemantauan tumbuh kembang, metode dan instrumen pengkajian tumbuh kembang, hingga intervensi keperawatan dalam stimulasi dan deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Selain itu, pembahasan mengenai kebijakan dan regulasi yang mendukung pemantauan tumbuh kembang anak di Indonesia turut

disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai aspek kebijakan yang melandasi praktik pemantauan ini.

Seiring dengan perkembangan kebijakan kesehatan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pemantauan tumbuh kembang anak. Dalam rentang tahun 2021-2025, beberapa kebijakan yang relevan antara lain Kurikulum Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan bagi Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021. Kurikulum ini menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pemantauan pertumbuhan anak. Selain itu, pada tahun 2024, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia menyelenggarakan workshop online tentang peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan gangguan tumbuh kembang anak. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani gangguan tumbuh kembang, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.

Di samping itu, Kementerian Kesehatan RI juga menyediakan materi orientasi terkait pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui platform digital. Materi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak dan teknik-teknik yang efektif dalam pelaksanaannya. Walaupun beberapa kebijakan utama terkait pemantauan tumbuh kembang anak telah diterbitkan sebelum tahun 2021, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak, namun kebijakan tersebut tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang anak hingga saat ini.

Dengan memahami latar belakang, tujuan, ruang lingkup, serta kebijakan yang mendukung pemantauan tumbuh kembang anak, diharapkan buku ini dapat menjadi panduan komprehensif bagi tenaga keperawatan dalam menjalankan perannya. Dukungan tenaga keperawatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak sangat diperlukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan intervensi yang tepat dan optimal demi mencapai tumbuh kembang yang maksimal.

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Tumbuh kembang anak merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran dan jumlah sel tubuh yang berkontribusi terhadap perubahan fisik, seperti bertambahnya tinggi dan berat badan, lingkar kepala, serta proporsi tubuh secara keseluruhan. Sementara itu, perkembangan merujuk pada pematangan fungsi tubuh yang melibatkan aspek motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Proses tumbuh kembang ini tidak terjadi secara

instan, melainkan melalui tahapan yang saling berkaitan dan berlangsung sejak masa konsepsi hingga dewasa (Barir et al., 2024).

Tumbuh kembang anak adalah hasil interaksi antara faktor genetik, lingkungan, dan stimulasi yang diterima oleh anak selama periode pertumbuhannya. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan pertumbuhan sebagai peningkatan ukuran fisik, sedangkan perkembangan sebagai pematangan fungsi yang mencerminkan kemampuan individu dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Kedua proses ini berlangsung secara simultan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nutrisi, stimulasi psikososial, penyakit, serta faktor genetik yang diturunkan dari orang tua (Indriasari & Pursitasari, 2025).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara sistematis melalui berbagai indikator yang telah ditetapkan, seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta pencapaian *milestone* perkembangan sesuai dengan usia anak. Pemantauan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa anak berkembang sesuai dengan norma yang telah ditetapkan serta untuk mendeteksi secara dini apabila terdapat gangguan tumbuh kembang (Nurhayati et al., 2025).

Tumbuh kembang anak terbagi dalam beberapa tahapan yang memiliki karakteristik unik, yaitu (Indriasari & Pursitasari, 2025):

1. Masa Prenatal (Konsepsi – Lahir).

Pada tahap ini, pertumbuhan dan perkembangan terjadi sangat pesat, dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan. Asupan nutrisi, kesehatan mental ibu, serta paparan terhadap zat berbahaya dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin.

2. Masa Neonatus (Lahir – 28 Hari).

Periode ini merupakan masa adaptasi anak terhadap lingkungan luar rahim. Fungsi fisiologis utama, seperti pernapasan dan sirkulasi darah, mengalami penyesuaian. Pemantauan pada tahap ini mencakup pemeriksaan refleks primitif serta pemantauan berat badan dan lingkar kepala.

3. Masa Bayi (1 Bulan – 1 Tahun).

Periode ini dikenal sebagai masa emas (*golden period*), di mana pertumbuhan berlangsung dengan cepat dan perkembangan otak mencapai 80% dari kapasitas maksimalnya. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan keterampilan motorik, seperti menggenggam, duduk, merangkak, hingga berjalan.

4. Masa *Toddler* (1 – 3 Tahun).

Pada fase ini, anak mulai mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar secara lebih signifikan. Perkembangan bahasa juga mulai terlihat dengan munculnya kata-kata pertama yang dapat dipahami. Selain itu, anak mulai

menunjukkan eksplorasi terhadap lingkungan sekitar dan membentuk interaksi sosial dengan orang di sekitarnya.

5. Masa Prasekolah (3 – 6 Tahun).

Periode ini ditandai dengan perkembangan kemampuan sosial dan emosional yang lebih kompleks. Anak mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, memahami konsep berbagi, serta mengembangkan kreativitas melalui permainan. Stimulasi kognitif sangat diperlukan untuk mendukung kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan formal.

6. Masa Sekolah (6 – 12 Tahun).

Anak mulai mengalami perkembangan kognitif yang pesat, dengan peningkatan kemampuan berpikir logis, membaca, serta menyerap informasi. Selain itu, perkembangan moral dan etika mulai terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

7. Masa Remaja (12 – 18 Tahun).

Periode ini merupakan masa transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang pesat serta perkembangan psikososial yang kompleks. Perubahan hormonal menyebabkan perkembangan karakteristik seksual sekunder, serta munculnya tantangan psikososial seperti pencarian identitas dan kemandirian.

Proses tumbuh kembang anak tidak terjadi secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya (Nurhayati et al., 2025):

1. Faktor Genetik.

Faktor ini menentukan potensi dasar anak, termasuk tinggi badan, warna kulit, dan bakat alami. Namun, ekspresi genetik tetap dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang.

2. Faktor Nutrisi.

Asupan gizi yang cukup, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), sangat menentukan perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, seperti stunting dan gangguan perkembangan kognitif.

3. Faktor Lingkungan.

Lingkungan yang sehat, termasuk akses terhadap air bersih, sanitasi, serta stimulasi yang memadai, berperan penting dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

4. Faktor Stimulasi.

Stimulasi yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar berpengaruh terhadap perkembangan motorik, bahasa, serta kemampuan sosial anak.

Stimulasi yang kurang dapat menghambat pencapaian perkembangan anak sesuai usianya.

5. Faktor Kesehatan.

Penyakit infeksi, kelainan bawaan, serta gangguan kesehatan kronis dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan secara berkala sangat diperlukan untuk mendeteksi dan menangani gangguan kesehatan sedini mungkin.

6. Faktor Psikososial dan Emosional.

Hubungan emosional antara anak dan orang tua atau pengasuh memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Kasih sayang, perhatian, serta lingkungan keluarga yang kondusif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian anak.

Pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara berkala menggunakan berbagai indikator dan metode, antara lain (Wati, Rismawan & Sriasih, 2024):

1. Pemantauan Pertumbuhan: menggunakan kurva pertumbuhan WHO (berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, dan indeks massa tubuh) yang diaplikasikan dalam Kartu Menuju Sehat (KMS).
2. Pemantauan Perkembangan: Menggunakan alat skrining perkembangan seperti Denver II, Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), dan *Bayley Scales of Infant Development* (BSID).
3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala: Meliputi imunisasi, pemeriksaan gizi, serta deteksi dini gangguan tumbuh kembang di fasilitas kesehatan.

Tumbuh kembang anak adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki peran penting dalam pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak agar berjalan optimal. Dengan pemahaman yang baik mengenai konsep dasar tumbuh kembang, diharapkan tenaga keperawatan dapat memberikan intervensi yang tepat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

C. Pola Pengasuhan Anak

Pola pengasuhan merupakan cara orang tua atau pengasuh dalam membimbing, mendidik, dan merawat anak untuk mencapai perkembangan yang optimal. Pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan keterampilan anak di masa depan. Selain itu, pola pengasuhan juga berdampak pada aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga sebagai

sistem pertama yang membentuk nilai, kebiasaan, dan pola interaksi sosial. Orang tua yang mampu memberikan pola pengasuhan yang baik akan membantu anak berkembang secara optimal, baik dari segi kesehatan, kecerdasan, maupun kepribadian. Pola pengasuhan tidak terbentuk secara instan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang berperan dalam membentuk pola pengasuhan adalah (Gannika et al., 2025):

1. Faktor Budaya dan Sosial.

Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang memengaruhi bagaimana anak diasuh dan dididik. Misalnya, dalam budaya kolektivistik, seperti di Indonesia, pola asuh sering kali melibatkan keluarga besar, sementara dalam budaya individualistik, pola asuh lebih berfokus pada otonomi anak.

2. Faktor Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua.

Tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi pola asuh. Orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya stimulasi dalam perkembangan anak, sedangkan kondisi ekonomi yang kurang baik dapat membatasi akses terhadap fasilitas pendukung tumbuh kembang anak.

3. Faktor Psikologis dan Emosional Orang Tua.

Kesehatan mental dan kondisi emosional orang tua berpengaruh besar terhadap cara mereka mengasuh anak. Orang tua yang memiliki tingkat stres tinggi atau mengalami masalah psikologis dapat mengalami kesulitan dalam memberikan pola asuh yang sehat dan mendukung perkembangan anak.

4. Faktor Lingkungan dan Teknologi.

Kemajuan teknologi dan paparan media digital juga berperan dalam membentuk pola pengasuhan modern. Orang tua saat ini harus lebih bijak dalam mengatur penggunaan teknologi agar tidak menghambat perkembangan sosial dan emosional anak.

Beberapa pendekatan utama dalam pola pengasuhan meliputi:

1. Pola Asuh Otoriter.

Pola asuh ini ditandai dengan kontrol yang tinggi dari orang tua serta penerapan aturan yang ketat tanpa memberikan ruang diskusi bagi anak. Anak yang diasuh secara otoriter cenderung kurang percaya diri, memiliki keterampilan sosial yang rendah, serta kurang mampu mengambil keputusan secara mandiri.

2. Pola Asuh Permisif.

Dalam pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa adanya aturan yang jelas. Anak yang tumbuh dalam pola asuh ini cenderung kurang disiplin, sulit mengendalikan emosi, serta kurang memahami batasan dalam interaksi sosial.

3. Pola Asuh Demokratis.

Pola asuh ini mengutamakan keseimbangan antara kebebasan dan aturan. Orang tua memberikan bimbingan dengan komunikasi terbuka dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berpendapat. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis cenderung lebih mandiri, percaya diri, serta memiliki keterampilan sosial yang baik.

4. Pola Asuh Abai (*Neglectful*).

Pola asuh ini terjadi ketika orang tua kurang terlibat dalam pengasuhan anak, baik secara emosional maupun fisik. Anak yang mengalami pola asuh abai sering kali menghadapi masalah dalam perkembangan emosional dan akademik serta memiliki risiko tinggi terhadap gangguan perilaku.

Setiap pola pengasuhan memberikan dampak yang berbeda terhadap tumbuh kembang anak. Pola asuh yang baik akan membantu anak berkembang secara optimal, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Sebaliknya, pola asuh yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai permasalahan perkembangan, seperti rendahnya kepercayaan diri, kesulitan dalam membangun hubungan sosial, serta risiko gangguan psikologis di kemudian hari.

Orang tua, sebagai pengasuh utama, memiliki peran krusial dalam membentuk pola asuh yang sehat. Keseimbangan antara kasih sayang, disiplin, dan dukungan emosional sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, keterlibatan anggota keluarga lain, seperti kakek, nenek, dan saudara kandung, juga dapat memberikan dampak positif dalam proses pengasuhan.

Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak menjadi faktor penting dalam membangun pola asuh yang sehat. Orang tua perlu mendengarkan anak dengan empati, memberikan arahan yang jelas, serta menerapkan disiplin dengan cara yang konstruktif. Untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, beberapa strategi pengasuhan yang dapat diterapkan antara lain (Nurhayati et al., 2025):

1. Memberikan Stimulasi yang Sesuai.

Orang tua perlu memastikan bahwa anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya, seperti bermain edukatif, membaca buku, dan berinteraksi sosial dengan teman sebaya.

2. Membangun Lingkungan yang Mendukung.

Lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang akan membantu anak merasa aman dan nyaman dalam bereksplorasi serta belajar hal-hal baru.

3. Menerapkan Disiplin Positif.

Disiplin tidak harus dilakukan dengan hukuman yang keras, tetapi dengan pendekatan positif seperti memberi contoh yang baik, memberikan pujian atas perilaku baik, serta menjelaskan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan anak.

4. Menggunakan Komunikasi yang Empatik.

Komunikasi yang terbuka dan penuh empati akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik serta meningkatkan rasa percaya diri mereka.

5. Memanfaatkan Teknologi Secara Bijak.

Penggunaan teknologi dalam pengasuhan harus dilakukan dengan bijak agar anak tetap mendapatkan manfaat dari teknologi tanpa kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar.

Tenaga keperawatan memiliki peran penting dalam mendukung orang tua dan keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan yang sehat. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh tenaga keperawatan meliputi (Lusiani et al., 2025):

1. Edukasi kepada Orang Tua.

Tenaga keperawatan dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pola asuh yang tepat serta cara-cara membangun hubungan yang baik dengan anak.

2. Konseling bagi Keluarga.

Dalam beberapa kasus, keluarga menghadapi tantangan dalam pengasuhan anak. Tenaga keperawatan dapat memberikan konseling untuk membantu orang tua mengatasi masalah yang dihadapi.

3. Deteksi Dini Masalah Psikososial.

Tenaga keperawatan dapat membantu mengidentifikasi masalah psikososial yang mungkin muncul akibat pola pengasuhan yang kurang optimal, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal.

4. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain.

Dalam mendukung kesejahteraan anak, tenaga keperawatan dapat bekerja sama dengan dokter, psikolog, dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak.

Pola pengasuhan memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Orang tua dan keluarga perlu memahami berbagai jenis pola asuh serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Dengan dukungan dari tenaga keperawatan, diharapkan setiap keluarga dapat menerapkan pola pengasuhan yang optimal demi masa depan anak yang lebih baik.

D. Implementasi Deteksi dan Intervensi Dini Pertumbuhan Anak

Deteksi dini pertumbuhan anak merupakan langkah penting dalam upaya memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat adanya gangguan pertumbuhan, seperti keterlambatan tinggi badan, berat badan yang tidak sesuai usia, atau tanda-tanda gizi buruk. Dengan melakukan deteksi dini, tenaga kesehatan, terutama tenaga keperawatan, dapat melakukan intervensi yang tepat guna mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kualitas hidup anak.

Prinsip dasar dalam deteksi dini pertumbuhan meliputi pemantauan berkala, penggunaan indikator pertumbuhan yang valid, serta keterlibatan orang tua dan tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan dan intervensi yang diperlukan. Deteksi dini juga harus dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan organisasi kesehatan dunia seperti WHO dan UNICEF.

Dalam pemantauan pertumbuhan anak, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi apakah pertumbuhan anak sesuai dengan standar perkembangan yang diharapkan. Indikator utama yang digunakan meliputi (Saepudin et al., 2025):

1. Antropometri
 - a. Berat badan menurut umur (BB/U) digunakan untuk menilai status gizi anak. Berat badan yang kurang dari standar menunjukkan adanya risiko malnutrisi.
 - b. Tinggi badan menurut umur (TB/U) digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan kronis, seperti stunting.
 - c. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dapat mengidentifikasi apakah anak mengalami gizi kurang, gizi baik, atau obesitas.
 - d. Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut umur digunakan untuk menilai status gizi berdasarkan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan.
2. Indikator tambahan
 - a. Lingkar kepala dan lingkar lengan atas (LiLA) merupakan indikator penting untuk mendeteksi malnutrisi akut pada anak.
 - b. Perkembangan motorik dan kognitif juga menjadi aspek penting dalam pertumbuhan anak yang perlu dipantau secara berkala.

Deteksi dini pertumbuhan anak dilakukan dengan berbagai metode dan instrumen yang telah terstandarisasi. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi (Puspanelli et al., 2025):

1. Pengukuran antropometri, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas.

2. Penggunaan Kurva Pertumbuhan WHO dan Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk memantau perkembangan anak dari waktu ke waktu.
3. Skrining tumbuh kembang anak dengan metode Denver II, yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan motorik, bahasa, dan sosial-emosional anak.
4. Evaluasi perkembangan sosial-emosional anak untuk menilai keterampilan interaksi sosial dan kemandirian anak sesuai usianya.

Dalam mendukung deteksi dini, berbagai instrumen juga digunakan, seperti Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang berisi data perkembangan anak, aplikasi pemantauan pertumbuhan berbasis digital, serta alat ukur pertumbuhan seperti timbangan digital dan pita LiLA.

Jika ditemukan adanya indikasi gangguan pertumbuhan, intervensi dini harus segera dilakukan untuk mencegah dampak lebih lanjut. Intervensi ini mencakup berbagai aspek, antara lain (Puspanelli et al., 2025):

1. Intervensi gizi
 - a. Pemenuhan kebutuhan makronutrien dan mikronutrien sesuai dengan rekomendasi kesehatan.
 - b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak yang berisiko mengalami gizi buruk.
 - c. Suplementasi zat besi, vitamin A, dan zinc untuk mendukung pertumbuhan optimal.
2. Stimulasi pertumbuhan dan perkembangan
 - a. Pemberian stimulasi motorik dan kognitif sesuai dengan usia anak.
 - b. Penerapan pola makan berbasis *responsive feeding*, yaitu pemberian makan yang responsif terhadap kebutuhan dan sinyal lapar anak.
 - c. Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pola asuh yang mendukung pertumbuhan anak.
3. Pendekatan berbasis layanan kesehatan
 - a. Optimalisasi peran Posyandu dan Puskesmas dalam pemantauan pertumbuhan anak.
 - b. Keterlibatan tenaga keperawatan dalam memberikan edukasi kepada orang tua serta melakukan rujukan jika diperlukan.
 - c. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter anak dan ahli gizi, untuk memastikan intervensi yang komprehensif.

Dalam implementasi deteksi dan intervensi dini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.

2. Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang menghambat akses layanan pemantauan pertumbuhan.
3. Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan pendidikan orang tua, yang berpengaruh terhadap pemenuhan gizi anak.
4. Minimnya edukasi tentang pola asuh dan gizi seimbang, yang menyebabkan orang tua tidak menyadari pentingnya asupan gizi dalam tumbuh kembang anak.

Tenaga keperawatan memiliki peran strategis dalam deteksi dan intervensi dini pertumbuhan anak, antara lain (Fatmawati et al., 2024; Manalu, 2024):

1. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan gizi seimbang.
2. Melakukan skrining dan pemantauan pertumbuhan anak secara berkala di fasilitas kesehatan maupun dalam kunjungan rumah.
3. Mengidentifikasi risiko gangguan pertumbuhan serta melakukan rujukan jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan.
4. Berperan dalam kolaborasi interprofesional, bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memastikan pertumbuhan anak yang optimal.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah beberapa contoh penerapan deteksi dan intervensi dini dalam pemantauan pertumbuhan anak:

1. Studi kasus intervensi gizi, seorang anak berusia 2 tahun dengan status gizi kurang mendapatkan intervensi berupa pemberian PMT, edukasi kepada orang tua, serta pemantauan pertumbuhan secara berkala.
2. Implementasi program deteksi dini di Posyandu, program yang dilakukan di salah satu Posyandu menunjukkan peningkatan kesadaran orang tua dalam membawa anaknya untuk ditimbang dan dipantau tumbuh kembangnya.
3. Model intervensi berbasis komunitas, program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kader kesehatan dan ibu-ibu dalam pemantauan tumbuh kembang anak menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan status pertumbuhan anak di suatu daerah.

Deteksi dan intervensi dini pertumbuhan anak merupakan langkah penting dalam memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Implementasi program ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan peran tenaga kesehatan dalam pemantauan pertumbuhan serta penguatan kebijakan yang mendukung layanan deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia.

E. Implementasi Deteksi dan Intervensi Dini Perkembangan Anak

Perkembangan anak merupakan proses dinamis yang mencakup berbagai aspek, seperti motorik, bahasa, sosial-emosional, dan kognitif. Deteksi dan intervensi dini perkembangan anak adalah suatu upaya sistematis untuk mengidentifikasi gangguan perkembangan sejak usia dini agar dapat diberikan intervensi yang tepat sebelum kondisi semakin kompleks. Deteksi dini bertujuan untuk mengenali keterlambatan atau gangguan perkembangan sedini mungkin, sehingga intervensi dapat diberikan guna memaksimalkan potensi anak.

Pentingnya pemantauan perkembangan anak tidak terlepas dari fakta bahwa periode emas (golden period) pada 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa krusial dalam membentuk kemampuan kognitif dan sosial anak. Jika gangguan perkembangan tidak terdeteksi dan diintervensi secara tepat waktu, maka dapat berdampak pada keterbatasan fungsi anak di masa depan. Oleh karena itu, implementasi deteksi dan intervensi dini harus menjadi bagian integral dalam layanan kesehatan anak, baik di fasilitas kesehatan maupun di lingkungan keluarga.

Setiap anak memiliki pola perkembangan yang unik, namun terdapat indikator standar yang digunakan untuk menilai apakah perkembangan anak sesuai dengan usianya. Indikator perkembangan anak meliputi beberapa aspek utama, yaitu (Wati, Rismawan & Sriasih 2024; Sutrisna et al., 2024):

1. Perkembangan motorik kasar, seperti kemampuan berguling, duduk, berdiri, dan berjalan.
2. Perkembangan motorik halus, yang melibatkan keterampilan tangan dan koordinasi mata-tangan, seperti menggenggam benda, mencoret-coret, dan mengancingkan baju.
3. Perkembangan bahasa dan komunikasi, termasuk pemahaman dan penggunaan kata-kata serta kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal.
4. Perkembangan sosial-emosional, yang mencerminkan interaksi dengan orang lain, pengenalan emosi, dan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
5. Perkembangan kognitif, yang meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami konsep dasar.

Standar perkembangan anak telah ditetapkan oleh berbagai organisasi kesehatan, seperti Kementerian Kesehatan RI dan WHO, yang menjadi acuan dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain faktor genetik, berbagai faktor lingkungan seperti pola asuh, status gizi, stimulasi, dan kesehatan ibu saat kehamilan juga berkontribusi dalam menentukan capaian perkembangan anak.

Untuk mengidentifikasi perkembangan anak, berbagai metode dan instrumen telah dikembangkan. Skrining perkembangan dilakukan dengan alat ukur yang telah terstandarisasi guna memastikan hasil yang valid dan reliabel. Beberapa instrumen yang umum digunakan dalam deteksi dini perkembangan anak antara lain:

1. *Denver II Developmental Screening Test* (DDST), yang digunakan untuk menilai keterampilan motorik, bahasa, dan sosial anak pada berbagai rentang usia.
2. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP), yang diterapkan dalam layanan kesehatan primer untuk menilai perkembangan anak berdasarkan pertanyaan yang dijawab oleh orang tua.
3. *Ages and Stages Questionnaire* (ASQ-3), yang membantu orang tua dan tenaga kesehatan dalam menilai perkembangan anak secara lebih rinci.
4. *Modified Checklist for Autism in Toddlers* (M-CHAT), yang digunakan untuk mendeteksi risiko gangguan spektrum autisme pada anak usia dini.
5. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sebagai alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mudah diakses oleh orang tua dan tenaga kesehatan.

Selain penggunaan instrumen, metode lain seperti observasi langsung, wawancara dengan orang tua, dan tes stimulasi dapat digunakan untuk memastikan perkembangan anak berjalan sesuai dengan usianya.

Intervensi dini merupakan langkah kritis dalam membantu anak yang mengalami keterlambatan perkembangan agar dapat mengejar ketertinggalannya. Intervensi dilakukan berdasarkan area perkembangan yang mengalami keterlambatan, seperti:

1. Stimulasi motorik kasar dan halus, yang melibatkan aktivitas fisik untuk memperkuat otot dan koordinasi gerakan.
2. Stimulasi bahasa dan komunikasi, dengan memberikan rangsangan berbicara, membaca cerita, atau bermain peran bersama anak.
3. Stimulasi sosial-emosional, melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar guna membangun rasa percaya diri dan kemandirian.
4. Stimulasi kognitif, yang melibatkan aktivitas berpikir dan pemecahan masalah seperti bermain puzzle atau menggambar.

Orang tua dan lingkungan memiliki peran besar dalam mendukung perkembangan anak melalui interaksi yang kaya akan stimulasi. Edukasi kepada keluarga tentang pentingnya stimulasi perkembangan sejak dini perlu diperkuat agar intervensi dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, tenaga kesehatan berperan dalam mendukung deteksi dan intervensi dini melalui layanan berbasis fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, dan

rumah sakit. Kolaborasi multidisiplin antara dokter anak, perawat, terapis, dan psikolog anak sangat diperlukan dalam menangani keterlambatan perkembangan yang lebih kompleks.

Meskipun deteksi dan intervensi dini perkembangan anak memiliki manfaat yang besar, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemantauan perkembangan anak secara berkala.
2. Keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih dalam melakukan deteksi dini perkembangan di layanan kesehatan primer.
3. Hambatan sosial dan budaya, seperti stigma terhadap anak dengan keterlambatan perkembangan yang menyebabkan keterlambatan dalam mencari bantuan.
4. Keterbatasan akses terhadap layanan deteksi perkembangan, terutama di daerah terpencil yang minim fasilitas kesehatan.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan tenaga kesehatan, serta pemerataan akses layanan kesehatan menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan peran yang kuat dalam pemantauan dan intervensi dini, tenaga keperawatan dapat berkontribusi dalam mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak. Perawat memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi deteksi dan intervensi dini perkembangan anak. Peran tersebut meliputi (Indriasari & Pursitasari, n.d.; Supri & Zulfira, 2024):

1. Edukasi kepada orang tua mengenai stimulasi perkembangan anak dan pentingnya deteksi dini.
2. Skrining perkembangan anak secara berkala dalam layanan kesehatan primer dan komunitas.
3. Pendampingan keluarga dalam memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.
4. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter anak, terapis okupasi, dan psikolog untuk memastikan pendekatan intervensi yang holistik.

Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan deteksi dan intervensi dini dalam menangani keterlambatan perkembangan anak. Misalnya, program stimulasi dini berbasis komunitas di Posyandu yang telah membantu meningkatkan kemampuan sosial-emosional anak melalui permainan interaktif. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam memberikan stimulasi berbasis aktivitas sehari-hari juga terbukti efektif dalam mempercepat perkembangan motorik dan bahasa anak.

Deteksi dan intervensi dini perkembangan anak merupakan aspek penting dalam memastikan anak tumbuh dengan optimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran, penyediaan layanan kesehatan yang merata, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam mengimplementasikan program pemantauan perkembangan anak secara komprehensif.

F. Peran Tenaga Keperawatan dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Anak

Pemantauan tumbuh kembang anak merupakan aspek penting dalam memastikan anak mencapai potensi optimalnya, baik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Tenaga keperawatan, sebagai bagian dari tim kesehatan, memiliki peran strategis dalam mendukung upaya ini, mulai dari deteksi dini, pemberian edukasi, hingga intervensi yang tepat untuk mencegah gangguan tumbuh kembang anak.

Dalam sistem kesehatan, perawat memiliki posisi yang dekat dengan individu, keluarga, dan komunitas, sehingga mereka berperan sebagai penghubung utama dalam mengedukasi dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Peran ini semakin krusial mengingat bahwa periode emas pertumbuhan anak (1.000 hari pertama kehidupan) menjadi masa kritis dalam pembentukan fondasi kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, tenaga keperawatan dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melakukan pemantauan, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Agar dapat berperan secara maksimal dalam pemantauan tumbuh kembang anak, tenaga keperawatan harus memiliki beberapa kompetensi dasar, antara lain (Barir et al., 2024; Gannika et al., 2025; Nurhayati et al., 2025):

1. Kompetensi dalam asesmen tumbuh kembang
 - a. Mampu mengukur parameter pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, serta indeks massa tubuh.
 - b. Mampu melakukan skrining perkembangan dengan menggunakan instrumen standar seperti KPSP, DDST, atau ASQ-3.
2. Kompetensi dalam edukasi dan komunikasi
 - a. Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang secara berkala.
 - b. Mengajarkan orang tua cara memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia anak.
 - c. Membangun hubungan terapeutik dengan keluarga untuk meningkatkan kesadaran terhadap tumbuh kembang anak.
3. Kompetensi dalam deteksi dini dan intervensi

- a. Mengidentifikasi keterlambatan tumbuh kembang berdasarkan parameter yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan rujukan ke tenaga medis atau spesialis bila ditemukan adanya indikasi gangguan tumbuh kembang.
- c. Berpartisipasi dalam program intervensi berbasis komunitas seperti stimulasi perkembangan anak di Posyandu atau pusat layanan kesehatan anak.
4. Kompetensi dalam kolaborasi lintas profesi
 - a. Berkoordinasi dengan dokter anak, ahli gizi, psikolog, dan fisioterapis dalam menangani gangguan tumbuh kembang anak.
 - b. Mengembangkan pendekatan *interprofessional education* (IPE) dalam mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak.

Pertumbuhan anak mencakup peningkatan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala yang dapat diukur secara objektif. Dalam pemantauan pertumbuhan anak, tenaga keperawatan memiliki peran sebagai berikut (Fatmawati et al., 2024; Supri & Zulfira, 2024):

1. Melakukan pengukuran pertumbuhan secara berkala, perawat bertugas mencatat parameter pertumbuhan anak dan membandingkannya dengan kurva pertumbuhan standar WHO atau Kementerian Kesehatan RI.
2. Mengidentifikasi risiko gangguan pertumbuhan, dengan mengamati tren pertumbuhan anak, perawat dapat mendeteksi apakah anak mengalami gizi buruk, obesitas, atau gangguan pertumbuhan lainnya seperti stunting.
3. Memberikan edukasi kepada orang tua, perawat memberikan informasi mengenai pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif, serta pemenuhan nutrisi yang optimal sesuai usia anak.
4. Melakukan intervensi berbasis komunitas, perawat dapat terlibat dalam program Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), dan kampanye kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak.

Selain aspek pertumbuhan, perawat juga memiliki peran penting dalam pemantauan perkembangan anak, yang meliputi aspek motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Peran tersebut meliputi:

1. Melakukan skrining perkembangan anak, dengan menggunakan alat skrining seperti KPSP, DDST, atau ASQ-3, perawat dapat mengidentifikasi keterlambatan perkembangan sejak dini.
2. Memberikan stimulasi perkembangan, perawat mengajarkan orang tua bagaimana memberikan stimulasi yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan motorik, bahasa, dan kognitif anak.

3. Melakukan edukasi kepada keluarga, memberikan pemahaman tentang pentingnya bermain sebagai media belajar anak, serta interaksi sosial yang sehat untuk perkembangan emosionalnya.
4. Membantu dalam program intervensi bagi anak dengan keterlambatan perkembangan, perawat dapat memberikan intervensi awal atau merujuk anak ke layanan rehabilitasi atau terapi khusus bila diperlukan.

Tenaga keperawatan dapat menjalankan perannya dalam pemantauan tumbuh kembang anak di berbagai fasilitas layanan kesehatan, baik di tingkat primer, sekunder, maupun tersier. Beberapa implementasi peran keperawatan berdasarkan tingkat layanan kesehatan meliputi (Fatmawati et al., 2024; Gannika et al., 2025):

1. Di layanan kesehatan primer (Posyandu, Puskesmas, dan praktik mandiri perawat)
 - a. Melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin.
 - b. Memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan orang tua tentang pentingnya stimulasi dini.
 - c. Melakukan home visit untuk memastikan anak mendapatkan stimulasi yang cukup dari lingkungan rumah.
2. Di layanan kesehatan sekunder (Rumah sakit tipe C dan B, klinik spesialis anak)
 - a. Berkolaborasi dengan dokter spesialis anak dalam pemantauan tumbuh kembang anak dengan risiko tinggi.
 - b. Mengelola kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti stunting, keterlambatan bicara, dan gangguan sensorik-motorik.
3. Di layanan kesehatan tersier (Rumah sakit rujukan, pusat rehabilitasi anak)
 - a. Berperan dalam tim multidisiplin untuk menangani gangguan tumbuh kembang kompleks.
 - b. Melaksanakan program rehabilitasi tumbuh kembang bersama terapis okupasi, psikolog, dan ahli gizi.

Meskipun tenaga keperawatan memiliki peran penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi peran tersebut, antara lain:

1. Kurangnya tenaga perawat yang memiliki pelatihan khusus dalam tumbuh kembang anak.
2. Terbatasnya fasilitas dan alat skrining tumbuh kembang di layanan kesehatan primer.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang sejak dini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Peningkatan kompetensi tenaga keperawatan melalui pelatihan dan sertifikasi dalam bidang tumbuh kembang anak.
2. Penguatan layanan tumbuh kembang berbasis komunitas dengan meningkatkan peran Posyandu dan kader kesehatan dalam mendukung pemantauan tumbuh kembang anak.
3. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala.
4. Pengembangan kebijakan berbasis bukti yang mendukung peran tenaga keperawatan dalam program kesehatan anak.

Tenaga keperawatan memiliki peran strategis dalam pemantauan tumbuh kembang anak, baik dari aspek pertumbuhan maupun perkembangan. Dengan kompetensi yang memadai, perawat dapat melakukan deteksi dini, memberikan edukasi kepada orang tua, serta berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memastikan anak tumbuh dengan optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga keperawatan serta dukungan kebijakan yang kuat sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi pemantauan tumbuh kembang anak di berbagai layanan kesehatan.

G. Simpulan

Pemantauan tumbuh kembang anak merupakan aspek fundamental dalam memastikan setiap anak mencapai potensi optimalnya, baik dari segi pertumbuhan fisik maupun perkembangan psikososial dan kognitif. Deteksi dan intervensi dini menjadi kunci utama dalam mencegah serta mengatasi gangguan yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, tenaga keperawatan memainkan peran sentral sebagai fasilitator, edukator, serta pelaksana intervensi yang berbasis bukti di berbagai tingkat layanan kesehatan.

Sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi langsung dengan individu, keluarga, dan komunitas, perawat memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan asesmen, edukasi, serta pendampingan kepada orang tua terkait tumbuh kembang anak. Dengan kompetensi yang mencakup pengukuran pertumbuhan, skrining perkembangan, serta pemberian intervensi berbasis komunitas, tenaga keperawatan dapat berperan aktif dalam memastikan anak-anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dan deteksi dini apabila terjadi keterlambatan atau gangguan dalam tumbuh kembangnya.

Namun demikian, implementasi peran tenaga keperawatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan, seperti peningkatan kompetensi tenaga keperawatan melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi layanan kesehatan berbasis komunitas, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

Dukungan kebijakan dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi, program nasional, maupun penyediaan fasilitas yang memadai, menjadi faktor krusial dalam memperkuat sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Dengan adanya sinergi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan pemerintah, diharapkan setiap anak dapat memperoleh kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Referensi

- Barir, B., Fatmawati, Z., K, D. Y., & Aini, I. (2024). Parenting Edukasi Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah di RA Syafaat Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Seminar Nasional Sains, Kesehatan, Dan Pembelajaran 3, ISSN 2963-1890*, 37–42.
- Fatmawati, A., Saleh, A., Kolomboy, F., & Ndama, M. (2024). Pemberdayaan Kader Posyandu Dalam Stimulasi , Deteksi , dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Toaya Kab . Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *7*(5), 1847–1861. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.1615>
- Gannika, L., Priscilia, M., & Rotty, F. (2025). Pelatihan Kader Posyandu Untuk Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita Di Kota Manado. *4*(2), 193–200.
- Indriasari, F. N., & Pursitasari, I. (2025). *Bunga Rampai: Keperawatan Anak: Kesehatan Mental Dan Perilaku*.
- Mawarni Manalu, K. (2024). Peran Posyandu Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak. *9*. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIPFISIP
- Ni Luh Gede Diana Wati, Made Rismawan, N. K. Sriasih. (2024). Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia 6-24 Bulan. *Jurnal Gema Keperawatan*, *17*(2), 37–46.
- Nurhayati, R., Utami, R. B., Anisa, N., & Zanah, M. (2025). Edukasi Tindakan Pencegahan Stunting pada Ibu dengan Balita Usia 2-5 Tahun di Posyandu Nanas Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. *2*(4), 3455–3459.
- Puspanelli, I., Khotijah, N. S., & Kartiyani, T. (n.d.). Program Penanganan Stunting Pada Balita , Ibu Hamil Dan Remaja
- Saepudin, D. Y., Muksin, N. N., Nugraha, I., & Adimiharja, R. (2025). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kota Sukabumi. *8*(1), 135–148.
- Sosial, J., Lusiani, E., Amalia, M., & Holizah, S. N. (2025). Pengalaman Ibu dalam Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dengan Pemanfaatan Aplikasi Mobile health : Kualitatif Eksploratif. *5*(1), 85–94.
- Supri, A., & Zulfira, R. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Balita di Posyandu. *3*(1), 5–13.
- Sutrisna, I. P. G., Rismawan, M., & Nita Sari, N. K. A. (2024). Pengaruh Media Gambar Berseri Terhadap Kemampuan Bercerita Pada Anak Di Taman Kanak-Kanak Sudha Kumara Denpasar. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *7*(1), 89–97. <https://doi.org/10.37329/cetta.v7i1.3045>

Glosarium

ASQ-3 (Ages and Stages Questionnaires-3), Instrumen skrining perkembangan anak usia dini yang digunakan untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan pada anak.

BB/TB (Berat Badan per Tinggi Badan), Indikator status gizi yang digunakan untuk menilai proporsi berat badan terhadap tinggi badan seorang anak.

BB/U (Berat Badan per Umur), Indikator status gizi yang membandingkan berat badan anak dengan standar berat badan menurut umur.

BSID (Bayley Scales of Infant Development), Alat penilaian perkembangan anak usia dini yang mengukur kognitif, motorik, dan bahasa.

DDST (Denver Developmental Screening Test), Tes skrining perkembangan anak yang menilai keterampilan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial.

HPK (Hari Pertama Kehidupan), Periode kritis dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan.

IMT (Indeks Massa Tubuh), Indikator status gizi yang dihitung berdasarkan berat badan (kg) dibagi dengan kuadrat tinggi badan (m^2).

KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Program pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak.

KMS (Kartu Menuju Sehat), Kartu pemantauan pertumbuhan anak yang digunakan di posyandu dan layanan kesehatan lainnya.

KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan), Alat skrining sederhana untuk menilai perkembangan anak berdasarkan usia.

LiLA (Lingkar Lengan Atas), Pengukuran antropometri yang digunakan untuk menilai status gizi pada ibu hamil dan anak.

M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), Kuesioner skrining dini untuk mendeteksi risiko gangguan spektrum autisme pada anak usia 16-30 bulan.

TB/U (Tinggi Badan per Umur), Indikator status gizi yang digunakan untuk menilai apakah anak mengalami stunting (pendek untuk usianya).

BAB V

PENANGANAN MEDIS PADA ANAK DENGAN KONDISI STUNTING

A. Pendahuluan

Masalah malnutrisi masih menjadi tantangan global yang signifikan, terutama bagi bayi dan anak di bawah usia lima tahun (balita). Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tahun 2020, tercatat bahwa 5,7% balita mengalami kelebihan gizi, 6,7% mengalami gizi kurang dan buruk, serta 22,2% atau sekitar 149,2 juta balita mengalami stunting. WHO mengkategorikan prevalensi stunting di atas 20% sebagai angka yang masih tergolong tinggi. Di Indonesia, data mengenai stunting belum sepenuhnya mengidentifikasi apakah penyebab utamanya berasal dari kekurangan nutrisi atau faktor lain seperti genetika, hormon, atau faktor keturunan.

Stunting sendiri merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. WHO menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena kombinasi asupan gizi yang kurang serta kebutuhan nutrisi yang meningkat tetapi tidak terpenuhi. Berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, pemahaman yang kurang mengenai pola makan balita, serta terbatasnya akses pada protein hewani dalam Makanan Pendamping ASI (MPASI) menjadi pemicu utama kurangnya asupan gizi anak. Selain itu, aspek budaya dan ketersediaan bahan pangan di lingkungan sekitar turut berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Kebutuhan nutrisi anak juga meningkat ketika menghadapi kondisi medis tertentu, seperti kelainan jantung bawaan, alergi susu sapi, bayi dengan berat lahir rendah, gangguan metabolisme, serta infeksi kronis yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti tuberkulosis (TBC), difteri, pertusis, dan campak, juga memperberat kebutuhan gizi anak. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih rentan terhadap TBC akibat lemahnya daya tahan tubuh. Penelitian di 22 negara dengan beban kasus TBC tinggi menunjukkan bahwa 26% kasus TBC berkaitan dengan malnutrisi. Di Indonesia, prevalensi TBC pada anak stunting mencapai 38,1%.

Stunting biasanya diawali dengan perlambatan kenaikan berat badan (weight faltering) yang bisa dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut setelah lahir. Penelitian di Malawi menemukan bahwa bayi yang lahir dengan panjang badan lebih pendek cenderung mengalami gangguan pertumbuhan panjang badan (length

faltering) selama masa bayi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlambatan pertumbuhan selama tiga bulan pertama kehidupan menjadi indikator utama stunting pada usia 12 bulan. Jika rata-rata berat badan bayi dalam tiga bulan pertama lebih rendah dari -1 standar deviasi (SD), maka risiko stunting pada usia 12 bulan meningkat hingga 14 kali lipat.

Dampak jangka panjang dari stunting sangatlah luas, mulai dari peningkatan risiko penyakit dan kematian, melemahnya sistem imun, hingga tingginya kerentanan terhadap infeksi. Selain itu, stunting juga menghambat perkembangan kognitif dan fisik anak, yang berakibat pada penurunan kapasitas kerja serta status sosial ekonomi di masa depan. Anak dengan stunting juga cenderung mengalami gangguan metabolisme lemak, sehingga lebih rentan mengalami akumulasi lemak di bagian perut dan resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dislipidemia, dan gangguan fungsi reproduksi.

Di Indonesia, stunting masih menjadi permasalahan gizi yang belum terselesaikan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi balita pendek dan sangat pendek mencapai 37,2% pada 2013, menurun menjadi 30,8% pada 2018. Pada kelompok baduta, prevalensi juga turun dari 32,8% di tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilakukan di 34 provinsi mencatat bahwa angka stunting nasional turun dari 27,7% pada 2019 menjadi 24,4% pada 2021. Meski terjadi penurunan, angka ini masih tergolong tinggi dan berpotensi meningkat kembali akibat keterbatasan akses pangan dan nutrisi selama pandemi COVID-19. Global Hunger Index (GHI) 2021 juga mencatat Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 116 negara dengan skor kelaparan kategori moderat, yang dinilai berdasarkan prevalensi wasting dan stunting pada balita.

Tingginya angka stunting di Indonesia dan dampak jangka panjang yang ditimbulkannya terhadap kualitas sumber daya manusia menegaskan urgensi perlunya kebijakan yang menyeluruh. Pemahaman yang mendalam dari tenaga kesehatan tentang pencegahan, deteksi dini, dan penanganan stunting pada bayi dan balita sangatlah penting untuk memutus rantai stunting di masa mendatang.

B. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan linier pada anak yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah -2 standar deviasi (SD) berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang berkaitan dengan berbagai faktor, seperti status sosial ekonomi yang rendah, kurangnya asupan nutrisi yang sesuai, kesehatan ibu yang kurang optimal,

riwayat infeksi berulang, serta pola makan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak (Kemenkes RI, 2022). Menurut WHO (2020), stunting didefinisikan sebagai kondisi di mana tinggi badan anak berada lebih dari dua standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Prawirahartono (2020) dan Sari (2021) juga menjelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usia anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Penyebab utamanya adalah kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tetapi juga menghambat perkembangan kognitif anak secara keseluruhan.

C. Diagnosis Stunting

Menentukan diagnosis stunting melibatkan beberapa tahap, yakni wawancara medis (anamnesis), pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan tambahan jika dibutuhkan. Keluhan yang sering disampaikan orang tua adalah anak terlihat lebih pendek dibandingkan teman sebayanya dan sering mengalami kesulitan makan. Setelah anamnesis dilakukan, langkah berikutnya adalah pengukuran antropometri, penilaian kecepatan tumbuh, evaluasi proporsi tubuh, serta estimasi potensi tinggi badan anak berdasarkan faktor genetik (Kemenkes RI, 2020).

1. Pengukuran Antropometri

Pada anak usia di bawah dua tahun, dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta lingkar kepala. Hasil pengukuran dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO atau tabel panjang badan menurut umur dari Kementerian Kesehatan RI. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki indeks tinggi badan per umur (TB/U) dan berat badan per umur (BB/U) di bawah -2 SD. Bila berat badan per tinggi badan (BB/TB) lebih dari 1 SD, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut guna mendeteksi kemungkinan gangguan endokrin.

2. Penilaian Kecepatan Tumbuh

Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain yang tumbuh normal.

3. Evaluasi Proporsi Tubuh

Penilaian proporsi tubuh dilakukan dengan membandingkan segmen tubuh bagian atas (A) dan bagian bawah (B). Segmen atas didapat dengan mengurangi tinggi badan dengan panjang segmen bawah (dari simfisis pubis ke kaki). Pada anak dengan stunting, rasio A/B umumnya = 1, yang menandakan proporsi tubuh tetap normal meskipun tinggi badan lebih pendek. Jika rasio tidak proporsional, maka kemungkinan ada gangguan lain, seperti kelainan genetik atau tulang.

4. Perkiraan Potensi Tinggi Genetik

Pemeriksaan ini bertujuan memperkirakan tinggi badan anak saat dewasa dengan memperhitungkan tinggi badan orang tua serta faktor genetik lainnya.

5. Alur Diagnostik Stunting

Diagnosis stunting dilakukan secara bertahap, dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan. Penting untuk membedakan apakah anak yang pendek tersebut merupakan variasi pertumbuhan normal atau ada gangguan medis yang mendasarinya. Pertumbuhan pendek yang bersifat patologis umumnya dikelompokkan menjadi:

- **Proporsional:** Biasanya disebabkan oleh gangguan prenatal (misalnya gangguan kehamilan) atau pascanatal (seperti penyakit kronis).
- **Disproporsional:** Sering kali dikaitkan dengan kelainan genetik atau gangguan tulang.

Pada anak yang pendek tapi memiliki status gizi baik atau berlebih, pemeriksaan lanjutan sangat dianjurkan untuk memastikan apakah benar mengalami stunting. Selain itu, evaluasi potensi tinggi genetik perlu mempertimbangkan tinggi badan kedua orang tua, riwayat prenatal, riwayat pascanatal, serta riwayat gangguan pertumbuhan seperti weight faltering dan malnutrisi sebelumnya.

D. Faktor Penyebab Stunting

Stunting merupakan kondisi yang dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, faktor penyebab stunting dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yakni faktor langsung dan faktor tidak langsung. Arianigizi (2020) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang berkontribusi terhadap stunting meliputi praktik pemberian ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), infeksi berulang, sanitasi yang buruk, status sosial ekonomi keluarga, serta tingkat pendidikan ibu.

1. Pemberian ASI Eksklusif

Pada bayi usia 0-6 bulan, kebutuhan nutrisi utama hanya berasal dari ASI eksklusif. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dan penurunan risiko stunting. Noor et al. (2022) menemukan bahwa pemberian ASI eksklusif berhubungan erat dengan penurunan angka stunting ($p\text{-value} = 0,008$). Penelitian lain oleh Fitri dan Ernita (2019) juga melaporkan hasil serupa dengan $p\text{-value} < 0,05$.

2. Pemberian MP-ASI yang Tidak Tepat

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) seharusnya diberikan setelah bayi berusia 6 bulan dengan jenis makanan dan tekstur yang sesuai untuk perkembangan anak. MP-ASI yang tidak memadai bisa meningkatkan risiko infeksi saluran cerna dan pernapasan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan anak. Studi oleh Fitri & Ernita (2019) menunjukkan bahwa praktik pemberian MP-ASI yang kurang tepat berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting pada balita ($p\text{-value} = 0,001$).

3. Infeksi Berulang

Infeksi kronis yang berulang, seperti cacingan, infeksi saluran pernapasan, diare, dan penyakit menular lainnya, bisa mengganggu penyerapan nutrisi, sehingga berdampak pada pertumbuhan anak.

4. Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

WHO mendefinisikan BBLR sebagai bayi yang lahir dengan berat di bawah 2.500 gram. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan, yang berisiko berlanjut hingga setelah lahir dan meningkatkan kemungkinan stunting.

5. Kondisi Sanitasi yang Buruk

Sanitasi yang buruk seperti kurangnya akses air bersih dan lingkungan rumah tangga yang tidak bersih dapat meningkatkan risiko anak terkena infeksi berulang. Infeksi ini menghambat penyerapan nutrisi, yang akhirnya berkontribusi pada stunting.

6. Status Sosial Ekonomi Keluarga

Keterbatasan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Keluarga dengan ekonomi rendah cenderung kurang memahami kebutuhan nutrisi anak serta memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi.

7. Tingkat Pendidikan Ibu

Pendidikan ibu sangat berpengaruh pada pemahaman mengenai pola asuh dan pemenuhan kebutuhan nutrisi anak. Ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang gizi dan kesehatan anak, sehingga mampu menerapkan pola makan yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.

Menurut WHO (2020), penyebab stunting terbagi menjadi dua kategori utama:

- **Faktor Internal:** Meliputi pemberian ASI eksklusif, MP-ASI yang tepat, kesehatan ibu, kualitas makanan rendah, keamanan pangan dan air, serta infeksi.
- **Faktor Eksternal:** Mencakup budaya, tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, status ekonomi, sistem pangan, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang sehat.

E. Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui dua jenis intervensi utama, yaitu **intervensi gizi spesifik** dan **intervensi gizi sensitif**.

- **Intervensi gizi spesifik** berfokus langsung pada pemenuhan kebutuhan nutrisi anak dan ibu, baik sebelum kehamilan, selama kehamilan, hingga masa menyusui.
- **Intervensi gizi sensitif** bertujuan mendukung tumbuh kembang anak melalui perbaikan akses terhadap air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan di lingkungan keluarga.

1. Intervensi	Gizi	Spesifik
----------------------	-------------	-----------------

Intervensi ini menargetkan langsung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak dan ibu. Beberapa langkah utamanya meliputi:

- Pemberian suplementasi gizi bagi ibu hamil, terutama tablet tambah darah dan vitamin A pasca melahirkan.
- Peningkatan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan serta pemberian MP-ASI yang bergizi dan sesuai usia setelah 6 bulan.
- Suplementasi vitamin dan mineral bagi balita, seperti vitamin A, zat besi, serta zinc untuk mendukung daya tahan tubuh dan mencegah gangguan pertumbuhan.

2. Intervensi

Gizi

Sensitif

Intervensi ini lebih bersifat mendukung kondisi lingkungan agar anak tumbuh optimal. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- Peningkatan akses air bersih dan fasilitas sanitasi layak untuk mencegah penyakit infeksi, seperti diare dan cacingan.
- Edukasi kesehatan dan gizi bagi ibu serta keluarga agar memahami pola makan yang seimbang dan kebersihan lingkungan.
- Peningkatan akses layanan kesehatan, termasuk pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala di posyandu, serta pemberian imunisasi lengkap sesuai usia anak.
- Penguatan ketahanan pangan keluarga dengan mendorong diversifikasi pangan, pemanfaatan lahan pekarangan, dan edukasi gizi seimbang berbasis lokal.

Gambaran Umum Pencegahan Stunting:

Pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan dan berlanjut hingga anak mencapai usia dua tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan). Periode ini disebut masa emas pertumbuhan, di mana pemenuhan nutrisi yang baik akan memberikan dampak besar bagi tumbuh kembang anak, baik fisik maupun kognitif. Menurut Sjarif (2022), intervensi yang efektif harus melibatkan lintas sektor, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Algoritme pencegahan dan penanganan stunting pun disusun agar semua pihak bisa berkontribusi secara terstruktur dalam upaya menekan angka stunting.

F. Intervensi Medik Anak Stunting

Anak yang lahir dalam kondisi stunting berisiko besar untuk tetap mengalami gangguan pertumbuhan hingga masa remaja dan dewasa. Namun, mereka masih berpeluang mengejar ketertinggalan pertumbuhan melalui **proses kejar tumbuh (catch-up growth)**, terutama bila berada dalam lingkungan yang mendukung. Beberapa faktor penting yang berkontribusi mendukung pertumbuhan optimal meliputi pemenuhan gizi seimbang, lingkungan bersih, pencegahan infeksi, serta akses layanan kesehatan seperti imunisasi dan pemantauan rutin di posyandu (Siswati, 2018).

1. Masa Emas Pertumbuhan (Golden Period)

Periode krusial untuk mengejar pertumbuhan terjadi pada **730 hari pertama kehidupan** — mulai dari dalam kandungan hingga usia dua tahun. Masa ini sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

➤ **Intervensi yang dianjurkan pada periode ini meliputi:**

- **ASI eksklusif** selama 6 bulan pertama.
- **Pemberian MP-ASI bergizi seimbang** setelah 6 bulan, sambil tetap melanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun.
- **Suplementasi vitamin A** dosis tinggi sesuai program pemerintah, serta pemakaian garam beryodium pada MP-ASI.

2. Peran Kunci Ibu dan Pengasuh

Ibu dan pengasuh memegang peran penting dalam menyiapkan makanan bergizi, menjaga kebersihan, dan memastikan anak mendapat asupan nutrisi yang seimbang. Edukasi gizi bagi ibu sangat diperlukan agar pola makan anak tetap memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya.

 **Waspada:** Memberikan makanan tinggi kalori dan lemak tanpa memperhatikan keseimbangan gizi bisa berisiko menyebabkan obesitas. Anak yang obesitas cenderung mengalami pertumbuhan ke samping, bukan ke atas. Oleh karena itu, keseimbangan asupan kalori, protein, dan lemak harus tetap terjaga.

3. Perlindungan dari Lingkungan yang Buruk

Anak harus dijauhkan dari paparan asap rokok, polusi udara, dan lingkungan yang tidak bersih. Akses air bersih dan sanitasi yang memadai sangat mendukung kesehatan serta mencegah infeksi berulang, yang berkontribusi pada gangguan penyerapan nutrisi.

4. Stimulasi Perkembangan Anak

Selain pemenuhan gizi, stimulasi perkembangan juga berperan besar dalam mendukung pematangan otak anak. Ibu dan pengasuh dianjurkan aktif berinteraksi dengan bayi melalui kegiatan seperti:

- Berbicara dan bernyanyi.
- Bermain dan memberikan rangsangan motorik.
- Melakukan kontak mata, sentuhan lembut, serta senyuman.

 **Tujuan:** Stimulasi ini membantu memperkuat perkembangan kognitif, bahasa, serta motorik halus dan kasar anak, agar tumbuh lebih optimal.

G. Tatalaksana Stunting di Faskes Sekunder

Anak dengan stunting yang tidak menunjukkan perbaikan di fasilitas kesehatan primer harus dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan (**FKRTL**) agar mendapat penanganan lebih intensif oleh dokter spesialis anak.

 Penanganan di faskes rujukan mencakup:

1. Tata Laksana Gizi, Aktivitas Fisik, dan Pola Tidur

- **Nutrisi:** Makanan diberikan dengan rasio protein-energi (**Protein Energy Ratio/PER**) sebesar **10-15%**.
- **Aktivitas fisik:** Anak dianjurkan melakukan olahraga ringan 30-60 menit per hari, minimal 3-5 kali seminggu.
- **Pola tidur:** Tidur malam diatur mulai pukul **21.00** agar anak masuk ke fase **deep sleep** antara **23.00-03.00**, waktu di mana hormon pertumbuhan mencapai puncak.

2. Penilaian dan Klasifikasi

Dokter spesialis anak akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengklasifikasikan kondisi anak — apakah stunting bersifat normal, patologis, proporsional, atau disproporsional. Anak dengan kondisi non-stunting dirujuk ke dokter subspesialis sesuai kebutuhan medis.

3. Strategi Kejjar Tumbuh (Catch-Up Growth)

Penanganan bertujuan mengejar ketertinggalan pertumbuhan dengan strategi:

- **Penilaian:** Melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pengukuran antropometri.
- **Penentuan kebutuhan nutrisi:** Kalori dihitung berdasarkan **Angka Kecukupan Gizi (AKG)** sesuai berat badan ideal anak.
- **Rute pemberian nutrisi:** Utamakan secara oral. Bila kurang efektif, bisa melalui enteral (selang makan) atau parenteral (infus).
- **Pemilihan jenis makanan:** Prioritaskan protein hewani berkualitas tinggi dengan skor **DIAAS ≥ 100** . Pemberian **Pangan Khusus untuk Medis Khusus (PKMK)** dilakukan sesuai indikasi dokter spesialis.

4. Dukungan Ilmiah

Berbagai penelitian mendukung konsumsi protein hewani (susu, daging, telur) sebagai kontributor signifikan dalam meningkatkan tinggi badan dan menurunkan risiko stunting.

5. Penanganan Kasus Khusus

Anak dengan kondisi khusus (BBLR, prematur, alergi susu sapi) memerlukan **dukungan nutrisi khusus**, seperti:

- **Oral Nutrition Supplement (ONS):** Suplemen energi tinggi (**$>0,9$ kkal/mL**).
- **Formula khusus:** Untuk bayi prematur dan bayi berat lahir rendah (BBLR).

- **Formula protein terhidrolisat:** Untuk anak dengan alergi susu sapi atau gangguan metabolisme.

H. Penutup

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah -2 SD menurut kurva pertumbuhan WHO. Penyebab utamanya adalah kekurangan gizi kronis yang berkaitan dengan faktor sosial ekonomi rendah, infeksi berulang, serta pola makan yang tidak sesuai.

Meskipun angka stunting di Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan, prevalensinya masih tergolong tinggi. Dampaknya pun sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Anak dengan stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, perkembangan kognitif yang terhambat, serta risiko penyakit metabolik di masa dewasa.

👉 **Kunci** penanganan:

- Deteksi dini stunting di posyandu.
- Edukasi gizi bagi ibu dan keluarga.
- Intervensi nutrisi yang tepat.
- Penanganan di faskes primer dan rujukan sesuai kebutuhan anak.

Dengan pencegahan dan penanganan yang komprehensif, diharapkan angka stunting di Indonesia terus menurun, sehingga generasi mendatang tumbuh lebih sehat, cerdas, dan produktif.

Referensi

- Delpeuch, F., Traissac, P., Martin-Prével, Y., Massamba, Y. P., & Maire, B. (2000). Economic crisis and malnutrition: Socioeconomic determinants of anthropometric status of preschool children and their mothers in an African urban area. *Public Health Nutrition*, 3(1), 39–47.
- Fitri, L., & Ernrita. (2019). Hubungan pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI dini dengan kejadian stunting pada balita. *Journal of Midwifery Sciences*, 8(1), 1–6. Retrieved from <http://jurnal.alinsyirah.ac.id/index.php/kebidanan>
- Goodchild van Hilten, L. (2015). *Higher education is key to economic development (but it's not as simple as you think)*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana stunting*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Panduan pencegahan dan penanganan stunting*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Komang, N., Apriastini, T., Putu, N., Adnyani, T., Selvyani, P. O., Hendra, K., Kedokteran, P., & Ganesha, U. P. (2024). *Stunting: Faktor risiko, diagnosis, tatalaksana, dan* (4)(1), 17–23.
- Noor, M. S., Andrestian, M. D., Dina, R. A., Ferdina, A. R., Dewi, Z., Hariati, N. W., et al. (2022). Analysis of socioeconomic, utilization of maternal health services, and toddler's characteristics as stunting risk factors. *Nutrients*, 14(20).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak*. Indonesia: Kementerian Kesehatan RI.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prawirohartono, E. P. (2020). *Stunting: Dari teori dan bukti ke implementasi di lapangan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Siswati, T. (2018). *Stunting*. Yogyakarta: Husada Mandiri. Retrieved from <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/5206/2/buku%20stunting%20lengkap.pdf>
- Sari, D. N. (2021). Faktor risiko stunting pada balita di Indonesia. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 150-162.

World Health Organization. (2012). *Global nutrition target 2025: Stunting policy brief*. WHO/NMH/NHD/14.3.

World Health Organization. (2014). *Childhood stunting: Context, causes and consequences*.

World Health Organization. (2020). *Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/The World Bank Group joint child malnutrition estimates*.

World Health Organization (WHO). (2020). *Malnutrition: Stunting, wasting, and overweight*. Retrieved from <https://www.who.int>

Glosarium

Antropometri: Pengukuran fisik tubuh manusia, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, untuk menilai status gizi dan pertumbuhan anak.

BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan): Indikator untuk menilai apakah anak mengalami kekurangan gizi akut.

BB/U (Berat Badan menurut Umur): Indikator yang membandingkan berat badan anak dengan usia untuk menilai status gizi.

BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah): Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, berisiko tinggi mengalami stunting.

Catch-Up Growth: Pertumbuhan kejar yang terjadi ketika anak dengan stunting mendapatkan intervensi nutrisi dan kesehatan yang tepat, memungkinkan mereka mengejar pertumbuhan yang tertinggal.

Deep Sleep: Fase tidur dalam yang penting untuk sekresi hormon pertumbuhan, mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.

DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score): Skor kualitas protein berdasarkan seberapa baik asam amino esensial dicerna dan digunakan tubuh. Protein hewani dengan DIAAS ≥ 100 dianggap berkualitas tinggi.

Imunisasi: Proses pemberian vaksin untuk melindungi anak dari penyakit menular yang bisa memperburuk kondisi stunting.

Length Faltering: Perlambatan pertumbuhan panjang badan yang terjadi pada bayi, sering menjadi prediktor stunting di masa depan.

Malnutrisi: Kondisi kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan energi dan nutrisi yang berdampak negatif pada kesehatan.

MPASI (Makanan Pendamping ASI): Makanan tambahan yang diberikan mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak selain ASI.

PKMK (Pangan untuk Keperluan Medis Khusus): Makanan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan kondisi medis tertentu, termasuk stunting.

Red Flags: Tanda bahaya klinis yang menunjukkan kemungkinan penyebab stunting yang lebih serius, seperti gangguan metabolik atau kelainan genetik.

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar): Survei nasional yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk memantau status kesehatan dan gizi masyarakat di Indonesia.

SD (Standar Deviasi): Ukuran penyimpangan data dari rata-rata. Pada stunting, -2 SD menunjukkan anak lebih pendek dari standar usianya.

SSGI (Studi Status Gizi Indonesia): Survei yang mengukur status gizi anak di seluruh provinsi di Indonesia untuk memantau prevalensi stunting dan malnutrisi lainnya.

Stunting: Kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usianya, disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.

TB/U (Tinggi Badan menurut Umur): Indikator yang membandingkan tinggi badan anak dengan usia untuk mengukur pertumbuhan linier.

Weight Faltering: Kondisi di mana kenaikan berat badan anak melambat atau berhenti, menjadi tanda awal risiko stunting.

WHO (World Health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia yang menetapkan standar pertumbuhan anak dan pedoman kesehatan global.

BAB VI

STRATEGI KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TENTANG STUNTING

A. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang kompleks dan masih menjadi perhatian utama di tingkat global, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam periode seribu hari pertama kehidupan, yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga berkontribusi terhadap tantangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di bawah 20 persen. Dalam laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional pada tahun 2022 masih berada di angka 21,6 persen, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan intervensi harus terus diperkuat. Faktor penyebab stunting meliputi asupan gizi yang tidak mencukupi, pola asuh yang kurang optimal, sanitasi yang buruk, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, serta sektor swasta. Salah satu aktor utama yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai stunting adalah komunitas. Komunitas dapat berperan sebagai agen perubahan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memfasilitasi program pemberdayaan gizi, serta memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, memahami strategi efektif yang dapat diterapkan komunitas dalam pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya akibat malnutrisi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial yang memadai, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan anak. Stunting bukan hanya sekadar masalah pertumbuhan fisik,

tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan otak, kognitif, dan produktivitas individu di masa depan.

Kesadaran tentang stunting sangat penting karena permasalahan ini tidak hanya memengaruhi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi juga berkontribusi terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, risiko kesehatan yang lebih tinggi di masa dewasa, serta potensi produktivitas ekonomi yang lebih rendah. Hal ini berdampak langsung pada daya saing sumber daya manusia suatu bangsa.

Meningkatkan kesadaran tentang stunting di kalangan masyarakat, terutama orang tua, pengasuh, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahannya. Kesadaran yang tinggi akan stunting dapat mendorong perilaku pencegahan, seperti pemenuhan gizi yang baik sejak kehamilan, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI yang bergizi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang baik. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan melalui berbagai media, program komunitas, serta kebijakan berbasis masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Komunitas memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi, serta mendukung intervensi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Komunitas dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dengan optimal.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan komunitas dalam mengatasi stunting antara lain: 1). Komunitas dapat menyelenggarakan program penyuluhan yang membahas pentingnya asupan gizi seimbang bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan kelompok, seminar, maupun pemanfaatan media sosial. 2). Komunitas dapat berperan dalam memberikan dukungan bagi ibu hamil dan menyusui, termasuk konsultasi dengan tenaga kesehatan, pelatihan tentang pemberian ASI eksklusif, serta promosi pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai. 3). Melalui posyandu dan kelompok kesehatan komunitas, masyarakat dapat melakukan pemantauan pertumbuhan anak secara berkala untuk mendeteksi dini risiko stunting dan memberikan intervensi yang diperlukan. 4). Komunitas dapat berperan dalam mendorong produksi dan distribusi pangan sehat, seperti membentuk kebun gizi keluarga, mengembangkan pasar pangan lokal, serta memfasilitasi program bantuan makanan bergizi bagi keluarga kurang mampu. 5). Sanitasi yang buruk dan

kurangnya akses air bersih dapat meningkatkan risiko infeksi yang berkontribusi terhadap stunting. Komunitas dapat mendorong pembangunan jamban sehat, sistem pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih yang lebih merata. 6). Pemanfaatan teknologi dan media sosial dapat menjadi alat efektif dalam menyebarkan informasi terkait stunting, pola makan sehat, dan praktik pengasuhan yang baik. 7). Komunitas dapat bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, serta organisasi kesehatan untuk memperkuat implementasi program pencegahan stunting secara lebih luas dan sistematis.

Keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam pencegahan stunting diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Dengan adanya sinergi antara komunitas, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan, target penurunan angka stunting secara nasional dapat lebih cepat tercapai, sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan stunting. Melalui pendekatan berbasis komunitas, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan stunting, termasuk masyarakat umum, tenaga kesehatan, akademisi, pembuat kebijakan, serta organisasi non-pemerintah. Beberapa manfaat yang diharapkan dari buku ini antara lain: 1). Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai stunting, faktor penyebabnya, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta upaya pencegahannya secara ilmiah dan berbasis bukti. 2). Menguraikan berbagai strategi berbasis komunitas yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan stunting, termasuk model pemberdayaan masyarakat, edukasi kesehatan, serta advokasi kebijakan. 3). Memberikan contoh praktik baik (best practices) dari berbagai komunitas yang telah berhasil menerapkan program pencegahan dan intervensi stunting, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 4). Mendorong pembaca untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan stunting melalui program-program berbasis komunitas, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta penguatan jejaring sosial untuk mendukung upaya intervensi yang berkelanjutan. 5). Menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas strategi komunitas dalam menangani stunting, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya buku ini, diharapkan semakin banyak komunitas yang tergerak untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. 1). Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai stunting, penyebab, serta dampaknya. 2). Menguraikan berbagai strategi yang dapat dilakukan komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan stunting. 3). Memberikan contoh praktik baik (best practices) dari berbagai komunitas yang telah berhasil dalam upaya penanggulangan stunting. 4). Mendorong pembaca, terutama praktisi kesehatan, akademisi, serta penggerak komunitas untuk mengembangkan inisiatif berbasis masyarakat dalam pencegahan stunting.

Buku ini disusun berdasarkan pendekatan ilmiah dan praktis yang menggabungkan kajian literatur, hasil penelitian terkini, serta pengalaman lapangan dalam implementasi program pencegahan stunting berbasis komunitas. Untuk memastikan kualitas informasi yang disajikan, metode yang digunakan dalam penyusunan buku ini meliputi: 1). Analisis berbagai penelitian dan laporan dari jurnal ilmiah, organisasi kesehatan global (seperti WHO dan UNICEF), serta kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan stunting.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar teoretis dan empirik yang kuat dalam memahami faktor penyebab, dampak, serta strategi intervensi stunting. 2). Penggunaan data dari berbagai sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta survei nasional terkait status gizi masyarakat. Data ini digunakan untuk menggambarkan kondisi stunting secara kuantitatif dan mengidentifikasi tren yang relevan dengan peran komunitas dalam penanggulangan stunting. 3). Buku ini mengadopsi perspektif langsung dari tenaga kesehatan, kader posyandu, pemimpin komunitas, serta individu yang terlibat dalam program pencegahan stunting di berbagai daerah. Wawancara ini bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi di lapangan serta strategi terbaik yang telah diterapkan oleh komunitas dalam menangani permasalahan stunting. 4). Untuk memberikan gambaran nyata mengenai implementasi strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran tentang stunting, buku ini menyajikan beberapa studi kasus dari daerah dengan prevalensi stunting tinggi maupun daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting melalui intervensi berbasis komunitas. Studi kasus ini mencakup faktor keberhasilan, tantangan yang dihadapi, serta model intervensi yang dapat direplikasi di daerah lain.

Ruang Lingkup Pembahasan Buku ini berfokus pada berbagai aspek yang terkait dengan peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan penanggulangan stunting. Ruang lingkup pembahasan mencakup: Definisi, faktor penyebab, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta kebijakan nasional dan internasional dalam

pencegahannya, pendekatan edukatif, advokasi kesehatan, intervensi berbasis keluarga, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat, keterlibatan komunitas, pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi non-pemerintah (NGO), serta sektor swasta dalam mendukung program-program penanggulangan stunting, kendala yang sering dihadapi dalam implementasi program komunitas serta strategi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh komunitas dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan program pencegahan stunting yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang sistematis ini, diharapkan buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi berbagai pihak yang ingin memahami dan berkontribusi dalam upaya penanggulangan stunting melalui pemberdayaan komunitas.

B. Konsep Stunting

1. Pengertian Stunting dan Faktor Penyebabnya

Stunting adalah kondisi yang terjadi ketika anak mengalami pertumbuhan yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). HPK mencakup masa sejak konsepsi (kehamilan) hingga anak berusia dua tahun, yang merupakan periode kritis dalam perkembangan tubuh dan otak.

Kekurangan gizi yang berkepanjangan menyebabkan anak memiliki tinggi badan di bawah standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Namun, stunting bukan hanya masalah tinggi badan; kondisi ini juga berkaitan erat dengan gangguan perkembangan kognitif, sistem imun yang lemah, serta risiko penyakit tidak menular di masa depan.

WHO menetapkan standar pertumbuhan anak berdasarkan kurva pertumbuhan yang membandingkan tinggi badan anak dengan usianya. Jika tinggi badan anak berada di bawah -2 standar deviasi dari median WHO, anak tersebut dikategorikan sebagai stunting. Oleh karena itu, stunting bukan hanya akibat kurang makan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola asuh, sanitasi, infeksi berulang, dan status sosial ekonomi keluarga.

2. Faktor penyebab stunting

Faktor penyebab stunting dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung berkaitan dengan kondisi yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan anak, seperti kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang. Sementara itu, faktor tidak langsung meliputi

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan anak, seperti pola asuh, sanitasi lingkungan, serta tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga. Secara lebih rinci, faktor langsung penyebab stunting mencakup:

- a) **Asupan gizi yang tidak mencukupi:** Kekurangan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) serta zat gizi mikro (zat besi, vitamin A, zinc) yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan tinggi badan.
- b) **Infeksi berulang:** Anak yang sering mengalami penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan cacingan berisiko mengalami stunting karena infeksi dapat menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh.

Sementara itu, faktor tidak langsung yang dapat menyebabkan stunting antara lain:

- a) **Pola asuh yang kurang optimal:** Praktik pemberian ASI eksklusif yang tidak sesuai serta pemberian MPASI yang tidak memenuhi kebutuhan gizi anak dapat meningkatkan risiko stunting.
- b) **Sanitasi dan akses air bersih yang buruk:** Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko anak terkena penyakit infeksi yang berulang, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
- c) **Tingkat pendidikan dan ekonomi keluarga:** Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam pengetahuan mengenai gizi dan kesehatan anak. Selain itu, kondisi ekonomi yang rendah dapat mengurangi akses keluarga terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai.

3. Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang Stunting

Dampak stunting dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang, yang keduanya berpengaruh besar terhadap perkembangan individu dan masyarakat.

a) Dampak Jangka Pendek:

1) Gangguan perkembangan otak

Anak yang mengalami stunting memiliki kapasitas kognitif yang lebih rendah dibandingkan anak yang memiliki gizi cukup. Hal ini dikarenakan kurangnya asupan nutrisi yang berperan dalam pembentukan jaringan saraf dan otak.

2) Peningkatan risiko penyakit infeksi

Sistem kekebalan tubuh anak yang mengalami stunting lebih lemah, sehingga mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

3) Pertumbuhan fisik terhambat

Anak dengan stunting mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih lambat dibandingkan anak seusianya, sehingga mereka memiliki postur tubuh yang lebih pendek dibanding standar usianya.

b) Dampak Jangka Panjang:

- 1) Penurunan prestasi akademik: Karena gangguan perkembangan otak, anak dengan riwayat stunting cenderung mengalami kesulitan dalam belajar, memiliki daya ingat yang lebih rendah, dan kurang mampu berkonsentrasi dibandingkan anak yang tumbuh dengan gizi optimal.
- 2) Meningkatnya risiko penyakit tidak menular (PTM): Stunting di masa kanak-kanak berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung di masa dewasa akibat perubahan metabolisme tubuh yang kurang optimal sejak dini.
- 3) Produktivitas dan pendapatan lebih rendah: Orang dewasa yang mengalami stunting di masa kecil cenderung memiliki keterampilan kognitif dan fisik yang lebih rendah, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas kerja serta pendapatan yang lebih kecil dibandingkan mereka yang tumbuh optimal.
- 4) Siklus antar-generasi stunting: Ibu yang mengalami stunting cenderung melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang kemudian berisiko tinggi mengalami stunting pula, sehingga masalah ini terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dampak stunting ini tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Oleh

karena itu, upaya pencegahan sejak dini menjadi sangat penting untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Status Stunting di Indonesia dan Global

Stunting merupakan masalah kesehatan global yang mendapat perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan anak dan pembangunan manusia. Menurut data WHO, pada tahun 2020, sekitar 149 juta anak di dunia mengalami stunting, yang berarti mereka memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan yang sesuai dengan usia mereka. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu panjang, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

Stunting tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga ditemukan di beberapa negara maju, meskipun dengan prevalensi yang lebih rendah. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting di berbagai negara mencakup kemiskinan, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, rendahnya tingkat pendidikan ibu, buruknya layanan kesehatan, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka stunting yang cukup tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting nasional mencapai 21,6%. Meskipun angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah masih memiliki target ambisius untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Berbagai program nasional telah dicanangkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memperbaiki akses terhadap pangan bergizi dan sanitasi yang layak.

Secara global, negara-negara di Afrika dan Asia Selatan memiliki angka prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Faktor seperti kemiskinan, ketidakcukupan pangan, dan akses layanan kesehatan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penanggulangan stunting di berbagai negara.

5. Kebijakan Pemerintah dan Program Nasional Terkait Stunting

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan program nasional untuk menurunkan angka stunting, di antaranya:

- 1) Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting):
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam

upaya penurunan angka stunting, dengan fokus pada intervensi spesifik dan sensitif.

- 2) Gerakan Nasional 1.000 HPK: Program ini menekankan pentingnya intervensi gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
- 3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Program ini menyediakan asupan gizi tambahan bagi ibu hamil dan anak balita yang berisiko stunting.
- 4) Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak balita untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi.
- 5) Intervensi sanitasi dan akses air bersih: Peningkatan akses sanitasi dan air bersih untuk mencegah infeksi yang berkontribusi pada stunting.

Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia. Kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis bukti menjadi kunci keberhasilan dalam menangani permasalahan ini.

C. Peran Komunitas dalam Penganggulan Stunting

1. Definisi Komunitas dan Jenis-jenisnya dalam Konteks Kesehatan

Komunitas adalah kelompok individu yang memiliki kesamaan karakteristik, nilai, atau tujuan tertentu dan sering kali berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial yang sama. Dalam konteks kesehatan, komunitas berperan sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi pola hidup, perilaku kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Ada beberapa jenis komunitas dalam bidang kesehatan:

- a) **Komunitas Berbasis Wilayah** merujuk pada kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan lokasi geografis tertentu, seperti desa, kelurahan, atau lingkungan perumahan. Komunitas ini berperan penting dalam penyebaran informasi kesehatan, pengawasan pertumbuhan anak, serta pelaksanaan program-program intervensi yang berhubungan dengan pencegahan stunting.

Sebagai contoh, di banyak desa di Indonesia, kader Posyandu dan perangkat desa bekerja sama dalam mengadakan edukasi gizi dan pemantauan pertumbuhan anak-anak balita. Mereka juga sering kali berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas untuk memberikan layanan tambahan, seperti penyuluhan ASI eksklusif, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan bergizi bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting.

Keunggulan dari komunitas berbasis wilayah adalah adanya keterikatan sosial yang kuat, yang membuat intervensi kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, komunitas ini juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan tantangan lokal, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam penanggulangan stunting.

b) Komunitas Profesional merujuk pada kelompok tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam penyuluhan, edukasi, serta pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Kelompok ini terdiri dari dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya yang berkontribusi dalam memberikan informasi yang akurat mengenai gizi, pola asuh yang baik, serta langkah-langkah pencegahan stunting kepada masyarakat.

Peran komunitas profesional dalam pencegahan stunting meliputi:

- 1) **Edukasi dan Konseling** – Memberikan pemahaman kepada ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya asupan gizi yang cukup serta pola makan sehat untuk anak-anak mereka.
- 2) **Pelayanan Kesehatan** – Menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak melalui fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Posyandu.
- 3) **Advokasi Kebijakan** – Mengusulkan dan mendukung kebijakan kesehatan yang berbasis bukti guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
- 4) **Pelatihan dan Pemberdayaan Kader Kesehatan** – Melatih kader kesehatan masyarakat agar mereka dapat memberikan edukasi dan pemantauan gizi di tingkat komunitas.

Keberadaan komunitas profesional sangat penting dalam memastikan bahwa upaya pencegahan stunting berbasis ilmu pengetahuan dan dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

c) Komunitas Berbasis Kepentingan adalah kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan kepentingan dan tujuan yang sama dalam konteks kesehatan. Contohnya adalah komunitas ibu hamil dan menyusui, serta kelompok dukungan orang tua yang memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Komunitas ini berperan penting dalam berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, serta mengedukasi anggotanya tentang pola asuh dan

pemenuhan gizi yang baik untuk mencegah stunting. Misalnya, komunitas ibu menyusui sering kali menjadi tempat berbagi informasi mengenai pentingnya ASI eksklusif, cara meningkatkan produksi ASI, serta strategi pemberian MPASI yang bergizi.

Selain itu, kelompok dukungan orang tua dapat menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman dalam mengasuh anak dan memastikan tumbuh kembang yang optimal. Dengan keterlibatan aktif dalam komunitas berbasis kepentingan, orang tua dapat lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik dalam pencegahan stunting.

d) Komunitas Digital adalah kelompok yang berinteraksi dan berbagi informasi terkait kesehatan dan gizi melalui platform daring seperti media sosial, aplikasi kesehatan, serta forum diskusi online. Komunitas ini memiliki peran penting dalam penyebaran informasi yang cepat dan luas mengenai stunting, pola makan sehat, serta pentingnya ASI eksklusif dan MPASI bergizi.

Keunggulan komunitas digital adalah aksesibilitasnya yang tinggi, memungkinkan orang tua, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum untuk memperoleh informasi kesehatan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, komunitas digital juga dapat menjadi ruang diskusi bagi para ibu untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan moral, serta berinteraksi dengan ahli gizi dan tenaga kesehatan secara daring.

Contoh komunitas digital yang berperan dalam pencegahan stunting antara lain adalah grup WhatsApp atau Telegram bagi ibu hamil dan menyusui, kanal YouTube edukatif tentang gizi anak, serta aplikasi kesehatan yang menyediakan fitur pemantauan pertumbuhan balita.

2. Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Stunting

Komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang stunting, baik melalui edukasi, advokasi, maupun pemberdayaan masyarakat. Beberapa peran utama komunitas dalam pencegahan stunting meliputi:

- **Edukasi dan Sosialisasi:** Komunitas dapat menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pola asuh yang baik melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, seminar, dan media sosial.
- **Dukungan Sosial dan Emosional:** Kelompok dukungan dapat memberikan motivasi dan bantuan bagi ibu hamil dan ibu menyusui dalam memberikan asupan gizi yang cukup untuk anak mereka.

- **Monitoring dan Evaluasi:** Komunitas dapat berperan dalam pemantauan pertumbuhan anak melalui kegiatan Posyandu, serta melaporkan kasus-kasus gizi buruk kepada pihak berwenang.
- **Advokasi Kebijakan:** Komunitas dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung peningkatan gizi dan pencegahan stunting.

3. Model Keterlibatan Komunitas dalam Program Pencegahan Stunting

Berbagai model keterlibatan komunitas telah diterapkan dalam upaya pencegahan stunting, antara lain:

- a) **Pendekatan Berbasis Masyarakat (Community-Based Approach):** Program yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam identifikasi masalah dan pelaksanaan intervensi kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan dan program edukasi gizi.
- b) **Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta:** Kolaborasi antara komunitas dengan dinas kesehatan, akademisi, dan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan, makanan bergizi, serta peningkatan kapasitas kader kesehatan.
- c) **Program Posyandu dan Kader Kesehatan:** Penguatan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan primer dengan dukungan kader kesehatan yang bertugas melakukan edukasi dan pemantauan gizi anak.
- d) **Penggunaan Teknologi Digital:** Pemanfaatan aplikasi kesehatan, media sosial, dan grup diskusi daring untuk menyebarkan informasi serta memantau status gizi anak secara lebih luas dan efisien.

4. Studi Kasus Keberhasilan Komunitas dalam Mengatasi Stunting

Beberapa komunitas di Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting melalui pendekatan berbasis masyarakat. Contoh keberhasilan tersebut antara lain:

- a) **Program Desa Bebas Stunting di Kabupaten Lombok Tengah:** Program ini melibatkan kader Posyandu dan tokoh masyarakat dalam edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, serta penguatan kapasitas ibu dalam pola asuh anak.
- b) **Gerakan Aksi Gizi di Jawa Tengah:** Komunitas lokal bersama dengan pemerintah daerah dan akademisi melaksanakan program pemberian makanan bergizi di sekolah serta edukasi tentang pentingnya konsumsi protein hewani.

- c) **Kelompok Wanita Tani di Nusa Tenggara Timur:** Kelompok ini berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui budidaya tanaman lokal yang kaya nutrisi untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak-anak.

Keberhasilan program-program ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam pencegahan stunting sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, dan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan memperkuat peran komunitas, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat terus menurun sesuai dengan target nasional.

D. Strategi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Stunting

1. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Stunting di Masyarakat

Edukasi dan kampanye kesadaran tentang stunting merupakan strategi utama dalam memberdayakan masyarakat agar memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Kampanye ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti penyuluhan di Posyandu, seminar kesehatan, serta kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan tokoh masyarakat.

Beberapa metode edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting meliputi:

- **Penyuluhan langsung:** Menggunakan pendekatan tatap muka dalam kelompok kecil atau besar untuk memberikan informasi tentang gizi, pola asuh, dan pentingnya sanitasi.
- **Pendidikan berbasis sekolah:** Mengintegrasikan materi tentang stunting ke dalam kurikulum pendidikan dasar agar anak-anak sejak dini memahami pentingnya gizi.
- **Pameran dan festival kesehatan:** Mengadakan kegiatan yang menarik perhatian masyarakat dengan menghadirkan pakar kesehatan, sesi konsultasi gratis, serta demonstrasi penyajian makanan bergizi.
- **Mobil edukasi keliling:** Memanfaatkan kendaraan sebagai media edukasi yang menjangkau daerah terpencil untuk memberikan informasi dan layanan kesehatan terkait pencegahan stunting.

2. Program Gizi Berbasis Komunitas

Program gizi berbasis komunitas bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga, terutama ibu hamil dan balita, mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Program ini dilakukan melalui:

- **Pemberian Makanan Tambahan (PMT):** Menyediakan makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi.
- **Pelatihan pembuatan makanan sehat:** Mengajarkan ibu-ibu di komunitas cara memasak makanan sehat dengan bahan lokal yang mudah didapat.
- **Pemanfaatan pangan lokal:** Mendorong masyarakat untuk menanam dan mengonsumsi sumber pangan bergizi yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti sayuran hijau, ikan, dan kacang-kacangan.
- **Bantuan dan subsidi gizi:** Menyediakan dukungan berupa bantuan bahan pangan bergizi bagi keluarga kurang mampu untuk memastikan kecukupan nutrisi anak-anak mereka.

3. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Pendekatan partisipatif dan kolaboratif melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Strategi ini menekankan pentingnya kerja sama antara komunitas, pemerintah, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Beberapa bentuk pendekatan ini antara lain:

- **Pelibatan ibu dan keluarga:** Mengajak keluarga untuk aktif dalam program kesehatan dan gizi anak mereka.
- **Kerja sama dengan pemerintah daerah:** Menjalin kemitraan dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pencegahan stunting.
- **Kolaborasi dengan sektor swasta:** Mendorong perusahaan untuk turut serta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada perbaikan gizi masyarakat.
- **Peningkatan kapasitas kader kesehatan:** Melatih kader Posyandu dan tenaga kesehatan komunitas agar lebih memahami isu stunting dan dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

4. Pemanfaatan Media Sosial dan Digital untuk Edukasi Stunting

Media sosial dan teknologi digital menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai stunting. Beberapa strategi pemanfaatan media sosial meliputi:

- **Pembuatan konten edukatif:** Menggunakan video pendek, infografis, dan artikel yang menarik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang stunting.
- **Webinar dan siaran langsung:** Mengadakan diskusi daring dengan pakar kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

- **Aplikasi kesehatan:** Memanfaatkan aplikasi yang menyediakan informasi tentang tumbuh kembang anak, pola makan sehat, dan pemantauan status gizi.
- **Forum daring dan grup diskusi:** Membangun komunitas daring yang berfungsi sebagai wadah berbagi pengalaman dan informasi seputar kesehatan ibu dan anak.

5. Peran Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat dalam Penyebaran Informasi

Lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi terkait stunting. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan anak-anak. Beberapa peran penting yang dapat dilakukan oleh mereka antara lain:

- **Sosialisasi melalui kegiatan keagamaan:** Mengintegrasikan pesan kesehatan dan gizi dalam ceramah agama, khutbah, dan pengajian.
- **Pengaruh tokoh masyarakat:** Memanfaatkan peran kepala desa, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik.
- **Program sosial berbasis keagamaan:** Menyelenggarakan program bantuan pangan bergizi melalui lembaga amal dan filantropi.
- **Pemberdayaan relawan komunitas:** Menggerakkan komunitas berbasis keagamaan untuk melakukan edukasi kesehatan dan gizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan strategi-strategi di atas, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting dapat meningkat secara signifikan, sehingga angka stunting di Indonesia dapat terus menurun dan tercapai generasi yang lebih sehat di masa depan.

E. Implementasi Program Komunitas di Berbagai Daerah

1. Studi Kasus: Program Komunitas di Daerah Perkotaan

Implementasi program komunitas di daerah perkotaan menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang unik. Kota-kota besar memiliki sumber daya yang lebih melimpah, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan dari pemerintah daerah. Namun, kompleksitas sosial, tingkat mobilitas yang tinggi, serta kesenjangan ekonomi antarwarga sering kali menjadi kendala dalam keberhasilan program komunitas.

Salah satu contoh implementasi yang berhasil adalah program kesehatan ibu dan anak di Jakarta, yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, serta organisasi lokal. Program ini tidak hanya menyediakan layanan kesehatan gratis bagi ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup penyuluhan gizi, konsultasi psikologis, serta program pendampingan bagi keluarga dengan anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Dengan memanfaatkan teknologi, program ini juga mengembangkan aplikasi seluler yang memungkinkan ibu hamil mendapatkan informasi seputar kehamilan dan kesehatan anak secara real-time.

Selain di bidang kesehatan, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Surabaya juga menjadi contoh yang menarik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan usaha mikro dan kecil. Program ini bekerja sama dengan koperasi dan bank daerah untuk memberikan skema kredit lunak bagi pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan bisnisnya. Sebagai tambahan, program ini juga menyediakan platform digital bagi peserta untuk memasarkan produk mereka, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing di era digital.

Namun, meskipun berbagai program telah dirancang secara sistematis, tantangan tetap ada. Di daerah perkotaan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program komunitas sering kali menjadi kendala utama. Kesibukan individu, kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan komunitas, serta persaingan dalam lingkungan perkotaan membuat banyak program sulit untuk mencapai dampak yang optimal. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif, pendekatan berbasis insentif, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan keberhasilan program komunitas di daerah perkotaan.

2. Studi Kasus: Program Komunitas di Daerah Pedesaan

Di daerah pedesaan, program komunitas sering kali berfokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Salah satu contoh program yang berhasil diterapkan adalah Posyandu Plus di beberapa desa di Jawa Tengah. Program ini tidak hanya menyediakan layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak, tetapi juga mengintegrasikan edukasi terkait gizi seimbang, pola asuh yang sehat, dan deteksi dini gangguan

tumbuh kembang pada anak. Keberhasilan program ini didukung oleh keterlibatan aktif kader kesehatan desa yang dilatih secara khusus untuk memberikan layanan berbasis komunitas. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan distribusi makanan tambahan bergizi turut meningkatkan efektivitas program.

Di sektor ekonomi, program pemberdayaan berbasis pertanian berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur telah dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan teknik pertanian modern seperti sistem tanam tumpangsari, pemanfaatan pupuk organik, serta penerapan teknologi irigasi sederhana guna mengatasi tantangan kekeringan. Selain itu, program ini juga melibatkan koperasi petani dalam distribusi hasil panen dan pemasaran produk lokal, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, serta organisasi non-pemerintah yang menyediakan bantuan teknis dan permodalan.

Namun, implementasi program di daerah pedesaan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan yang buruk dan minimnya sarana transportasi, sering kali menghambat distribusi bantuan dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, rendahnya tingkat literasi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program yang dijalankan juga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya lokal dan pelibatan tokoh masyarakat sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan strategi yang tepat, program komunitas di daerah pedesaan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup secara berkelanjutan.

3. Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan Lembaga Donor

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dan lembaga donor memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung implementasi program komunitas di berbagai daerah. Mereka berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk penyediaan dana, sumber daya teknis, pelatihan tenaga kerja, serta advokasi kebijakan guna memastikan program yang dijalankan dapat memberikan dampak jangka panjang.

Salah satu contoh nyata keterlibatan NGO adalah program pencegahan stunting yang dijalankan oleh UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Program ini mencakup penyuluhan bagi ibu hamil dan ibu menyusui mengenai pola makan yang sehat, distribusi makanan tambahan

bergizi bagi anak-anak, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan penyediaan alat kesehatan yang memadai. Selain itu, UNICEF juga mengembangkan program berbasis teknologi yang memungkinkan tenaga kesehatan dan kader Posyandu memantau status gizi anak secara digital.

Selain UNICEF, organisasi seperti Save the Children telah menjalankan program pendidikan anak usia dini di berbagai daerah terpencil di Indonesia. Program ini berfokus pada pelatihan guru, penyediaan bahan ajar berkualitas, serta peningkatan infrastruktur sekolah guna memastikan anak-anak di daerah tertinggal mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendekatan berbasis komunitas yang digunakan oleh Save the Children juga melibatkan orang tua dan masyarakat lokal dalam mendukung proses pendidikan anak-anak.

Lembaga donor internasional seperti The World Bank dan USAID juga memainkan peran besar dalam mendanai berbagai proyek pembangunan komunitas. Salah satu inisiatif yang didukung oleh USAID adalah program kesehatan ibu dan anak yang mencakup peningkatan layanan kesehatan di puskesmas, penyuluhan tentang kebersihan sanitasi, serta pengadaan air bersih di daerah dengan akses terbatas terhadap sumber air bersih.

Meskipun keterlibatan NGO dan lembaga donor memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan program setelah pendanaan eksternal berakhir. Banyak program yang bergantung pada dana donor tanpa memiliki rencana jangka panjang untuk beroperasi secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan program komunitas dengan kebijakan lokal serta membangun kapasitas masyarakat agar dapat mengelola dan melanjutkan program secara independen.

Tantangan lainnya adalah koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menghindari duplikasi program serta memastikan efektivitas pelaksanaan. Dalam beberapa kasus, terdapat program yang tumpang tindih karena kurangnya komunikasi antara NGO, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik serta transparansi dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, keterlibatan NGO dan lembaga donor sangat membantu dalam mempercepat pembangunan komunitas, namun harus diiringi dengan strategi keberlanjutan dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan agar manfaat yang dihasilkan dapat bertahan dalam jangka panjang.

4. Evaluasi Keberhasilan Program dan Tantangan yang Dihadapi

Evaluasi keberhasilan program komunitas sangat penting untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutannya. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei dampak, wawancara dengan penerima manfaat, observasi langsung, serta analisis data sekunder seperti statistik kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan serta hambatan yang dihadapi selama implementasi program.

Keberhasilan program komunitas dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain:

- **Peningkatan kualitas hidup**, seperti akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih.
- **Penurunan angka stunting** dan perbaikan status gizi anak-anak di daerah sasaran.
- **Peningkatan pendapatan masyarakat** melalui program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan.
- **Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat**, yang mencerminkan keberlanjutan program secara jangka panjang.
- **Efektivitas penggunaan dana dan sumber daya**, untuk memastikan bahwa investasi dalam program memberikan hasil yang optimal.

Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan sering muncul yang dapat menghambat efektivitas program. Beberapa tantangan utama meliputi:

- a) **Keterbatasan Anggaran**: Banyak program komunitas bergantung pada pendanaan dari pemerintah atau lembaga donor, sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam memastikan keberlanjutan setelah sumber dana berakhir.
- b) **Resistensi Sosial dan Budaya**: Dalam beberapa kasus, masyarakat memiliki kebiasaan atau norma yang sulit diubah, seperti pola asuh anak yang kurang memperhatikan gizi seimbang atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.
- c) **Kurangnya Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan**: Program yang melibatkan berbagai pihak sering kali menghadapi tantangan dalam koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, NGO, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
- d) **Kendala Infrastruktur**: Di daerah pedesaan, keterbatasan akses terhadap jalan, listrik, dan internet dapat menghambat pelaksanaan program, terutama dalam hal distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

- e) **Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi:** Meskipun pelatihan dan bantuan modal telah diberikan, masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar, menghadapi persaingan bisnis, serta mengelola usaha secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk:

- a) **Pendekatan berbasis komunitas**, yang mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
- b) **Diversifikasi sumber pendanaan**, agar program tidak bergantung pada satu sumber dana saja.
- c) **Peningkatan kapasitas SDM lokal**, melalui pelatihan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola program secara mandiri.
- d) **Sinergi antar-sektor**, dengan memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah, NGO, akademisi, dan sektor swasta.
- e) **Adaptasi program berdasarkan kebutuhan spesifik daerah**, sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, evaluasi program komunitas dapat membantu meningkatkan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

F. Keberlanjutan dan Pengembangan Program Komunitas

1. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

membahas cara-cara agar masyarakat lebih terlibat dalam program komunitas. Ini penting karena tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program yang dirancang bisa saja tidak berkelanjutan atau kurang efektif.

- a) **Pendekatan Berbasis Kebutuhan Lokal**

Program harus sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Jika program tidak relevan dengan kehidupan mereka, mereka cenderung tidak tertarik. Contohnya, di daerah dengan masalah gizi, program edukasi stunting harus menyesuaikan dengan budaya dan pola makan masyarakat setempat.

- b) **Pemberdayaan Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat seperti pemuka agama, kepala desa, atau tokoh adat memiliki pengaruh besar terhadap warga. Jika mereka mendukung program, kemungkinan besar masyarakat juga akan ikut berpartisipasi.

- c) **Kampanye dan Edukasi Berkelanjutan**

Edukasi yang dilakukan secara berkala akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, atau penyuluhan langsung.

d) **Pemberian Insentif dan Pengakuan**

Insentif bisa dalam bentuk sertifikat, penghargaan, atau bantuan bagi mereka yang aktif berpartisipasi. Pengakuan sosial juga bisa memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam program.

e) **Mekanisme Partisipatif dalam Pengambilan Keputusan**

Jika masyarakat diberi kesempatan untuk ikut dalam perencanaan dan evaluasi program, mereka akan merasa lebih memiliki program tersebut, sehingga partisipasi akan meningkat.

2. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan bagi Anggota Komunitas

membahas cara-cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota komunitas agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.

a) **Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan**

Anggota komunitas perlu memiliki kemampuan mengelola program agar tidak bergantung pada pihak luar. Pelatihan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, serta pengelolaan sumber daya komunitas.

b) **Pelatihan Keterampilan Teknis**

Keterampilan praktis seperti pertanian berkelanjutan, wirausaha, atau layanan kesehatan dasar sangat diperlukan agar komunitas dapat berkembang. Contohnya, ibu-ibu di komunitas bisa mendapatkan pelatihan tentang pemenuhan gizi balita untuk mengatasi stunting.

c) **Mentorship dan Pendampingan**

Tidak cukup hanya dengan pelatihan satu kali, perlu ada mentor yang bisa membimbing komunitas secara berkelanjutan. Mentor bisa berasal dari akademisi, tenaga kesehatan, atau wirausahawan yang sudah berpengalaman.

d) **Penyediaan Modul dan Materi Pelatihan Berbasis Teknologi**

Agar pelatihan lebih fleksibel, teknologi dapat dimanfaatkan. Contohnya, pembuatan video edukasi, aplikasi seluler, atau kursus daring untuk memperluas jangkauan pelatihan.

e) **Evaluasi dan Pembaruan Pelatihan**

Pelatihan harus dievaluasi secara berkala agar tetap relevan. Misalnya, jika kebutuhan masyarakat berubah, maka kurikulum pelatihan juga harus disesuaikan.

3. Sinergi antara Komunitas, Pemerintah, dan Sektor Swasta

menjelaskan bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat keberlanjutan program komunitas. Setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, namun jika bekerja sama, dampaknya bisa lebih besar dan berkelanjutan.

a) Kemitraan dengan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kebijakan, regulasi, serta pendanaan. Dukungan infrastruktur juga dapat mempercepat keberhasilan program, misalnya penyediaan pusat kesehatan atau sarana edukasi.

b) Keterlibatan Sektor Swasta

Perusahaan dapat membantu komunitas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Bantuan ini bisa berupa dana, teknologi, atau pelatihan bagi masyarakat agar lebih mandiri.

c) Jaringan dan Kolaborasi Antar-Komunitas

Komunitas yang saling bekerja sama bisa berbagi sumber daya, pengalaman, dan praktik terbaik. Ini dapat meningkatkan efektivitas program dan memperluas dampaknya.

d) Pembangunan Model Bisnis Sosial

Komunitas bisa diarahkan untuk membangun kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, seperti koperasi atau usaha sosial. Ini membantu mereka memperoleh pendapatan mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.

e) Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Keberlanjutan

Fasilitas yang memadai seperti pusat komunitas, klinik, atau sistem air bersih sangat penting untuk mendukung program yang berjalan. Pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi dalam membangun infrastruktur ini.

4. Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Peran Komunitas dalam Penanggulangan Stunting

membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan komunitas memiliki peran yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi stunting. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing rekomendasi:

a) Integrasi Program dalam Kebijakan Nasional dan Daerah

Agar program komunitas memiliki dampak jangka panjang, harus ada integrasi dengan kebijakan yang lebih luas. Pemerintah pusat dan daerah harus

memasukkan program-program komunitas dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Misalnya:

- Menjadikan program edukasi gizi di komunitas sebagai bagian dari strategi nasional penanggulangan stunting.
- Memasukkan peran komunitas dalam kebijakan kesehatan ibu dan anak di tingkat daerah.
- Mewajibkan koordinasi antara dinas kesehatan dan komunitas dalam pelaksanaan intervensi gizi.

b) Penyediaan Dana Berkelanjutan

Banyak program komunitas gagal berkembang karena ketergantungan pada donasi atau hibah sementara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pendanaan yang lebih stabil, seperti:

- Alokasi dana desa atau dana daerah untuk program kesehatan berbasis komunitas.
- Pembuatan skema pembiayaan jangka panjang melalui kemitraan dengan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Mendorong inisiatif ekonomi lokal, seperti koperasi atau usaha sosial yang keuntungannya dialokasikan untuk program kesehatan anak dan ibu.

c) Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Keberhasilan program komunitas bergantung pada pengakuan dan dukungan formal dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang memperkuat posisi komunitas dalam sistem kesehatan, misalnya:

- Pengakuan resmi kader kesehatan atau relawan komunitas dalam struktur pelayanan kesehatan nasional.
- Penyediaan pelatihan dan sertifikasi bagi kader kesehatan agar mereka dapat berkontribusi lebih efektif.
- Regulasi yang mempermudah akses komunitas terhadap fasilitas kesehatan dan bantuan dari pemerintah.

d) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Program yang efektif harus memiliki sistem evaluasi yang jelas dan berbasis bukti. Beberapa langkah yang bisa diterapkan adalah:

- Penggunaan teknologi digital untuk mengumpulkan data pertumbuhan anak dan pola konsumsi keluarga.
- Melibatkan akademisi dan lembaga riset dalam melakukan evaluasi dampak program komunitas.

- Membuat kebijakan yang mengharuskan evaluasi program setiap tahun dengan indikator yang terukur.

e) Kolaborasi Multi-Pihak

Penanggulangan stunting membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari komunitas, akademisi, hingga sektor swasta. Beberapa bentuk kolaborasi yang bisa diterapkan adalah:

- Kemitraan dengan universitas untuk melakukan riset dan pelatihan kader kesehatan.
- Mendorong perusahaan untuk terlibat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
- Membentuk forum kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi inovatif dalam pencegahan stunting.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ringkasan Temuan dan Pelajaran dari Berbagai Program Komunitas

Berdasarkan kajian dan implementasi berbagai program komunitas yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran sentral dalam keberhasilan program. Beberapa temuan utama yang dapat diidentifikasi meliputi:

a) Peran Aktif Komunitas:

Keberhasilan program komunitas sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Program yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi cenderung lebih berkelanjutan.

b) Pentingnya Pendekatan Berbasis Kebutuhan Lokal

Program yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat lebih mudah diterima dan diadopsi oleh masyarakat.

c) Kolaborasi Multi-Pihak:

Sinergi antara komunitas, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah (NGO) sangat membantu dalam memberikan dukungan sumber daya dan keberlanjutan program.

d) Pendidikan dan Kesadaran sebagai Kunci Perubahan:

Program edukasi yang berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah membantu masyarakat memahami pentingnya pencegahan stunting dan gizi seimbang.

e) Tantangan dalam Implementasi:

Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan dana, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi antar-stakeholder, serta kesulitan dalam mengukur dampak program secara jangka panjang.

Dari berbagai pengalaman tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa pendekatan berbasis komunitas yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada pemberdayaan adalah strategi terbaik untuk memastikan keberlanjutan program.

2. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesadaran Stunting melalui Komunitas

Untuk meningkatkan kesadaran tentang stunting dan pencegahannya melalui komunitas, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi:

a) Penguatan Kampanye Informasi dan Edukasi

- ✓ Menggunakan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi mengenai stunting.
- ✓ Mengembangkan materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan budaya lokal.

b) Pemberdayaan Tokoh Masyarakat

- ✓ Melibatkan pemuka agama, kepala desa, dan kader kesehatan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat.
- ✓ Meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan berbasis bukti ilmiah.

c) Pendekatan Berbasis Keluarga dan Sekolah

- ✓ Mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini.
- ✓ Memberikan penyuluhan langsung kepada ibu hamil dan ibu dengan balita tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan anak.

d) Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan dan Gizi

- ✓ Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk penyediaan posyandu yang lebih aktif dan inovatif.
- ✓ Meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi melalui program ketahanan pangan berbasis komunitas.

e) Pemanfaatan Teknologi dan Data dalam Pemantauan Stunting

- ✓ Menggunakan sistem digital untuk memantau perkembangan gizi anak secara lebih akurat.
- ✓ Mengembangkan aplikasi atau platform daring untuk memberikan informasi interaktif mengenai pencegahan stunting.

3. Saran untuk Penelitian dan Implementasi Selanjutnya

Untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan efektivitas program komunitas dalam pencegahan stunting, beberapa arah penelitian dan implementasi selanjutnya yang disarankan meliputi:

a) Studi Efektivitas Model Intervensi Berbasis Komunitas

- ✓ Meneliti model intervensi yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pencegahan stunting.

- ✓ Membandingkan efektivitas berbagai strategi edukasi dan intervensi berbasis komunitas.

b) Evaluasi Dampak Jangka Panjang Program Komunitas

- ✓ Mengembangkan metode evaluasi berbasis data yang memungkinkan pemantauan dampak program dalam jangka panjang.
- ✓ Melakukan studi longitudinal untuk melihat efek intervensi komunitas terhadap status gizi anak.

c) Inovasi dalam Strategi Pemberdayaan Komunitas

- ✓ Mengeksplorasi penggunaan teknologi digital dalam memperkuat keterlibatan komunitas dalam pencegahan stunting.
- ✓ Mengembangkan model bisnis sosial yang dapat mendukung keberlanjutan program komunitas.

d) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Peran Komunitas

- ✓ Menganalisis kebijakan yang dapat meningkatkan dukungan terhadap program berbasis komunitas.
- ✓ Mendorong regulasi yang memungkinkan komunitas memperoleh sumber daya yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan program komunitas dalam pencegahan stunting dapat semakin efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang nyata bagi kesehatan masyarakat.

H. Penutup

Program komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan lokal, kolaborasi multi-pihak, serta dukungan regulasi yang memadai, komunitas dapat menjadi ujung tombak dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Kesadaran masyarakat yang lebih tinggi mengenai stunting, ditunjang dengan akses terhadap edukasi dan layanan kesehatan yang lebih baik, akan membantu menurunkan angka stunting secara signifikan.

Penelitian dan inovasi dalam pengembangan program komunitas harus terus dilakukan agar strategi yang diterapkan selalu relevan dan berbasis bukti. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat sendiri, diharapkan upaya pencegahan stunting dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Referensi

- Alderman, H., Hoddinott, J., & Kinsey, B. (2006). Long-term consequences of early childhood malnutrition. *Oxford Economic Papers*, 58(3), 450–474. <https://doi.org/10.1093/oep/gpl008>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Laporan status gizi balita di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2011). Long-term consequences of stunting in early life. *Maternal & Child Nutrition*, 7(S3), 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8709.2011.00375.x>
- Food and Agriculture Organization. (2022). Food security and nutrition report. Rome: FAO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pencegahan dan penanggulangan stunting. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Leroy, J. L., Ruel, M., Habicht, J. P., & Frongillo, E. A. (2014). The impact of stunting on early childhood development. *The Lancet Global Health*, 2(9), e463–e471. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(14\)70280-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70280-3)
- Martorell, R. (1995). Results and implications of the INCAP follow-up study. *Journal of Nutrition*, 125(6), 1127–1138. https://doi.org/10.1093/jn/125.suppl_6.1127S
- Mendez, M. A., & Adair, L. S. (1999). Severity and timing of stunting in the first two years of life affect performance on cognitive tests in late childhood. *Journal of Nutrition*, 129(8), 1555–1562. <https://doi.org/10.1093/jn/129.8.1555>
- Ministry of Health Malaysia. (2016). National Plan of Action for Nutrition of Malaysia III 2016–2025. Kuala Lumpur: MOH.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250–265. <https://doi.org/10.1179/2046905514Y.00000000158>
- Sunardi, T., & Wijayanti, R. (2019). Peran Posyandu dalam pencegahan stunting di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 112–125.

Suparman, A. (2021). Gizi dan pertumbuhan anak: Faktor penyebab dan solusi. Bandung: Pustaka Medika.

Tiwari, R., Ausman, L. M., & Agho, K. E. (2014). Impact of early childhood stunting on cognitive and schooling outcomes: A systematic review. *BMC Public Health*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1>

UNICEF Indonesia. (2020). The state of nutrition in Indonesia. Jakarta: UNICEF.

UNICEF. (2013). Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress. New York: UNICEF.

Victora, C. G., Adair, L., Fall, C., et al. (2008). Maternal and child undernutrition: Consequences for adult health and human capital. *The Lancet*, 371(9609), 340–357. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61692-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61692-4)

World Bank. (2018). Accelerating progress against malnutrition in Indonesia. Washington, DC: World Bank.

World Health Organization, & UNICEF. (2019). Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2021). Guidelines on stunting prevention. Geneva: WHO.

Glosarium

A

Anemia: Kondisi kurangnya sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan, sering terjadi pada ibu hamil dan berkontribusi terhadap risiko stunting pada anak.

Asam folat: Vitamin B yang penting untuk perkembangan janin, terutama dalam mencegah cacat lahir dan mendukung pertumbuhan anak.

ASI Eksklusif: Pemberian hanya Air Susu Ibu (ASI) tanpa makanan atau minuman tambahan lainnya kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan.

B

Balita: Anak berusia di bawah lima tahun, yang merupakan kelompok rentan terhadap masalah gizi, termasuk stunting.

Bidan: Tenaga kesehatan profesional yang membantu proses kehamilan, persalinan, dan perawatan ibu serta bayi.

BMI (Body Mass Index): Indeks yang digunakan untuk mengukur status gizi seseorang berdasarkan berat dan tinggi badan.

C

Cacingan: Infeksi parasit usus yang dapat menghambat penyerapan nutrisi dan menyebabkan masalah pertumbuhan pada anak.

Cakupan Imunisasi: Persentase populasi yang telah menerima vaksinasi dasar untuk mencegah penyakit menular yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak.

Cairan Elektrolit: Larutan yang mengandung ion mineral penting bagi tubuh, seperti natrium dan kalium, yang berperan dalam keseimbangan cairan dan metabolisme tubuh.

D

Diare Kronis: Penyakit yang ditandai dengan buang air besar cair secara berkepanjangan, dapat menyebabkan dehidrasi dan malnutrisi yang berkontribusi terhadap stunting.

Defisiensi Mikronutrien: Kekurangan vitamin dan mineral penting yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Deteksi Dini Stunting: Proses identifikasi anak dengan risiko stunting melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala.

E

Edukasi Gizi: Proses memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pola makan sehat untuk mencegah stunting.

Epidemiologi Stunting: Studi tentang penyebaran dan faktor-faktor risiko stunting dalam populasi.

Eksklusi Sosial: Kondisi di mana kelompok tertentu, seperti keluarga miskin, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan gizi yang layak.

F

Faktor Risiko Stunting: Berbagai aspek yang berkontribusi terhadap kejadian stunting, seperti pola makan yang buruk, sanitasi yang buruk, dan infeksi berulang.

Folat: Vitamin B yang berperan penting dalam perkembangan sel dan produksi sel darah merah.

Fortifikasi Makanan: Proses penambahan nutrisi tertentu ke dalam makanan untuk meningkatkan kandungan gizinya.

G

Gizi Buruk: Kondisi kekurangan atau kelebihan zat gizi yang menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk stunting.

Gizi Seimbang: Pola makan yang mengandung nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Gerakan Nasional Pencegahan Stunting: Program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia melalui intervensi gizi dan kesehatan masyarakat.

H

Hemoglobin: Protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh, rendahnya kadar hemoglobin dapat menyebabkan anemia.

Hipoalbuminemia: Kondisi kadar albumin rendah dalam darah yang dapat menyebabkan edema dan masalah pertumbuhan.

Hipoglikemia: Kondisi kadar gula darah rendah yang dapat berdampak buruk pada perkembangan otak anak.

I

Imunisasi Dasar: Serangkaian vaksinasi yang diberikan kepada bayi dan anak untuk mencegah penyakit yang dapat memengaruhi pertumbuhan mereka.

Infeksi Kronis: Penyakit infeksi berulang yang menghambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko stunting.

Iodium: Mineral esensial yang dibutuhkan untuk perkembangan otak dan mencegah gangguan tumbuh kembang.

J

Jamban Sehat: Fasilitas sanitasi yang layak untuk mencegah penyebaran penyakit yang berkontribusi terhadap stunting.

Jaringan Posyandu: Sistem pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang memberikan layanan pemantauan pertumbuhan anak dan edukasi kesehatan.

Jendela 1000 HPK: Periode emas pertumbuhan anak dari kehamilan hingga usia dua tahun yang sangat menentukan status gizi dan kesehatan masa depan.

K

Kalsium: Mineral penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi, kekurangan kalsium dapat menghambat pertumbuhan anak.

Karbohidrat Kompleks: Sumber energi utama dalam makanan yang penting untuk pertumbuhan optimal.

Keamanan Pangan: Kondisi makanan yang bebas dari kontaminasi dan memiliki kandungan gizi yang cukup.

L

Laktasi: Proses produksi dan pengeluaran ASI oleh ibu menyusui.

Lansia Sehat: Konsep penuaan dengan kondisi kesehatan optimal sebagai hasil dari pola makan dan gaya hidup sehat sejak kecil.

Lingkungan Sehat: Faktor yang mendukung pertumbuhan anak yang optimal, termasuk akses ke air bersih dan sanitasi yang baik.

M

Malnutrisi: Kondisi kekurangan atau kelebihan nutrisi yang berdampak buruk pada kesehatan.

Makanan Tambahan: Asupan gizi tambahan yang diberikan kepada bayi dan balita untuk memastikan kecukupan gizi mereka.

Monitoring Gizi: Pengukuran rutin status gizi anak untuk mendeteksi masalah pertumbuhan.

N

Nutrisi Esensial: Zat gizi yang diperlukan tubuh tetapi tidak dapat diproduksi sendiri, seperti vitamin dan mineral.

Neonatus: Bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizinya.

Nilai Gizi Harian: Kebutuhan rata-rata gizi yang harus dipenuhi setiap hari untuk mendukung pertumbuhan optimal.

O

Obesitas Anak: Kondisi kelebihan berat badan yang juga dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan.

Osteoporosis: Penyakit akibat kekurangan kalsium yang dapat dicegah sejak dini dengan asupan gizi seimbang.

Otak Optimal: Perkembangan otak yang maksimal sebagai hasil dari pola makan sehat dan stimulasi yang baik.

P

Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu, pusat pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di tingkat komunitas.

Protein Hewani: Sumber protein berkualitas tinggi seperti daging, ikan, dan telur yang penting untuk pertumbuhan anak.

Pola Asuh Gizi: Cara orang tua dalam memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada anak.

Q

Quality Control Pangan: Pengawasan mutu makanan untuk memastikan kandungan gizinya sesuai dengan standar kesehatan.

R

Rehabilitasi Gizi: Proses pemulihan anak dengan gizi buruk melalui intervensi medis dan nutrisi.

Resistensi Insulin: Kondisi tubuh yang tidak dapat merespons insulin dengan baik, sering kali terkait dengan pola makan yang buruk sejak kecil.

S

Sanitasi Lingkungan: Upaya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan stunting.

Sumber Gizi Makro dan Mikro: Klasifikasi nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar (karbohidrat, protein, lemak) dan kecil (vitamin, mineral).

T-Z

Tekanan Darah Rendah: Kondisi yang bisa disebabkan oleh kekurangan gizi dan dapat memengaruhi perkembangan anak.

Tumbuh Kembang Anak: Proses pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak yang dipengaruhi oleh asupan gizi dan lingkungan.

Zat Besi: Mineral penting yang membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia.

Profil Penulis



Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb. Lahir di Tangerang, 28 September 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran lulus tahun 2006. Pendidikan S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran lulus tahun pada tahun 2013. Profesi Bidan STIKes Salsabila Serang lulus tahun 2024. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen di Universitas Faletahan pada prodi D3 Kebidanan. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan

Kehamilan, Konsep Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, serta Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi dan Balita. Penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis aktif dalam organisasi IBI Kabupaten Serang dan AIPKIND Korwil Banten, Owner Mom's, Kid's and Baby Spa Fadheela. Penulis dapat dihubungi melalui email: eha.fathiyah@gmail.com

Motto: "Mencari ilmu dulu, kemudian amalkan, jangan beramal tanpa ilmu "



Desi Rofita, S.ST., M.Keb. lahir di Bima, 02 Oktober 1992. Penulis merupakan seorang dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram lulus tahun 2014, D-IV Bidan Pendidik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2017, pendidikan S-2 Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2020. Penulis tergabung dalam

organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014-2016 bekerja sebagai bidan di salah satu puskesmas Kota Bima Nusa Tenggara Barat, tahun 2018-2020 bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fajar Yogyakarta, tahun 2020-2021 bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram, dan tahun 2021-sekarang sebagai dosen (ASN) di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Penulis aktif dalam berbagai

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan seminar ilmiah.



Nurulicha, S.ST., M.Keb Penulis lahir di Indramayu, Tanggal 26 Februari 1984. Menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Cirebon tahun 2005, D IV Kebidanan Universitas Padjadajaran tahun 2007 dan S2 Kebidanan Universitas 'Padjadajaran Bandung tahun 2014. Penulis saat ini aktif sebagai seorang dosen serta sebagai Sekretaris Prodi Profesi Bidan sejak tahun 2022 dan tahun 2024 – sekarang penulis menjabat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI) di STIKes Mitra RIA Husada

Jakarta, penulis mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Komplementer, Askeb Neonatus bayi dan balita dan pra sekolah, Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal, sebagai pembimbing dan penguji institusi praktik klinik kebidanan profesi. Selain mengajar juga membimbing Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan. Aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, tim dosen bimbel Optimal dan pernah sebagai narasumber pada pelatihan OSCE Bidan di Lembaga ACT.

Pengalaman penulis dalam membuat buku Evidence Based Soal Kasus Kebidanan Komunitas, buku Latihan soal UKOM kebidanan, buku bunga rampai landasan ilmiah praktik kebidanan, buku ajar dan penyusunan SOP yang ber ISBN dan HKI, penulis dapat dihubungi melalui email: nnurulicha26@gmail.com



Novi Puspita Sari S.Gz., M.Kes Penulis di lahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 11 November 1993. Ketertarikan penulis terhadap ilmu Gizi dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Hasanuddin dengan memilih Jurusan Ilmu Gizi dan berhasil lulus pada tahun 2015. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di

Program Studi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nani Hasanuddin. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: novipuspitasari@stikesnh.ac.id



Ns. Made Rismawan, S.Kep., MNS. Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Keperawatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali sejak 1 September 2002. Lahir di Denpasar, 20 Januari 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Kasetsart University Thailand. Saat ini penulis menjadi dosen pengampu Mata Kuliah Keperawatan Anak dengan interest area penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup upaya pencegahan dan deteksi dini stunting. Selain itu penulis juga tengah menempuh Pendidikan S3 di Program Doktorat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sejak Tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui email maderismawan@gmail.com. Pesan penulis untuk pembaca: **Let's do the best and let the God do the rest (Selalu Berdoa dan Tetap Semangat).**



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep

(<https://orcid.org/0000-0001-9758-6359>) adalah seorang Dosen Keperawatan di Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners serta Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga, Surabaya. Selanjutnya, beliau meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Keperawatan dari Fakultas

Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia.

Bidang penelitian yang beliau tekuni meliputi konsep caring serta aspek budaya dalam perawatan pasien, baik perawatan pasien dengan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Beliau juga aktif menulis dan mempublikasikan berbagai hasil penelitiannya di jurnal ilmiah nasional dan internasional. Dedikasi beliau dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya dalam pendekatan caring berbasis budaya, menjadi kontribusi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Selain berperan sebagai dosen, beliau juga aktif dalam organisasi profesi. Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Nusa Tenggara Timur selama dua periode, yaitu Periode I (2015-2021) dan Periode II (2022-2027). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI untuk periode 2021-2026, serta menjadi Anggota Kolegium Keperawatan Indonesia

Sinopsis

Buku referensi "**Pentingnya Pencegahan Stunting pada Anak**" menyajikan kajian komprehensif mengenai stunting, suatu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Buku ini diawali dengan pemahaman tentang definisi, penyebab, dan dampak luas stunting yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial-ekonomi, yang dapat mempengaruhi masa depan anak serta generasi berikutnya.

Bab pertama menyoroti peran penting bidan dalam mendeteksi dan mencegah stunting sejak masa kehamilan. Pembaca akan memperoleh wawasan tentang bagaimana pemantauan gizi ibu hamil, edukasi mengenai ASI eksklusif, serta pengelolaan komplikasi kehamilan dapat secara signifikan mengurangi risiko stunting pada anak.

Bab berikutnya membahas pengaruh pola asuh keluarga terhadap pertumbuhan anak. Dijelaskan berbagai pola asuh seperti otoriter, demokratis, permisif, dan tidak terlibat, serta dampaknya terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Bab ini juga menawarkan strategi praktis bagi keluarga dalam menerapkan pola asuh yang positif untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

Selanjutnya, intervensi nutrisi sebagai metode pencegahan stunting menjadi fokus utama dalam buku ini. Penjelasan mendalam mengenai kebutuhan nutrisi esensial pada periode kritis pertumbuhan anak, rekomendasi makanan kaya protein hewani, serta pentingnya intervensi gizi sensitif dan spesifik, turut disajikan secara rinci untuk membantu pembaca memahami cara praktis mengatasi tantangan gizi pada anak balita.

Bab terakhir memaparkan tentang strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran tentang stunting. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, peran komunitas dalam mendukung upaya edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta keterlibatan aktif berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan stunting. Buku ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul..

Buku referensi "Pentingnya Pencegahan Stunting pada Anak" menyajikan kajian komprehensif mengenai stunting, suatu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Buku ini diawali dengan pemahaman tentang definisi, penyebab, dan dampak luas stunting yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan sosial-ekonomi, yang dapat mempengaruhi masa depan anak serta generasi berikutnya.

Bab pertama menyoroti peran penting bidan dalam mendeteksi dan mencegah stunting sejak masa kehamilan. Pembaca akan memperoleh wawasan tentang bagaimana pemantauan gizi ibu hamil, edukasi mengenai ASI eksklusif, serta pengelolaan komplikasi kehamilan dapat secara signifikan mengurangi risiko stunting pada anak.

Bab berikutnya membahas pengaruh pola asuh keluarga terhadap pertumbuhan anak. Dijelaskan berbagai pola asuh seperti otoriter, demokratis, permisif, dan tidak terlibat, serta dampaknya terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Bab ini juga menawarkan strategi praktis bagi keluarga dalam menerapkan pola asuh yang positif untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

Selanjutnya, intervensi nutrisi sebagai metode pencegahan stunting menjadi fokus utama dalam buku ini. Penjelasan mendalam mengenai kebutuhan nutrisi esensial pada periode kritis pertumbuhan anak, rekomendasi makanan kaya protein hewani, serta pentingnya intervensi gizi sensitif dan spesifik, turut disajikan secara rinci untuk membantu pembaca memahami cara praktis mengatasi tantangan gizi pada anak balita.

Bab terakhir memaparkan tentang strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran tentang stunting. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, peran komunitas dalam mendukung upaya edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta keterlibatan aktif berbagai pihak diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencegahan stunting. Buku ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi antar sektor untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-10-9348-6



9

786231

093486